Preguntas EUNACOM · Pediatría

Contenido

Cardiología (20) 1
Respiratorio y otorrinolaringología (22) 10
Digestivo y hepatología (31) 21
Nefrología y urología (21) 34
Endocrinología y diabetes (41) 43
Crecimiento, talla y desarrollo psicomotor (20) 59
Nutrición y alimentación (27) 67
Hematología y oncología (17) 79
Infectología y vacunas (23) 87
Inmunología y reumatología (16) 98
Neurología (34) 105
Psiquiatría infantil y maltrato (16) 120
Traumatología y ortopedia (28) 126
Intoxicaciones y misceláneos (5) 137

Cardiología (20)

1. Las siguientes condiciones pueden desencadenar una arritmia maligna en un niño portador de síndrome del QT largo, EXCEPTO:

a. Hipocalcemia
b. Bradicardia
c. Hipokalemia
d. Hiponatremia
e. Hipomagnesemia

Respuesta correcta: d. Hiponatremia

Explicación: Las alteraciones del sodio, por regla general, tiene bajo impacto a nivel cardíaco. Por otro lado, la hipokalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia y bradicardia, todas ellas, alargan el intervalo QT y pueden desencadenar torsión de puntas y otras arritmias ventriculares.

Fuente: Cardiología pediátrica P1

2. Un niño de 3 meses presenta un soplo sistólico eyectivo III/VI, asociado a un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Usted debe sospechar:

a. Comunicación interventricular
b. Comunicación interauricular
c. Ductus arterioso persistente
d. Coartación aórtica
e. Transposición de grandes vasos

Respuesta correcta: b. Comunicación interauricular

Explicación: Es una CIA clásica. Revisar el resumen de semiología cardíaca.

Fuente: Cardiología pediátrica P2

3. Adolescente de 14 años inicia dolor torácico retroesternal de intensidad 7/10, que aumenta con la inspiración. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal y electrocardiograma que demuestra elevación del segmento ST en todas las derivaciones precordiales. El diagnóstico más probable es:

a. Disección aórtica
b. Endocarditis bacteriana aguda
c. Taponamiento pericárdico
d. Pericarditis aguda
e. Infarto agudo al miocardio

Respuesta correcta: d. Pericarditis aguda

Explicación: Es una pericarditis clásica. Se trata con AINEs. Se debe solicitar una ecocardiografía para ver el grado de derrame. También se solicitan CK o troponinas para ver si tiene miocarditis concomitante.

Es una pericarditis clásica. Revisar el resumen de semiología cardíaca.

Fuente: Cardiología pediátrica P3 · Cuestionario 3.1 P15

4. El ductus arterioso persistente se manifiesta semiológicamente como:

a. Chasquido de apertura, asociado a aumento del segundo ruido
b. Click de apertura, asociado a disminución del segundo ruido
c. Chasquido de apertura, asociado a soplo sistólico
d. Soplo con componente sistólico y diastólico
e. Soplo sistólico, asociado a desdoblamiento paradojal del segundo ruido

Respuesta correcta: d. Soplo con componente sistólico y diastólico

Explicación: Revisar resumen de semiología cardiológica.

Fuente: Cardiología pediátrica P4

5. La cardiopatía congénita más frecuente es:

a. Comunicación interventricular
b. Comunicación interauricular
c. Ductus arterioso persistente
d. Canal auriculoventricular
e. Drenaje anómalo de venas pulmonares

Respuesta correcta: a. Comunicación interventricular

Explicación: La CIV es la más frecuente, seguida de la CIA tipo ostium secundum. Dentro de las cianóticas, la más frecuente es la tetralogía de Fallot.

Fuente: Cardiología pediátrica P5

6. Un adolescente de 14 años, con antecedente de enfermedad de Kawasaki en su infancia, inicia dolor precordial opresivo, irradiado a cuello y hombro izquierdo, asociado a disnea. Al examen físico se aprecia pálido, taquicárdico a 120x', con ritmo cardíaco regular en 3 tonos, por presencia de R4, sin soplos. El diagnóstico más probable es:

a. Miocarditis aguda
b. Miocardiopatía dilatada
c. Pericarditis
d. Flutter auricular
e. Infarto agudo al miocardio

Respuesta correcta: e. Infarto agudo al miocardio

Explicación: La importancia de diagnosticar la enfermedad de Kawasaki es precisamente que evoluciona con daño coronario, con riesgo de infartos en el mediano y largo plazo. En agudo también puede producir miocarditis y la muerte. Después de la pandemia Covid-19, se agregó el PIPMS (síndrome de inflamación multisistémica pediátrica), que puede presentarse de la misma manera que una enfermedad de Kawasaki, o bien como una miocarditis o como cuadro gastrointestinal y shock. El tratamiento de ambas es el mismo: soporte, inmunoglobulina G endovenosa y aspirina. Se debe solicitar un ecocardiograma en la enfermedad de Kawasaki para evaluar la presencia de aneurismas coronarias.

Fuente: Cardiología pediátrica P6

7. Un recién nacido de término, sin antecedentes obstétricos de importancia, presenta cianosis intensa y desaturación arterial marcada, desde el nacimiento, que no responde a oxígeno al 100%. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Intubar y ventilar con presión positiva
b. Derivar para resolución quirúrgica inmediata
c. Administrar prostaglandina E y realizar ecocardiografía a la brevedad
d. Administrar indometacina y realizar ecocardiografía a la brevedad
e. Administrar antibióticos endovenosos, surfactante endotraqueal y oxígeno al 100%

Respuesta correcta: c. Administrar prostaglandina E y realizar ecocardiografía a la brevedad

Explicación: Muchas de las cardiopatías congénitas cianóticas son ducto dependientes, es decir, requieren que el ductus arterioso se mantenga abierto para mantenerse con vida. Por tanto, ante todo niño con un cuadro clínico compatible, se debe administrar prostaglandina u otro medicamento para mantener abierto el ductus arterioso. Luego, se solicita urgentemente una ecocardiografía y se evalúa la posibilidad de una cirugía cardíaca. Actualmente el diagnóstico muchas veces se hace antes del parto, en las ecocardiografías obstétricas.

Fuente: Cardiología pediátrica P7

8. La primera causa de hipertensión arterial en los niños es:

a. Esencial
b. Renovascular
c. Insuficiencia renal
d. Coartación aórtica
e. Síndrome hemolítico urémico

Respuesta correcta: c. Insuficiencia renal

Explicación: En adultos el 90% de la HTA es esencial y el 10% es secundaria. En niños, las cifras se invierten, siendo la inmensa mayoría de tipo secundaria (enfermedad renal es la primera causa, seguida de la renovascular, aunque algunos pocos estudios ponen primero a la renovascular). En adolescentes, la HTA esencial vuelve a ser la más frecuente, en especial si son obesos y tienen antecedentes familiares de hipertensión.

Fuente: Cardiología pediátrica P8

9. Las cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, que son corregidas tardíamente, desarrollan característicamente:

a. Endocarditis bacteriana
b. Embolías cardíacas
c. Hipertensión pulmonar persistente
d. Hipertensión arterial
e. Fibrilación auricular

Respuesta correcta: c. Hipertensión pulmonar persistente

Explicación: Por el mismo cortocircuito de izquierda a derecha, se produce hipertensión pulmonar, sin embargo, aquella revierte al operar la cardiopatía. Sin embargo, si no se operan a tiempo, evolucionan a hipertensión pulmonar persistente, que no corrige con la cirugía y empeora drásticamente el pronóstico. Incluso, en algunos casos, puede cambiar el orden del flujo, pasando a un cortocircuito de derecha a izquierda, que se conoce como síndrome de Eisenmenger o enfermedad cianosante tardía.

Fuente: Cardiología pediátrica P9

10. Un niño de 3 años, cursando disentería aguda en tratamiento con cotrimoxazol, ingresa comprometido de conciencia, en malas condiciones generales. Al examen físico se encuentra mal perfundido, hipotenso y taquicárdico. Se monitoriza invasivamente con catéter de Swan-Ganz y línea arterial, demostrándose presión arterial baja, presión de enclavamiento pulmonar elevada y presión venosa central elevada. ¿Cuál es la causa más probable del shock?

a. Hipovolémico
b. Séptico
c. Cardiogénico
d. Neurogénico
e. Anafiláctico

Respuesta correcta: c. Cardiogénico

Explicación: La PCP (presión de capilar pulmonar) elevada es categórica de shock cardiogénico. La RVP (resistencia vascular periférica) baja es la característica fundamental de los shocks vasodilatadores (anafiláctico, séptico, medular). La PVC (presión venosa central) baja se puede ver tanto en el shock hipovolémico como en el vasodiltador, por lo que la diferencia exige que se mida la RVP o al menos que se vea si responde o no a volumen (el vasodilatador no responde).

Fuente: Cardiología pediátrica P10

11. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis?

a. Drenaje anómalo de las venas pulmonares
b. Comunicación interventricular
c. Ventrículo único
d. Ductus arterioso persistente
e. Coartación aórtica

Respuesta correcta: c. Ventrículo único

Explicación: Son cianóticas las cardiopatías congénita con cortocircuito de derecha a izquierda (tetraología de Fallot), las con mezcla total (ventrículo único, tronco arterioso, atresia tricuspídea) y las sin mezcla (trasposición de grandes vasos). En cambio, son acianóticas las con cortocircuito de izquierda a derecha (CIV, CIA, DAP).

Fuente: Cardiología pediátrica P11

12. La primera causa de insuficiencia cardíaca en la edad pediátrica es:

a. Canalopatías
b. Miocardiopatía hipertrófica
c. Miocardiopatía coronaria
d. Malformaciones cardíacas
e. Enfermedad coronaria

Respuesta correcta: d. Malformaciones cardíacas

Explicación: Las cardiopatías congénitas son, por lejos, la primera causa de falla cardíaca en niños.

Fuente: Cardiología pediátrica P12

13. Un niño con antecedente de ventrículo único operado, con cirugía de Fontan, con buena evolución, debe ser sometido a un procedimiento dental. A modo de prevenir la aparición de endocarditis infecciosa debe administrarse, como primera opción:

a. Clindamicina oral, luego del procedimiento
b. Amoxicilina oral, previo al procedimiento
c. Ampicilina y gentamicina, por vía endovenosa, previo al procedimiento
d. Ceftriaxona endovenosa, previo al procedimiento
e. Cefadroxilo oral, luego del procedimiento

Respuesta correcta: b. Amoxicilina oral, previo al procedimiento

Explicación: En procedimientos dentales invasivos, se recomienda profilaxis con amoxicilina solo en pacientes con condicionbes de alto riesgo de endocarditis, que incluyen: 1. Prótesis valvulares, 2. Endocarditis previa, 3. Cardiopatías congénitas no corregidas o con correcciones que incluyan prótesis. La evidencia no demuestra utilidad en otras situaciones, pero, en la práctica, se deja con más frecuencia, como en este caso con cardiopatía congénita corregida.

Fuente: Cardiología pediátrica P13

14. Un recién nacido prematuro de 7 horas de vida, presenta temblor, mioclonías y luego sopor, convulsionando en una oportunidad. Al examen físico se constata taquicárdico e hiporreactivo. No se aprecian signos neurológicos focales. Se solicita hemoglucotest que resulta normal y electrocardiograma que demuestra una taquicardia ventricular polimorfa. La alteración hidroelectrolítica que con mayor probabilidad es responsable del cuadro descrito, es:

a. Hipocalcemia
b. Hipercalcemia
c. Hipokalemia
d. Hiperkalemia
e. Hiponatremia

Respuesta correcta: a. Hipocalcemia

Explicación: La hipocalcemia es la alteración hidroelectrolítica clásica de los prematuros (también de hijos de madre diabética) y se caracteriza por alargar el intervalo QT y desencadenar arritmias ventriculares tipo torsades de pointes. La hipoglicemia también es muy frecuente y tiene una clínica similar, por lo que se debe solicitar glicemia capilar como primer examen.

Fuente: Cardiología pediátrica P14

15. La persistencia del ductus arterioso, luego del nacimiento, puede tratarse farmacológicamente con:

a. Adenosina
b. Prostaglandinas
c. Furosemida
d. Indometacina
e. Digoxina

Respuesta correcta: d. Indometacina

Explicación: Los AINEs como el ibuprofeno o la indometacina son útiles para cerrar el ductus; si fallan, se procede al cierre mediante procedimientos invasivos (idealmente cierre transcatéter, por sobre la ligadura quirúrgica). Por el contrario, las prostaglandinas son útiles para mantenerlo abierto, en el caso de las cardiopatías congénitas cianóticas ducto dependientes.

Fuente: Cardiología pediátrica P15

16. Un niño de 13 años presenta 2 síncopes en relación al esfuerzo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico, que aumenta con la maniobra de Valsalva. El diagnóstico más probable es:

a. Insuficiencia mitral
b. Estenosis mitral
c. Estenosis pulmonar
d. Coartación aórtica
e. Miocardiopatía hipertrófica

Respuesta correcta: e. Miocardiopatía hipertrófica

Explicación: Es una MCPHT clásica. Ver el resumen de semiología cardiológica.

Fuente: Cardiología pediátrica P16

17. Un lactante de 2 semanas, asintomático, presenta un soplo cardíaco holosistólico IV/VI, que se ausculta en todo el precordio izquierdo. El diagnóstico más probable es:

a. Atresia tricuspídea
b. Comunicación interauricular tipo ostium secundum
c. Comunicación interventricular
d. Tronco arterioso
e. Foramen oval permeable

Respuesta correcta: c. Comunicación interventricular

Explicación: Es una CIV clásica. Ver el resumen de semiología cardiológica.

Fuente: Cardiología pediátrica P17

18. El fármaco de elección para convertir una taquicardia paroxística supraventricular, hemodinámicamente estable, que no responde a maniobras vagales, es:

a. Amiodarona
b. Digoxina
c. Adenosina
d. Propanolol
e. Nifedipino

Respuesta correcta: c. Adenosina

Explicación: La TPSV se trata con maniobras vagales. Si no responde, se da adenosina en bolo endovenoso (se puede repetir hasta 3 veces). Si no responde o si no hay adenosina, se puede dar verapamilo.

Fuente: Cardiología pediátrica P19

19. ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a un soplo funcional?

a. Sistólico
b. Intensidad III/VI
c. Tonalidad musical
d. Presencia de frémito
e. Eyectivo

Respuesta correcta: d. Presencia de frémito

Explicación: Los soplos funcionales son los más frecuentes en la infancia y adultos jóvenes. Siempre son sistólicos, eyectivos, sin otras alteraciones, con intensidad máximo III/VI, es decir, sin frémito y, lo más importante, sin síntomas que sugieran falla cardíaca (ej. síncopes, disnea, ortopnea, intolerancia al ejercicio, etc.).

Fuente: Cardiología pediátrica P20

20. Un niño de 3 meses presenta mal incremento ponderal e infecciones respiratorias a repetición. La madre refiere que se cansa rápidamente al mamar. Al examen físico destacan crépitos pulmonares bibasales y soplo cardíaco sistólico. Presenta además desaturación arterial hasta 85%, que revierte al aportar oxígeno. El diagnóstico más probable es:

a. Cardiopatía congénita con cortocircuito de derecha a izquierda
b. Cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha
c. Cardiopatía congénita obstructiva izquierda
d. Cardiopatía congénita con mezcla total
e. Transposicón de grandes arterias

Respuesta correcta: b. Cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha

Explicación: Tiene la clínica clásica de una cardiopatía congénita (mal incremento ponderal e infecciones respiratorias). Si bien desatura, el hecho de que revierta con oxígeno hace que sea no cianótica (El soplo sistólico puede corresponder a CIV o CIA). La A, D y E son cianóticas. La coartación aórtica sí tiene soplo y puede tener una clínica similar, pero es más infrecuente y le faltan los signos clásicos: disminución de los pulsos pedios e HTA de las extremidades superiores.

Es una cardiopatía congénita acianótica clásica (incluye CIV, CIA, DAP). Revisar semiología cardíaca. No se especifica qué tipo de soplo tiene, como para saber exactamente cuál es.

Fuente: Cuestionario 3.1 P1 · Cardiología pediátrica P18

Respiratorio y otorrinolaringología (22)

1. Un niño de 4 años ronca, presenta apneas durante el sueño y habla con "voz de papa caliente". Al examen físico se aprecia hipertrofia amigdalina, con amígdalas simétricas, que se juntan en la línea media de la faringe. No ha presentado amigdalitis ni otro tipo de infecciones recurrentes. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución hasta que cumpla 6 años
b. Iniciar corticoides en spray nasal y reevaluar en un mes
c. Iniciar corticoides orales y decidir conducta según respuesta
d. Derivar para amigdalectomía bilateral

Respuesta correcta: d. Derivar para amigdalectomía bilateral

Explicación: Tiene indicación quirúrgica, por cumplir con un criterio obstructivo: apnea del sueño. Además, su hipertrofia amigdalina es grado IV (se juntan en la línea media), lo que es una indicación relativa de amigdalectomía (si tiene síntomas, pasa a ser absoluta).

Fuente: Cuestionario 3.1 P17

2. Un lactante de 6 meses de edad, nacido a las 28 semanas de edad gestacional, con antecedente de una enfermedad de membrana hialina que fue tratada con ventilación mecánica y surfactante endotraqueal, ha permanecido con requerimientos de oxígeno de un 28% de FiO2, para mantener saturación arterial de oxígeno normal. Cuenta con una radiografía de tórax que muestra opacidades lineales múltiples y zonas de enfisema en ambos pulmones. El diagnóstico es:

a. Fibrosis quística
b. Neumonía neonatal
c. Bronquiectasias
d. Bronquiolitis
e. Displasia broncopulmonar

Respuesta correcta: e. Displasia broncopulmonar

Explicación: Tiene una displasia broncopulmonar (DBP) clásica, que suele ser una complicación de la enfermedad de membrana hialina y se caracteriza por afectación pulmonar crónica (aunque mejora con el paso de los meses) y SBOR secundario. En la radiografía de tórax se ve con zonas de fibrosis y otras de enfisema. Es multifactorial, pero el antecedente de EMH es lo más importante y, es más, el diagnóstico de DBP suele hacerse en un recién nacido que tiene EMH, pero que sigue requiriendo oxígeno después del equivalente a las 36 semanas edad edad gestacional. La fibrosis quística tiene síntomas respiratorios, con bronquiectasias y neumonías por pseudomona y estafilococo. La bronquiolitis es el primer caso de SBO. Las bronquiectasias son dilataciones permanentes de los bronquios y dan clínica de infecciones respiratorias a repetición, broncorrea mayor en la mañana y hemoptisis (pueden tener uñas en vidrio de reloj).

Fuente: Cuestionario 3.1 P18

3. Una niña de 4 años de edad presenta cuadro de tos irritativa y fiebre hasta 38,1° de 24 horas de evolución. En las últimas horas la tos se hace más intensas, agregándose disfonía, estridor inspiratorio y

finalmente disnea. Al examen físico se observa taquipneica, con retracción intercostal, sin cianosis. La auscultación pulmonar no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Administrar oxígeno, nebulizar con adrenalina racémica, administrar corticoides inhalados e iniciar antibióticos
b. Administrar oxígeno, nebulizar con salbutamol y administrar corticoides inhalados
c. Administrar oxígeno, nebulizar con adrenalina racémica e iniciar antibióticos orales
d. Administrar oxígeno, nebulizar con adrenalina e iniciar corticoides orales
e. Administrar oxígeno, nebulizar con salbutamol e iniciar corticoides endovenosos

Respuesta correcta: d. Administrar oxígeno, nebulizar con adrenalina e iniciar corticoides orales

Explicación: Tiene una laringitis obstructiva clásica. El oxígeno es la primera medida, como en todo trastorno V/Q. La adrenalina permite desobstruir rápidamente y puede ser racémica (0,05 ml/Kg) o adrenalina común, también llamada levoadrenalina (0,5 ml/Kg: 10 veces la dosis). Los corticoides evitan las recurrencias (dexametasona oral: 0,6 mg/Kg o por otra vía, si no tolera la oral).

Tiene una laringitis obstructiva clásica. Se trata con oxígeno (si desatura), más adrenalina inhalada (puede ser racémica o común: en el sistema público se usa la común), más corticoides sistémicos (vía oral si es posible; de lo contrario, intramusculares o endovenosos). El salbutamol, en cambio, se usa para el síndrome bronquial obstructivo y el asma.

Fuente: Respiratorio pediátrico P1 · Cuestionario 3.1 P9

4. Un lactante de 4 meses, sin antecedentes de importancia, ni cuadros respiratorios previos, inicia cuadro de tos y dificultad respiratoria. Al examen se observa con cianosis perioral, uso de musculatura accesoria y el examen pulmonar demuestra sibilancias difusas bilaterales. El diagnóstico más probable es:

a. Bronquiolitis aguda
b. Bronquitis aguda
c. Neumonía bacteriana
d. Displasia broncopulmonar
e. Crisis asmática

Respuesta correcta: a. Bronquiolitis aguda

Explicación: El primer SBO en lactantes se llama bronquiolitis. La mayoría es por virus respiratorio sincicial (VRS), aunque puede ser por otros virus (parainfluenza sobre todo, aunque también por cualquier otro).

Fuente: Respiratorio pediátrico P2

5. Un recién nacido de 2 días de vida, es diagnosticado de neumonía. La terapia antibiótica empírica más adecuada es:

a. Ampicilina sola
b. Cefotaximo + vancomicina
c. Ceftriaxona + claritromicina
d. Gentamicina + clindamicina
e. Gentamicina + ampicilina

Respuesta correcta: e. Gentamicina + ampicilina

Explicación: El tratamiento empírico de la sepsis neonatal, incluyendo las neumonías neonatales es ampicilina (cubre SGB, listeria y E. coli) más un aminoglicósido (cubre gram negativos y tiene cierta sinergia para listeria). Tanto gentamicina como amikacina se pueden usar. También es correcto usar ampicilina más cefotaximo, ya que cubre bien a los gran negativos y estreptococos, pero algunas guías internacionales prefieren el aminoglicósido, en lugar de la cefalosporinas, en especial en las sepsis tempranas, que inician en las primeras 72 horas, ya que las cefalosporinas no cubren listeria. La ceftriaxona se evita en neonatos, ya que puede aumentar la toxicidad de la hiperbilirrubinemia.

Fuente: Respiratorio pediátrico P3

6. Un recién nacido de término, nacido por cesárea, inicia dificultad respiratoria a los pocos minutos de nacer. Al examen se observa taquipneico, con aleteo nasal, sin cianosis. Logra saturación normal con oxígeno al 24%. La radiografía de tórax muestra hilios prominentes y líquido en las cisuras. El diagnóstico más probable es:

a. Neumonía neonatal
b. Cardiopatía congénita, con shunt de izquierda a derecha
c. Cardiopatía congénita, con shunt de derecha a izquierda
d. Taquipnea transitoria
e. Síndrome de aspiración meconial

Respuesta correcta: d. Taquipnea transitoria

Explicación: Es una taquipnea transitoria clásica.

Fuente: Respiratorio pediátrico P4

7. Un niño de 6 años consulta por un cuadro de 7 días de evolución de decaimiento, rinorrea y tos seca, la que luego se hace productiva. En las últimas 48 horas se agrega fiebre hasta 38,5°C, asociada mayor compromiso del estado general y finalmente disnea leve. Al examen físico se observa niño en buenas condiciones generales, eupneico, febril hasta 38°, normotenso, bien perfundido, con frecuencia respiratoria de 20 rpm y saturación de O2 de 97%. El examen pulmonar presenta murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales, mayores a izquierda. La radiografía de tórax muestra un infiltrado intersticial bilateral, mayor en la base izquierda. El tratamiento antibiótico de elección es:

a. Penicilina benzatina intramuscular
b. Amoxicilina oral
c. Azitromicina oral
d. Ceftriaxona endovenosa
e. Clindamicina endovenosa

Respuesta correcta: c. Azitromicina oral

Explicación: Es una neumonía atípica clásica, generalmente causada por Mycoplasma pneumoniae y, menos frecuentemente, por Chlamydia pneumoniae. Se trata con macrólidos (azitromicina 10 mg/kg). También se puede tratar con levofloxacino, aunque las quinolonas suelen reservarse para adultos, si bien su seguridad en niños es cada vez más estudiada y parece improbable la afectación a largo plazo. Sin embargo, la recomendación sigue siendo preferir otros antibióticos y solo usar quinolonas si no se cuenta con otros medicamentos más srguros.

Fuente: Respiratorio pediátrico P5

8. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede cursar con mayor probabilidad con una insuficiencia respiratoria global?

a. Crisis asmática
b. Neumonía neumocócica
c. Intoxicación con jarabe para la tos
d. Cardiopatía congénita cianótica
e. Displasia bronquiopulmonar

Respuesta correcta: c. Intoxicación con jarabe para la tos

Explicación: La codeína es un opiáceo y puede producir hipoventilación. Ver resumen de gases arteriales (al final del resumen de semiología respiratoria).

Fuente: Respiratorio pediátrico P6

9. La etiología más frecuente del síndrome bronquial obstructivo recurrente del lactante es:

a. Hiperreactividad bronquial secundaria a infección por virus respiratorio sincicial, exacerbada por nuevas infecciones virales
b. Hiperreactividad bronquial secundaria a exposición a alérgenos respiratorios, exacerbada por infecciones virales
c. Alteraciones anatómicas de las vías respiratorias pequeñas, asociadas a disminución de la producción de surfactante
d. Alteraciones en el clearence de secreciones respiratorias, por parte del epitelio ciliado
e. Infecciones reiteradas por virus respiratorio sincicial

Respuesta correcta: a. Hiperreactividad bronquial secundaria a infección por virus respiratorio sincicial, exacerbada por nuevas infecciones virales

Explicación: Tanto el SBOR como el asma se producen por hiperreactividad bronquial, solo que en el SBOR es post VRS, mientras que en el asma es alérgica.

Fuente: Respiratorio pediátrico P7

10. Un paciente de 6 años, consulta por cuadro de 3 días de evolución de odinofagia leve y tos irritativa, la que luego se hace productiva, con expectoración mucosa abundante. Al examen físico se observa paciente en buenas condiciones generales, sin dificultad respiratoria. La auscultación pulmonar demuestra esterores bilaterales difusos, que se movilizan con la tos. Se solicita radiografía de tórax, la que resulta normal. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento sintomático, sin necesidad de antibióticos ni corticoides
b. Iniciar antibióticos orales, mucolíticos y antipiréticos
c. Iniciar antibióticos y corticoides endovenosos
d. Iniciar broncodilatadores inhalados, asociados a corticoides inhalados
e. Iniciar broncodilatadores inhalados, asociados a corticoides orales y antibióticos orales

Respuesta correcta: a. Iniciar tratamiento sintomático, sin necesidad de antibióticos ni corticoides

Explicación: Tiene una bronquitis, que es un tipos de infección respiratoria alta, por lo que se trata sintomáticamente. No se debe confundir con la broquiolitis, que el primer SBO en el lactante, generalmente por VRS.

Fuente: Respiratorio pediátrico P8

11. Un paciente de 7 años, presenta tos con el ejercicio y en algunas ocasiones, también respiración sibilante. El examen físico es normal, al igual que el PEF (flujo espiratorio máximo). La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio sin necesidad de mayor estudio
b. Solicitar radiografía de tórax y decidir manejo según hallazgos
c. Solicitar test cutáneo para alérgenos respiratorios
d. Solicitar test de provocación bronquial con metacolina
e. Iniciar antihistamínicos y corticoides orales

Respuesta correcta: d. Solicitar test de provocación bronquial con metacolina

Explicación: La sospecha diagnóstica es un asma. La clínica es el elemento más importante para el diagnóstico, pero se puede confirmar con una espirometría como examen de elección. Sin embargo, en los pacientes con síntomas intermitentes la espirometría resulta normal (falso negativo), por lo que se prefiere la prueba de provocación con metacolina, que es una espirometría, pero con dosis crecientes de metacolina inhalada, que es un broncoconstrictor. Si se obstruye mucho, se apoya el diagnóstico (advertir al paciente que se puede sentir bastante ahogado, pero que al final se lo nebuliza con salbutamol para revertir el efecto de la metacolina).

Fuente: Respiratorio pediátrico P9

12. La causa más frecuente de estridor congénito de tipo inspiratorio es:

a. Laringomalacia
b. Hemangioma subglótico
c. Parálisis vocal unilateral
d. Traqueomalacia
e. Membrana faríngea

Respuesta correcta: a. Laringomalacia

Explicación: La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito (inspiratorio y de tonalidad alta, por lo general) y suele ser de excelente pronóstico, mejorando sola. Sin embargo, siempre se debe solicitar una nasofibrolaringoscopía, para descartar otras causas más graves.

Fuente: Respiratorio pediátrico P10

13. Un niño de 2 años inicia cuadro de tos intensa, de inicio súbito, persistiendo luego con tos, la que se hace rápidamente productiva. Al examen físico se ve de buen aspecto y la auscultación pulmonar demuestra sibilancias en la base derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Neumonía
b. Bronconeumonía
c. Bronquitis aguda
d. Coqueluche
e. Cuerpo extraño bronquial

Respuesta correcta: e. Cuerpo extraño bronquial

Explicación: Es un cuerpo extraño bronquial clásico. Ver resumen de semiología respiratoria.

Fuente: Respiratorio pediátrico P11

14. Un recién nacido pretérmino de 33 semanas, presenta dificultad respiratoria, quejido, aleteo nasal y retracción intercostal y subcostal. Al examen físico se observa taquipneico, con cianosis perioral, la que mejora parcialmente con la administración de oxígeno. La auscultación cardiopulmonar sólo demuestra crepitaciones bibasales. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de membrana hialina
b. Taquipnea transitoria
c. Neumonía neonatal
d. Ductus arterioso persistente
e. Síndrome de aspiración meconial

Respuesta correcta: a. Enfermedad de membrana hialina

Explicación: Es una enfermedad de membrana hialina clásica: recién nacido prematuro menor de 34 semanas, con distrés respiratorio grave. Se trata con soporte respiratorio y surfactante endotraqueal.

Fuente: Respiratorio pediátrico P12

15. Un niño de 4 años presenta cuadro catarral, seguido de tos seca, la que se hace muy intensa, con accesos de tos recurrentes, seguidos de gallito inspiratorio. Se sospecha infección por Bordetella pertusis, la que se confirma con una inmunofluorescencia directa de expectoración. Su hermano de 3 años, vive con él, tiene sus vacunas al día y se encuentra asintomático. La conducta más adecuada para ambos niños es:

a. Indicar azitromicina por 5 días al paciente y por 7 días a su hermano
b. Indicar azitromicina por 5 días al paciente y sólo una dosis a su hermano
c. Indicar azitromicina por 5 días exclusivamente al paciente y observar al hermano
d. indicar amoxicilina más ácido clavulánico por 10 días exclusivamente al paciente y observar al hermano
e. Indicar amoxicilina más ácido clavulánico por 14 días al paciente y sólo una dosis a su hermano

Respuesta correcta: c. Indicar azitromicina por 5 días exclusivamente al paciente y observar al hermano

Explicación: El hermano no tiene factores de riesgo ni síntomas, por lo que no requiere profilaxis (igual al tratamiento). La profilaxis de los contactos es algo controvertido. La evidencia dice que solo sirve en los pacientes que están sintomáticos (en especial en la etapa catarral inicial), sin embargo, las recomendaciones la extienden a todos los que tienen patologías que se pueden descompensar con el coqueluche (cardíacas, respiratorias, epilepsia), así como a los menores de 1 años y menores de 2 años con menos de 3 dosis de vacuna. En todos se debe completar la vacunación, si está incompleta.

Fuente: Respiratorio pediátrico P13

16. Un paciente 4 años, con sus vacunas al día, estuvo en contacto con un paciente diagnosticado recientemente de tuberculosis bacilífera. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal y PPD que resulta negativo, al igual que la baciloscopía. La conducta es:

a. Observar evolución, sin necesidad de nuevos exámenes ni tratamientos
b. Iniciar quimioprofilaxis primaria con isoniazida
c. Indicar nueva vacunación con BCG y observar evolución
d. Solicitar baciloscopías de expectoración mensuales, por 6 meses y decidir conducta según resultados
e. Solicitar nuevas radiografías de tórax y PPD mensualmente, por 6 meses y decidir conducta según resultados

Respuesta correcta: b. Iniciar quimioprofilaxis primaria con isoniazida

Explicación: Todo menor de 15 años recibe isoniazida como profilaxis; también la reciben los adultos con PPD positivo. La excepción en pediatría solo los niños que requieren tratamiento antituberculoso completo, con 4 fármacos, que son los que tienen pruebas diagnósticas positivas (PCR, baciloscopías o cultivo) o alteraciones radiológicas.

Fuente: Respiratorio pediátrico P14

17. Un lactante de 11 meses, inicia cuadro de fiebre hasta 38,5°C e irritabilidad, sin otros síntomas. Al examen físico se ve de buen aspecto y sólo destaca faringe eritematosa, congestiva, con exudado amigdalino blanquecino, adherente, bilateral, asociado a algunas adenopatías cervicales. El diagnóstico más probable es:

a. Infección respiratoria alta viral
b. Amigdalitis estreptocócica
c. Mononucleosis infecciosa
d. Herpangina
e. Difteria

Respuesta correcta: a. Infección respiratoria alta viral

Explicación: Las amigdalitis exudativas en menores de 3 años generalmente son causadas por adenovirus. Si bien se suele usar el score de Centor en la evaluación de las amigdalitis, es poco recomendable hacerlo en estos casos de lactantes en los que, casi con seguridad, se trata de un virus. De todos modos, si se quiere estar seguro, es aceptable solicitar un panel viral y una prueba de detección de estreptococo, pero también es perfectamente aceptable indicar tratamiento sintomático.

Fuente: Respiratorio pediátrico P15

18. El tratamiento farmacológico de primera línea para el asma persistente es:

a. Beta agonistas de acción corta inhalados, previos a la actividad física o en caso de síntomas, sin necesidad de usar corticoides
b. Corticoides inhalados según horario y beta agonistas de acción corta según síntomas
c. Corticoides inhalados según horario y beta agonistas de acción larga según síntomas
d. Corticoides inhalados y beta agonistas de acción larga según horario, más beta agonistas de acción corta según síntomas
e. Corticoides orales en dosis bajas y beta agonistas de acción corta según síntomas

Respuesta correcta: b. Corticoides inhalados según horario y beta agonistas de acción corta según síntomas

Explicación: El concepto de "asma persistente" es controvertido, pero, la regla general es que el manejo de cualquier paciente que tenga síntomas persistentes de asma requerirá de corticoides inhalados para prevenirlos, más broncodilatadores de corta acción para revertirlos una vez que aparecen. De segunda línea se agregan los broncodilatadores de acción larga, aunque es aceptable agregarlos desde el inicio del tratamiento en quienes tienen síntomas moderados (síntomas diarios; o 3 o más despertares nocturnos al mes).

Fuente: Respiratorio pediátrico P16

19. Niño de 3 años, ha presentado 3 episodios de otitis media aguda en los últimos 6 meses. Consulta por nuevo episodio de otalgia y otorrea escasa a derecha. A la otoscopía se observa tímpano derecho eritematoso y abombado, con salida de pus. El tratamiento antibiótico de elección, para este nuevo episodio de otitis media aguda es:

a. Amoxicilina
b. Cefadroxilo
c. Amoxicilina más ácido clavulánico
d. Azitromicina
e. Ciprofloxacino

Respuesta correcta: a. Amoxicilina

Explicación: El antibiótico no cambia en la OMAR, ya que suelen ser reinfecciones por bacteras sensibles, debido a la disfunción de la trompa de Eustaquio, pero sí se debe derivar al ORL para evaluar la necesidad de una cirugía que corrija esta disfunción (ej. tubos de ventilación timpánica y adenoidectomía). Eso sí, si han pasado menos de 15 días desde la última infección, sí se prefiere ampliar la cobertura, ya que puede ser la misma bacteria que es resistente.

Fuente: Respiratorio pediátrico P17

20. La gravedad de una crisis bronquial obstructiva está determinada principalmente por:

a. La gasometría arterial
b. La radiografía de tórax
c. El agente etiológico
d. La edad del paciente
e. La clínica

Respuesta correcta: e. La clínica

Explicación: La clínica es lo más importante para determinar la severidad de todos los cuadros respiratorios agudos (SBO, crisis asmática, laringitis obstructiva, neumonía). Luego, es útil la gasometría arterial.

Fuente: Respiratorio pediátrico P18

21. Un paciente asmático de 10 años, en tratamiento con broncodilatadores y corticoides inhalados, de uso irregular, consulta por tos seca, asociada a respiración sibilante y disnea de reposo. Al examen se observa disneico, con cianosis labial, frecuencia respiratoria de 32 rpm, asociado a tiraje y retracción subcostal. La auscultación pulmonar muestra espiración prolongada y sibilancias inspiratorias y espiratorias intensas y difusas. La conducta más adecuada es:

a. Realizar una nebulización con salbutamol y enviar a domicilio con indicación de cumplir el tratamiento previo, sin necesidad de nuevos controles
b. Realizar 3 inhalaciones con salbutalmol, asociado a ipratropio, separadas por 10 minutos, administrar corticoides sistémicos y enviar a domicilio con tratamiento antibiótico oral
c. Iniciar oxígeno, indicar salbutamol inhalado, administrar corticoides sistémicos y reevaluar periódicamente
d. Hospitalizar, iniciar oxígeno y broncodilatadores nebulizados, administrar corticoides endovenosos, indicar kinesioterapia y observar por 24 horas
e. Intubar, iniciar ventilación mecánica, broncodilatadores inhalados, corticoides y antibióticos sistémicos.

Respuesta correcta: c. Iniciar oxígeno, indicar salbutamol inhalado, administrar corticoides sistémicos y reevaluar periódicamente

Explicación: El manejo de la crisis asmática incluye los siguientes pilares: 1. Oxígeno para saturar 93% o más (sin miedo de hipercarbia, a diferencia del EPOC), 2. Salbutamol inhalado: puff (2-4 cada 20 minutos) o nebulizaciones, siendo preferible los puff en muchas guías y 3. Corticoides sistémicos (prednisona 0,5 mg/Kg).

Fuente: Respiratorio pediátrico P19

22. Los gérmenes que con mayor frecuencia están involucrados en las infecciones respiratorias bajas, de los pacientes con fibrosis quística son:

a. Staphylococcus aureus y Pseudomona aureginosa
b. Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma
c. Streptococcus pneumoniae y Anaerobios
d. Staphylococcus aureus y Anaerobios
e. Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae

Respuesta correcta: a. Staphylococcus aureus y Pseudomona aureginosa

Explicación: Las bacterias más frecuentes en los niños con fibrosis quística son Staphylococcus aureus y Pseudomona aureginosa. Es más, las neumonías por estos gérmenes en niños, obligan a descartar fibrosis quística. También se colonizan por otras bacterias raras, como Burkholderia, Stenotrophomonas y micobacterias no tuberculosas.

Fuente: Respiratorio pediátrico P20

Digestivo y hepatología (31)

1. Un niño de 4 años se traga una bolita de cristal, evolucionando con dolor torácico, imposibilidad de tragar y sialorrea. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución sin necesidad de mayor estudio
b. Controlar con radiografías cada 24 horas
c. Revisar las deposiciones diariamente hasta que aparezca la bolita
d. Retirar el cuerpo extraño por vía endoscópica
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: d. Retirar el cuerpo extraño por vía endoscópica

Explicación: Tiene un cuerpo extraño esofágico, ya que tiene sialorrea, dolor e imposibilidad de tragar. Se debe extraer con la endoscopía. Sí es correcto solicitar una radiografía, para buscar neumomediastino, lo que sugeriría una perforación y se debería estudiar con una TAC y si es importante o evoluciona a mediastinitis, manejar quirúrgicamente. Sin embargo, nada de esto aparece en las alternativas (la B habla de controles periódicos con radiografías). Si hubiese estado en el estómago o más allá y fuera asintomático, simplemente se observa. Vale la pena mencionar que el cristal es radiolúcido, por lo que no se vería en la radiografía.

Fuente: Cuestionario 3.1 P20

2. Un niño de 6 años es traído por su madre, ya que presenta "incontinencia fecal". Mancha frecuentemente los calzoncillos y las sábanas con deposiciones. No presentan problemas urinarios. Al examen físico destaca palpación de una masa hipogástrica, con examen neurológico normal. El diagnóstico más probable es

a. Enfermedad de Hirschsprung
b. Ascariasis
c. Polipomatosis adenomatosa familiar
d. Enfermedad de Cröhn
e. Fecaloma

Respuesta correcta: e. Fecaloma

Explicación: Es un fecaloma clásico con encopresis y pseudoincontinencia. Se debe objetivar con un tacto rectal (recomendación: hacerlo en presencia de enfermera y registrar su nombre en la ficha, a fin de evitar acusaciones infundadas). Una vez diagnosticado se debe desimpactar con un enema evacuante o solución de colon oral. Posteriormente, se debe dejar con polietilenglicol como laxante, hasta formar el hábito de defecación.

Tiene un fecaloma clásico, con la pseudodiarrea y encopresis, que se presenta por rebalse. La masa es compatible con el diagnóstico. Se confirma con el tacto rectal (recordar hacerlo siempre en presencia de un auxiliar o enfermera, que dejen constancia de que no hay abuso). Se trata con 1. Desimpactación (con polietilenglicol en solución oral o rectal), 2. seguida de la prevención de recidivas con una dosis de mantención de polietilenglicol, más 3. Educación de hábitos de alimentación y defecación.

Fuente: Digestivo pediátrico P1 · Cuestionario 3.1 P19

3. Un paciente de 14 meses es traído por su madre, ya que presenta diarrea acuosa abundante, asociada a fiebre hasta 38,4°C de un día de evolución. Al examen físico se observa en buenas condiciones, animado, afebril y con signos vitales normales. Las mucosas están húmedas, la piel turgente y llora con lágrimas. La conducta más adecuada es

a. Enviar a domicilio con régimen liviano, sin residuos e hidratación oral con sales de rehidratación luego de cada deposición diarreica
b. Indicar antibióticos y sales de rehidratación oral, según plan A
c. Indicar reposición hídrica con sales de rehidratación oral con 50-100cc/Kg y reevaluar en 4 a 6 horas
d. Indicar antidiarreicos y sales de rehidratación oral, según plan B
e. Enviar a domicilio con régimen liviano sin residuos, hidratación oral, según plan A, antibióticos y antidiarreicos

Respuesta correcta: a. Enviar a domicilio con régimen liviano, sin residuos e hidratación oral con sales de rehidratación luego de cada deposición diarreica

Explicación: Tiene una diarrea aguda, sin deshidratación, por lo que requiere hidratación oral, según plan A. No requiere antibióticos, ya que no tiene disentería, sino solo fiebre, lo que es compatible con una infección por rotavirus.

Fuente: Digestivo pediátrico P2

4. Una niña de 6 años presenta dolor abdominal intenso, varias veces al día, de localización periumbilical, que suele iniciar luego de que despierta y la acompaña durante las clases, siendo especialmente intenso en los periodos de mayor carga y tendiendo a desaparecer en el período de vacaciones. El examen físico es normal y la niña se ve de buen aspecto. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar cintigrafía con tecnecio
b. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
c. Solicitar radiografías baritadas
d. Indicar antiespasmódicos SOS
e. Explicar a la madre que con alta probabilidad el dolor es de origen psicógeno y solicitar exámenes generales para descartar la presencia de patología orgánica

Respuesta correcta: e. Explicar a la madre que con alta probabilidad el dolor es de origen psicógeno y solicitar exámenes generales para descartar la presencia de patología orgánica

Explicación: Probablemente se trata de dolor abdominal psicógeno. La localización periumbilical y el patrón temporal, relacionado con periodos de estrés, lo hace probable.

Fuente: Digestivo pediátrico P3

5. Un niño con fibrosis quística, presenta un síndrome de malabsorción intestinal. Se sospecha que es secundaria a un déficit de la secreción de enzimas pancreáticas. A diferencia de la enfermedad celíaca, este paciente presentará:

a. Esteatorrea
b. Detención del crecimiento
c. Test de la D-xilosa normal
d. Signos carenciales
e. Anemia

Respuesta correcta: c. Test de la D-xilosa normal

Explicación: El estudio de la malabsorción se realiza en el siguiente orden: 1. objetivar la esteatorrea (test de Sudán) y realizar inmediatamente los exámenes relacionados con la sospecha clínica (ej. si se sospecha FQ, realizar prueba del sudor). 2. Si no se tiene una sospecha clara, se piden los exámenes de enfermedad celíaca y la prueba de la D- xilosa. Esta última diferencia las patologías por alteraciones de la pared intestinal (disminuyen la absorción y posterior eliminación urinaria de D-xilosa) de las por problemas de digestión enzimática (absorción y eliminación urinaria normales).

Fuente: Digestivo pediátrico P4

6. Un lactante de 25 días inicia vómitos postprandiales explosivos, asociados a baja de peso. La madre refiere que el niño se encuentra hambriento y que mama varias veces al día, pero casi siempre vomita a los pocos minutos. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar endoscopía digestiva alta
b. Solicitar ecografía abdominal
c. Instalar sonda nasogástrica
d. Iniciar bloqueadores de calcio
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: b. Solicitar ecografía abdominal

Explicación: La sospecha clínica es una estenosis hipertrófica del píloro, que se estudia con ecografía abdominal y se maneja con cirugía de miotomía pilórica de Ramstedt. Los síntomas clásicamente inician al mes de vida (entre 2 y 6 semanas), siendo fundamentalmente importantes los vómitos explosivos y el aspecto hambriento. Puede tener ictericia tardía también. La HSRC puede tener una clínica similar, con la gran diferencia que esta tiene hiperkalemia, mientras que la EHP tiende a la hipokalemia.

Fuente: Digestivo pediátrico P5

7. Aunque la vasta mayoría de pacientes con deshidratación sin shock pueden ser tratados exitosamente con rehidratación oral, la terapia de rehidratación oral puede no ser efectiva en pacientes con una de las siguientes situaciones:

a. Diarrea por E. coli enterotoxigénica
b. Distensión abdominal progresiva
c. Vómitos, en promedio de dos por hora
d. Diarrea por rotavirus
e. Hipernatremia

Respuesta correcta: b. Distensión abdominal progresiva

Explicación: Obligan a la hidratación oral: compromiso de conciencia, shock, íleo paralítico (se puede ver como distensión abdominal progresiva).

Nota del editor: La explicación original dice que estas situaciones obligan a la hidratación oral. Debe leerse al revés: contraindican la vía oral y obligan a hidratación endovenosa.

Fuente: Digestivo pediátrico P7

8. El examen más adecuado para continuar el estudio de un neonato de 20 días de vida, con ictericia de predominio directo, es:

a. Prueba de Coombs
b. TSH
c. Resonancia magnética nuclear
d. Ecografía abdominal
e. Pruebas hepáticas

Respuesta correcta: d. Ecografía abdominal

Explicación: La ictericia neonatal tardía, de predominio directo suele ser causada por atresia biliar primaria, la que se confirma con ecografía abdominal.

Fuente: Digestivo pediátrico P8

9. Un niño de 8 años consulta por cuadro de compromiso del estado general y luego ictericia, asociada a acolia y coluria. Entre sus exámenes destaca IgM positiva anti-VHA, diagnosticándose hepatitis A. ¿Cuál de las siguientes situaciones daría un peor pronóstico?

a. Transaminasas mayor a 1500
b. Protrombinemia de 60%
c. Confusión mental
d. Aparición de ascitis clínica
e. Positividad de anticuerpos IgG Anticore VHB

Respuesta correcta: c. Confusión mental

Explicación: La hepatitis fulminante o falla hepática aguda fulminante se define por la presencia de encefalopatía. Por tanto, su pronóstico es muy malo y suele requerir trasplante hepático para sobrevivir. La caída en la protrombinemia suele precederlo, por lo que es el examen más importante para definir el

pronóstico en las hepatitis agudas, sin embargo, da peor pronóstico la confusión mental, por ser un síntomas de encefalopatía.

Fuente: Digestivo pediátrico P9

10. El tratamiento de elección de la ascariasis es:

a. Albendazol
b. Metronidazol
c. Nifurtimox
d. Prazicuantel
e. Cotrimoxazol

Respuesta correcta: a. Albendazol

Explicación: La ascariasis se puede tratar con albendazol 1 dosis (10 mg/Kg, máximo 400 mg) o mebendazol (máximo 500 mg). También sirve el pamoato de pirantel, que se usa en embarazadas.

Fuente: Digestivo pediátrico P10

11. Un niño de 4 años presenta diarrea crónica, asociada a piel seca, caída del pelo, queilitis, detención del crecimiento y anemia microcítica. El diagnóstico más probable es:

a. Acidosis tubular renal
b. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
c. Inmunodeficiencia por déficit de IgA
d. Enfermedad celíaca
e. Fibrosis quística

Respuesta correcta: d. Enfermedad celíaca

Explicación: Tiene un síndrome de malabsorción intestinal. La anemia ferropénica apunta fuertemente a la enfermedad celíaca, ya que el hierro se absorbe en el duodeno que suele ser la parte más afectada del intestino.

Fuente: Digestivo pediátrico P11

12. Un niño de 1 año consulta por dolor abdominal muy intenso, asociado a eliminación de deposiciones rojas en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

a. Divertículo de Meckel complicado
b. Invaginación intestinal
c. Hiperplasi linfonodular
d. Adenitis mesentérica
e. Embolia mesentérica

Respuesta correcta: b. Invaginación intestinal

Explicación: Es una intususcepción o invaginación intestinal clásica. Se suele diagnosticar con la ecografía abdominal, que muestra la imagen en tiro al blanco o en herradura. Se trata con desinvaginación neumática y, solo si falla, se proce a la cirugía.

Fuente: Digestivo pediátrico P12

13. Un recién nacido de 24 días de vida es traído por su madre, ya que presenta regurgitaciones frecuentes de leche. Refiere que todos los días vomita 1 o 2 veces. Ha mantenido un buen incremento ponderal y no presenta alteraciones en el examen físico. El diagnóstico más probable es:

a. Estenosis hipertrófica del píloro
b. Enterocolitis necrotizante
c. Enfermedad de Hirschsprung
d. Atresia duodenal
e. Reflujo gastroesofágico del lactante

Respuesta correcta: e. Reflujo gastroesofágico del lactante

Explicación: "Los únicos bebés que no vomitan leche son los que no toman leche". Si se ve bien y no es muy intenso, probablemente, sea un reflujo fisiológico.

Fuente: Digestivo pediátrico P13

14. Los pacientes con atresia biliar primaria, que se operan después de las 8 semanas de vida, tienen alto riesgo de desarrollar:

a. Malaabsorción intestinal
b. Cirrosis hepática
c. Dolor abdominal crónico
d. Litiasis biliar
e. Quistes reanles

Respuesta correcta: b. Cirrosis hepática

Explicación: La atresia biliar primaria es la primera causa de daño hepático crónico en niños y el momento de la cirugía es el principal determinante del pronóstico. Por ello, el diagnóstico debe ser precoz y la cirugía también.

Fuente: Digestivo pediátrico P14

15. Un niño de 5 años inicia un cuadro diarreico severo, que al día siguiente se vuelve disentérico. Al examen físico está muy decaído, con aspecto tóxico, soporoso y con deshidratación moderada. Su temperatura es 40,3°C y su examen físico es no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar sales de rehidratación oral y cotrimoxazol
b. Iniciar sales de rehidratación oral y ciprofloxacino
c. Iniciar suero fisiológico y ceftriaxona endovenosa
d. Iniciar suero fisiológico, sin necesidad de antibióticos
e. Indicar hidratación oral, sin necesidad de antibióticos

Respuesta correcta: c. Iniciar suero fisiológico y ceftriaxona endovenosa

Explicación: La disentería suele ser por Shigella u otras enterobacterias (E. coli enteroinvasora y E. coli enterohemorrágica, por ejemplo). Todas se cubren bien con cefalosporinas, quinolonas y cotrimoxazol. Sin embargo, en niños se evitan las quinolonas. Además, por estar tóxico y soporoso, lo más adecuado es dar tratamiento endovenoso, con ceftriaxona.

Fuente: Digestivo pediátrico P15

16. La enfermedad de Hirschsprung se debe a:

a. Mal rotación intestinal
b. Persistencia del conducto ónfalo-mesentérico
c. Mutación de canales de cloro
d. Ausencia de neuronas en un segmento del plexo mientérico
e. Una alteración del cromosoma X

Respuesta correcta: d. Ausencia de neuronas en un segmento del plexo mientérico

Explicación: La enfermedad de Hirshcsprung se debe a una aganglionosis de un segmento de los plexos nerviosos intestinales (generalmente a nivel del recto y colon sigmoides, aunque puede ser en otra parte), ya sea el plexo mientérico o el submucoso. Causa constipación y obstrucción intestinal en lactantes. Su clínica consiste en imposibilidad de defecar, vómitos y síntomas de obstrucción desde el nacimiento. Se asocia a síndrome de Down. El diagnóstico definitivo se realiza con biopsia del segmento aganglionótico, que confirma la ausencia del plexo mientérico, pero, la sospecha se logra con radiografías contrastadas o manometría rectal y colónica, que muestran una zona contraída y estenótica. El tratamiento es la resección quirúrgica del segmento aganglionótico, con anastomosis primaria.

Fuente: Digestivo pediátrico P16

17. Un niño de 3 años presenta prurito anal importante. La madre visualizó un pequeño gusanito en la zona perianal. El tratamiento de elección es:

a. Prazicuantel
b. Metronidazol
c. Cotrimoxazol
d. Mebendazol
e. Benzinidazol

Respuesta correcta: d. Mebendazol

Explicación: La oxiurasis o enterobiasis ("pidulles") se trata igual que la ascariasis con albendazol, mebendazol o pamoato de pirantel.

Fuente: Digestivo pediátrico P17

18. Un paciente de 13 años, sin hábitos tóxicos, ni uso de medicamentos y que vive en una comunidad rural, consulta por un cuadro de una semana de evolución, que inició como fiebre hasta 38,4°C y decaimiento. Hace dos días notó que la orina empezó a volverse más oscura y que su piel y ojos empezaron a tomar un tinte amarillento. Se solicitan pruebas hepáticas que demuestran GOT: 1.560 UI/l, GPT: 1.389 UI/l, GGT: 120 UI/l, FA: 288 UI/l, bilirrubina total: 6,4 mg/dl, bilirrubina directa: 5,6 mg/dl. ¿Qué examen le parece más adecuado para determinar el diagnóstico etiológico de este cuadro?

a. AMA, ANCA, ASMA y ANA
b. Anticuerpos totales contra VHC
c. IgM VHA y antígeno de superficie VHB
d. Biopsia hepática
e. Ecografía abdominal

Respuesta correcta: c. IgM VHA y antígeno de superficie VHB

Explicación: Las pruebas hepáticas muestran una hepatitis aguda, con gran elevación de las transaminasas. Para determinar la etiología, se solicitan marcadores virales para hepatitis A (IgM-VHA) y la hepatitis B (antígeno de superficie VHB e IgM antiVHB core). Si no se identifica la causa, se piden exámenes en busca de otros virus, como CMV, VEB, VHE. Para el pronóstico, se usa la protrombinemia (si cae, aumenta el riesgo de falla hepática).

Fuente: Digestivo pediátrico P18

19. El tratamiento de la Giardiasis intestinal es:

a. Tinidazol
b. Clotrimazol
c. Cotrimoxazol
d. Albendazol
e. Prazicuantel

Respuesta correcta: a. Tinidazol

Explicación: La giardiasis es frecuente, especialmente en zonas sin agua potable o sin recursos. Su clínica varía desde ser completamente asintomática, hasta un cuadro de diarrea crónica y síndrome de malabsorción. El diagnóstico se puede hacer con microscopía de deposiciones o con PCR para Giardia lambia (más sensible). El tratamiento es con tinidazol oral. El metronidazol es menos efectivo.

Fuente: Digestivo pediátrico P19

20. La enfermedad de Hirschsprung se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

a. Su tratamiento es quirúrgico
b. Se diagnostica habitualmente mediante ecografía abdominal
c. Sus síntomas suelen ser similares a una obstrucción intestinal
d. El retraso en la eliminación de meconio es característica
e. Se caracteriza por el desarrollo de megacolon

Respuesta correcta: b. Se diagnostica habitualmente mediante ecografía abdominal

Explicación: El diagnóstico definitivo de la enfermedad de Hirschsprung se realiza con la biopsia de colon (por succión) y el diagnóstico de sospecha se realiza con radiografías contrastada por enema baritado o con manometría intestinal, que muestran una zona del colon contraída y estenótica. Las demás opciones son verdaderas.

Fuente: Digestivo pediátrico P20

21. La causa más frecuente de constipación en la edad pediátrica es:

a. Enfermedad de Hirschsprung
b. Síndrome de intestino irritable
c. Parasitosis intestinales
d. Malos hábitos de defecación
e. Pólipos juveniles

Respuesta correcta: d. Malos hábitos de defecación

Explicación: En niños es fundamental formar hábitos de defecación y alimentación adecuada, para evitar la constipación. El tratamiento, precisamente, consiste en formar dichos hábitos, muchas veces, apoyado de polietilenglicol u otro laxante.

Fuente: Digestivo pediátrico P21

22. Un niño de 2 años de edad presenta diarrea de 1 mes de evolución, con deposiciones explosivas, acuosas, sin sangre, que tiende a mejorar por algunos días y luego recurre. El examen físico es normal y mantiene su ritmo de crecimiento. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad celíaca
b. Giardiasis
c. Diarrea crónica inespecífica
d. Divertículo de Meckel
e. Enfermedad inflamatoria intestinal

Respuesta correcta: c. Diarrea crónica inespecífica

Explicación: Es una diarrea crónica inespecífica clásica. Se suele asociar a la ingesta de jugos hiperosmolares, por lo que la primera medida es prohibir su consumo y reemplazarlos por agua.

Fuente: Digestivo pediátrico P22

23. Un recién nacido de 20 días de vida presenta hematemesis en una oportunidad, sin otros síntomas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, bien perfundido, con pulso y presión arterial normales para la edad. El examen segmentario es normal. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar endoscopía digestiva alta
b. Iniciar reposición de volumen con cristaloides por vía venosa periférica gruesa
c. Solicitar test de Apt-Downey de la sangre emitida
d. Solicitar hemograma
e. Administrar omeprazol endovenoso

Respuesta correcta: c. Solicitar test de Apt-Downey de la sangre emitida

Explicación: La primera causa de hematemesis en el recién nacido es la ingesta de sangre materna, desde el pezón. El test de Apt Downey diferencia la hemoglobina fetal del recién nacido (que se mantiene roja o rosada) de la hemoglobina adulta o materna (que se vuelve amarilla o café), sin embargo, solo sirve en las primeras semanas de vida, ya que después el niño reemplazará su hemoglobina fetal por hemoglobina adulta.

Fuente: Digestivo pediátrico P23

24. Una niña de 7 años de edad, con mal incremento ponderal, presenta además diarrea crónica, esteatorreica. Se realiza test de Sudan en deposiciones, que resulta positivo y se solicitan anticuerpos antiendomisio, lo que resultan positivos a títulos altos. ¿Cuál de los siguientes alimentos puede ser ingerido sin problemas, por este paciente?

a. Avena
b. Maíz
c. Centeno
d. Trigo
e. Cebada

Respuesta correcta: b. Maíz

Explicación: Tiene una enfermedad celíaca. Trigo, cebada y centeno tienen gluten, por lo que están prohibidos, al igual que cualquier alimento procesado que pueda contenerlos. La avena no tiene gluten, pero tiene dos problemas: se procesa en los mismos molinos que otros cereales y tiene una proteína similar, que puede afectar a algunos celíacos. Por tanto, la avena se suele prohibir, salvo que el paciente ya está bien controlado, quiera comer avena, compre avena certificada libre de gluten y se introduzca de a poco, probando tolerancia. Los demás alimentos se pueden consumir sin problemas.

El gluten está presente en el trigo, la cebada y el centeno, más en una inmensa cantidad de alimentos procesados, que utilizan estos cereales. La avena no tiene gluten, pero sí un proteína similar y su consumo es controvertido. Algunos plantean que sí se puede usar avena, certificada como “libre de gluten”, en el sentido de que se muela y procese en lugares en los que no se manipulan los otros cereales con gluten. Sin embargo, la mayoría se inclina a prohibirla y, únicamente si el paciente la quiere, probar su reintroducción paulatina varios meses después (6 a 12), siempre y cuando se trate de avenas certificadas. Los demás alimentos se pueden ingerir sin problemas.

Fuente: Digestivo pediátrico P24 · Nutrición pediátrica P13

25. La presencia de ictericia, acompañada de coluria y acolia, en un lactante de 6 semanas, se debe más probablemente a:

a. Ictericia fisiológica
b. Síndrome de Gilbert
c. Atresia biliar primaria
d. Hipotiroidismo congénito
e. Hepatitis viral

Respuesta correcta: c. Atresia biliar primaria

Explicación: La coluria y acolia sugieren fuertemente una hiperbirrubinemia de tipo directo o conjugada, por colestasia. Por tanto, obliga a sospechar una atresia biliar primaria. Se deben solicitar pruebas hepáticas, con bilirrubina diferenciada y una ecografía abdominal.

Fuente: Digestivo pediátrico P26

26. La conducta más adecuada ante un lactante cursando una diarrea aguda por rotavirus, con deshidratación severa (mayor al 10% del peso corporal), es:

a. Hidratar con suero fisiológico por vía endovenosa
b. Indicar sales de rehidratación oral y reevaluar en 6 horas
c. Indicar sales de rehidratación oral luego de cada deposición diarreica, según Plan A
d. Iniciar antibióticos y sales de rehidratación oral
e. Iniciar sales de rehidratación oral e indicar vacunación contra el rotavirus

Respuesta correcta: a. Hidratar con suero fisiológico por vía endovenosa

Explicación: La deshidratación severa (definida clínicamente por el compromiso hemodinámico) se trata con hidratación endovenosa, según plan C: suero fisiológico en bolo de 20 cc/Kg de peso y reevaluar. El bolo se repite hasta lograr la estabilización del paciente.

Fuente: Digestivo pediátrico P27

27. La imagen radiológica de "doble burbuja", en contexto de un recién nacido con vómitos intensos desde las primeras horas de vida, sugiere fuertemente:

a. Una duplicidad intestinal
b. Una atresia duodenal
c. Una enfermedad de Hirschsprung
d. Una enterocolitis necrotizante
e. Una intususcepción intestinal

Respuesta correcta: b. Una atresia duodenal

Explicación: La atresia duodenal se asocia a síndrome de Down. Clínicamente se presenta como vómitos posprandiales, que aparecen muy precozmente. Puede tener vómitos biliosos. La radiografía (y ecografía, aunque la radiografía es mejor) muestran la imagen de doble burbuja (una del estómago y la otra del duodeno). El tratamiento es quirúrgico.

Fuente: Digestivo pediátrico P28

28. Un niño de 5 años presenta hematoquecia en 3 oportunidades, en el último año, sin otros síntomas. Su examen físico es completamente normal, incluyendo un tacto rectal. El diagnóstico más probable es:

a. Pólipo juvenil
b. Hiperplasia linfática nodular
c. Divertículo de Meckel
d. Enfermedad inflamatoria intestinal
e. Angiodiplasia

Respuesta correcta: a. Pólipo juvenil

Explicación: Tanto el pólipo juvenil como el divertículo de Meckel pueden producir hematoquecia y tener un examen físico normal. Sin embargo, los pólipos juveniles (hamartomas vasculares) son más frecuentes y suelen tener clínicas leves, con hemorragia indolora que suele estar alrededor del bolo fecal. En cambio, el divertículo de Meckel puede tener hemorragias más severas y complicarse con una diverticulitis muy similar a la apendicitis (por estar en el intestino delgado, la sangre suele venir mezclada con deposiciones). El diagnóstico de los pólipos juveniles es con colonoscopía. El diagnóstico del divertículo de Meckel es con con cintigrafía o con una TAC. Hasta el 2% de las personas tienen divertículo de Meckel, pero rara vez tienen síntomas (solo se operan los sintomáticos).

Fuente: Digestivo pediátrico P29

29. ¿Qué microrganismo produce frecuentemente diarrea crónica en el escolar?

a. Entamoeba coli
b. Entamoeba hystolytica
c. Escherichia coli
d. Campilobacter jejuni
e. Giardia lambia

Respuesta correcta: e. Giardia lambia

Explicación: La giardiasis es frecuente, especialmente en zonas sin agua potable o sin recursos. Su clínica varía desde ser completamente asintomática, hasta un cuadro de diarrea crónica y síndrome de malabsorción. El diagnóstico se puede hacer con microscopía de deposiciones o con PCR. El tratamiento de elección es el tinidazol. El metronidazol es menos efectivo.

Fuente: Digestivo pediátrico P30

30. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede simular un síndrome de malabsorción intestinal, con mayor frecuencia?

a. Ascaris lumbricoides
b. Oxiuros
c. Entoameba histolítica
d. Balantidium coli
e. Giardia lambia

Respuesta correcta: e. Giardia lambia

Explicación: La giardiasis es bastante frecuente en Chile y el mundo. Su clínica puede ser desde asintomática o tener algún grado de malestar, hasta producir diarrea crónica y un síndrome completo de malabsorción intestinal.

Fuente: Nutrición pediátrica P4

31. Un lactante de 10 meses presenta deposiciones líquidas 4 a 5 veces al día, sin vómitos ni fiebre, desde hace tres días. Se alimenta bien con lactancia artificial más almuerzo y comida con postre. Al examen físico se encuentra afebril, con buen estado general, sin signos de deshidratación, con el abdomen distendido, ruidos hidroaéreos aumentados y bazuqueo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Hidratar por vía oral por 4 horas y luego continuar con su misma alimentación
b. Administrar sales de hidratación oral después de cada deposición y eliminar los residuos de la dieta
c. Reemplazar leche actual por leche modificada sin lactosa
d. Hidratar por vía oral por 4 horas y luego continuar con leche modificada sin lactosa
e. Diluir la leche y eliminar los residuos de la dieta

Respuesta correcta: b. Administrar sales de hidratación oral después de cada deposición y eliminar los residuos de la dieta

Explicación: Tiene una diarrea aguda sin deshidratación o con deshidratación leve, por lo que se debe manejar con “Plan A” (recordar marcar la alternativa que corresponde y no la A, que es un error frecuente; lo mismo con la hepatitis A, la vitamina A, etc.).

Fuente: Nutrición pediátrica P8

Nefrología y urología (21)

1. Joven de 15 años, con cuadro de dos días de evolución, de odinofagia, fiebre leve y rinorrea. Presenta varios episodios de hematuria indolora. El examen físico resulta normal. La analítica demuestra hemograma, función renal y hepática normales. El sedimento de orina muestra eritrocitos dismórficos abundantes. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoídea)
b. Glomerulopatía membranosa
c. Glomerulonefritis rápidamente progresiva
d. Enfermedad de Berger / Nefropatía por IgA
e. Glomerulonefritis aguda postestreptocócica

Respuesta correcta: d. Enfermedad de Berger / Nefropatía por IgA

Explicación: Tiene un glomerulonefritis (hematuria dismórfica), cuya causa más frecuente es la nefropatía por IgA (puede presentarse solo con hematuria, o bien venir con síndrome nefrítico e incluso proteinuria). No tiene insuficiencia renal, porque está normal la función renal (no es la C). No tiene síndrome nefrítico, porque no tiene edema ni HTA (no es la E). No tiene síndrome nefrótico, porque no tiene proteinuria ni edema (no es la A ni B).

Tiene una GNA, sin síndrome nefrítico, ni nefrótico, por lo que lo más probable es que sea una glomerulonefritis por depósitos de IgA, también conocida como enfermedad de Berger.

Fuente: Cuestionario 3.1 P5 · Nefrología pediátrica P16

2. Las Infecciones del tracto urinario en los niños generalmente deben estudiarse a fin de detectar la presencia de malformaciones que aumentan el riesgo de recurrencia de la infección y de daño renal. ¿Cuál de las siguientes opciones enumera los exámenes que deben solicitarse para cumplir este objetivo en lactantes con infecciones urinarias febriles?

a. Cintigrafía renal estática y dinámica
b. Cintigrafía renal estática y cintigrafía renal dinámica
c. Uretrocistografía miccional seriada y ecografía renal y vesical
d. Tomografía de abdomen y pelvis y cintigrafía renal dinámica
e. Ecografía renal y vesical y cintigrafía renal dinámica

Respuesta correcta: c. Uretrocistografía miccional seriada y ecografía renal y vesical

Explicación: Las ITU en pediatría se deben estudiar, en busca de malformaciones y reflujo vesicoureteral. El examen mínimo es la ecografía renal y vesical. En el caso de que esté alterada, o si es una ITU febril en un lactante menor de 1 año, se realiza además la uretrocistografía y la cintigrafía estática DMSA. Sin embargo, estas recomendaciones no son compartidas por todos. De hecho, muchas recomendaciones internacionales solo indican el estudio de ITU febriles y no de las cistitis, usando los siguientes criterios:

- Ecografía: solo en ITU febril que 1. primer episodio en menor de dos años, 2. segundo episodio a cualquier edad,

3. que no responde o 4. con clínica de falla renal.

- UGC: solo en ITU febril que 1. tiene ecografía alterada, 2. segundo episodio, 3. germen distinto a E. coli o 4. clínica de falla renal.

Fuente: Infectología pediátrica P1

3. La primera causa de insuficiencia renal crónica en los niños es:

a. Hipertensión arterial
b. Glomerulonefritis aguda
c. Diabetes mellitus
d. Malformaciones congénitas
e. Síndrome hemolítico urémico

Respuesta correcta: d. Malformaciones congénitas

Explicación: Aquello incluye el riñón poliquístico infantil, el reflujo vesicoureteral y las malformaciones obstructivas, que, en conjunto, suponen la primera causa de IRC infantil.

Fuente: Nefrología pediátrica P1

4. El examen de elección para diferenciar una insuficiencia renal aguda prerrenal, de una necrosis tubular aguda es:

a. El clearence de creatinina
b. La relación BUN/creatinina
c. El hemograma
d. La fracción excretada de sodio
e. El sedimento de orina

Respuesta correcta: d. La fracción excretada de sodio

Explicación: Al igual que en los adultos, la IRA prerrenal y renal se diferencian en que la prerrenal tiene FeNa menor a 1% (el sodio urinario también sirve, estando habitualmente bajo 10 mEq/L. En la NTA, por el contrario, suele tener FeNa mayor a 3%, con sodio urinario mayor a 20 mEq/L, además de múltiples células y cilindros granulosos y céreos en el sedimento).

Fuente: Nefrología pediátrica P2

5. La conducta más adecuada ante un paciente de 10 años, cursando con un síndrome nefrótico impuro, asociado a hipertensión y hematuria es:

a. Iniciar con corticoides orales
b. Administrar pulsos endovenosos de metilprednisolona
c. Iniciar inmunosupresores, asociados a corticoides endovenosos
d. Iniciar una asociación de corticoides, inmunosupresores y antibióticos, con cobertura para estreptococo betahemolítico del grupo A
e. Derivar para realización de una biopsia renal

Respuesta correcta: e. Derivar para realización de una biopsia renal

Explicación: Si es impuro, se debe biopsiar. En cambio, los síndromes nefróticos puros en pediatría, por regla general, se tratan con corticoides en altas dosis, ya que suelen ser por enfermedad de cambios mínimos o

nefrosis lipoidea, por lo que únicamente se biopsian si es que no responden. Para la proteinuria, además, se indican IECA o ARA2. Algo que vale la pena recordar es que en el menor de 1 año, todo síndrome nefrótico se asume genético, por lo que va directamente al estudio genético y eventual biopsia (requieren trasplante renal).

Fuente: Nefrología pediátrica P3

6. Cuál de las siguientes alternativas representa mejor la clínica del síndrome nefrítico:

a. Edema, hematuria dismórfica y rápida elevación de la creatinina
b. Hipertensión arterial, lipiduria y proteinuria
c. Proteinuria, hematuria dismórfica y orinas espumosas
d. Edema, hipertensión arterial y hematuria dismórfica
e. Orina espumosa, hematuria dismórfica y proteinuria

Respuesta correcta: d. Edema, hipertensión arterial y hematuria dismórfica

Explicación: La triada característica es HTA, edema y hematuria. Puede tener falla renal y proteinuria (en rango no nefrótico), así como palidez.

Fuente: Nefrología pediátrica P5

7. Un niño de 7 años, con retraso estaturo-ponderal, presenta signos radiológicos de raquitismo y ecográficos de nefrocalcinosis. Los análisis demuestran acidosis metabólica con pH inferior a 7,32 y bicarbonato plasmático inferior a 17 mEq/l. El pH de la orina es siempre superior a 5,5. Presenta además hipercalciuria, hipocitruria y discreta disminución de la resorción del fósforo. No se detecta glucosuria ni aminoaciduria. El diagnóstico más probable es:

a. Acidosis tubular renal tipo I
b. Acidosis tubular renal tipo II
c. Hiperparatiroidismo primario
d. Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo secundario
e. Enfermedad poliquística del niño

Respuesta correcta: a. Acidosis tubular renal tipo I

Explicación: Es una acidosis tubular renal clásica: Acidosis metabólica (pH bajo y bicarbonato bajo en sangre) más orinas con tendencia a ser alcalinas (demostrando que la acidosis es por pérdidas renales de bicarbonato). Además, suelen tener hiponatremia e hipokalemia. Si tuviese glucosuria y aminoaciduria, sería tipo II. Finalmente, la tipo IV (hipoaldosteronismo hiporreninémico) se caracteriza por tener hiperkalemia y asociarse a diabetes.

Fuente: Nefrología pediátrica P6

8. El recuento de colonias necesario para diagnosticar una infección urinaria, por medio de un urocultivo, cuya muestra fue obtenida por punción vesical, es:

a. 1 a 1.000 según la fuente
b. 10.000
c. 30.000
d. 50.000
e. 100.000

Respuesta correcta: a. 1 a 1.000 según la fuente

Explicación: El punto de corte varía según la fuente. Suele ser mayor o igual a 100.000 UFC/ml en orina de segundo chorro, a 10.000-50.000 en las por cateterismo y a 1-1.000 en las por punción. EN la práctica es infrecuente encontrar pacientes que estén en las zonas grises.

Fuente: Nefrología pediátrica P7

9. La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, en los niños es:

a. Prerrenal
b. Necrosis tubular aguda
c. Glomerulonefritis aguda
d. Infección del tracto urinario
e. Síndrome hemolítico urémico

Respuesta correcta: a. Prerrenal

Explicación: Al igual que en los adultos, la falla renal prerrenal, ya sea por deshidratación, shock, hemorragia u otra causa de hipovolemia es la más frecuente. La asociada a insuficiencia cardíaca, aunque no tiene hipovolemia, también es de tipo prerrenal.

Fuente: Nefrología pediátrica P8

10. El principal problema de la agenesia renal bilateral congénita es:

a. Su asociación con cardiopatías congénitas
b. La necesidad de hemodiálisis a permanencia
c. Su asociación a defectos del tubo neural
d. La necesidad de trasplante renal, dentro del primer mes de vida
e. La incompatibilidad con la vida, dada por hipoplasia pulmonar

Respuesta correcta: e. La incompatibilidad con la vida, dada por hipoplasia pulmonar

Explicación: La agenesia renal congénita suele traducirse en un oligohidroamnios severo, que finalmente se traduce en una grave hipoplasia pulmonar, que suele ser fatal. Además, son frecuentes las alteraciones faciales y de extremidades, por la falta de espacio en el líquido amniótico (síndrome de Potter).

Fuente: Nefrología pediátrica P9

11. Una madre trae a su hijo de 4 años, porque continúa orinándose en la cama mientras duerme. Durante el día presenta continencia normal y el desarrollo psicomotor es adecuado para su edad. El diagnóstico más probable es:

a. Infección urinaria
b. Malformación congénita urogenital
c. Enuresis primaria
d. Hiposecreción de ADH
e. Sano

Respuesta correcta: e. Sano

Explicación: La enuresis primaria se diagnostica a los 5 años en niñas y hasta en los 6 años en niños. Antes, orinarse al dormir se considera algo normal, aunque la mayoría de los niños logra la continencia diurna entre los 2 y 3 años y la nocturna entre los 2 y 4 años. La enuresis primaria (llega a la edad sin nunca haber logrado la continencia), sin otros síntomas, suele resolver sola, por lo que la educación es lo más importante, junto a asegurar que no afecte el autoestima del niño. Se recomienda dar terapia conductual (tomar poca agua en la noche, orinar antes de acostarse). Se puede usar una cartilla miccional con recompensas. Si no responde, se puede observar o agregar desmopresina o una alarma de enuresis (suena cuando se empieza a mojar). La enuresis secundaria (había logrado la continencia y luego la pierde, en cambio, se debe estudiar siempre.

Fuente: Nefrología pediátrica P10

12. La conducta más adecuada ante un paciente de 3 meses de edad, cuyo testículo izquierdo es imposible de palpar, es.

a. Tranquilizar a la madre e indicarle que esta condición no tiene ninguna repercusión negativa sobre el lactante
b. Derivar a especialista para examen físico y estudio ecográfico
c. Realizar orquidopexia quirúrgica al cumplir 18 meses
d. Realizar orquidopexia inmediata
e. Realizar laparoscopía abdominal

Respuesta correcta: b. Derivar a especialista para examen físico y estudio ecográfico

Explicación: El testículo no palpable, en la mayoría de los casos, corresponde a una criptorquídea (queda en el trayecto de migración testicular), pero también puede tener un testículo ectópico (pasa el conducto inguinal, pero termina en un lugar inadecuado) o ser una agenesia testicular. La evaluación clínica suele ser la más importante, idealmente por alguien entrenado. La ecografía inguinoescrotal no es un examen mejor que el examen físico, pero suele pedirse igualmente, como una forma de objetivar el problema. La exploración quirúrgica por laparoscopía es el examen de elección para encontrar el testículo no palpable, pero suele hacerse a los 12 meses, aunque algunas recomendaciones plantean hacerlo mucho más temprano (ej. desde los 4 o 6 meses). Si el ninguno de los dos testículos son palpables, el primer examen debe ser el cariograma.

Fuente: Nefrología pediátrica P11

13. Un niño de 6 años es traído por edema facial y escrotal, asociado a orinas espumosas. Al examen físico se corrobora dicho edema. Se solicitan exámenes que demuestran proteinuria de 4,6 g/24h, lipiduria, sin hematuria. La creatinina, BUN, hemograma, C3 y C4 son normales. El diagnóstico más probable es:

a. Nefrosis lipoidea
b. Glomerulonefritis postestreptocócica
c. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
d. Glomerulopatía membranosa
e. Glomerulonefritis mesangiocapilar

Respuesta correcta: a. Nefrosis lipoidea

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico puro, cuya causa más frecuente en niños es la nefrosis lipoidea (nombre clínico) o enfermedad de cambios mínimos (nombre histológico). Suele presentarse entre los 5 y 10 años de edad y responder a corticoides en dosis altas (se espera un mes para ver si hay respuesta o no); si no responde, se biopsia.

Fuente: Nefrología pediátrica P12

14. Una niña de 2 años de edad sufre un episodio de pielonefritis aguda, por Escherichia coli multisensible. La conducta más adecuada para esta paciente es:

a. Iniciar tratamiento y luego profilaxis antibiótica con ciprofloxacino, sin necesidad de mayor estudio
b. Iniciar tratamiento y luego profilaxis antibiótica con cefadroxilo, sin necesidad de mayor estudio
c. Iniciar tratamiento y luego profilaxis antibiótica con cefadroxilo y solicitar ecografía abdominal
d. Iniciar tratamiento con nitrofurantoína y solicitar urocultivos mensuales seriados
e. Iniciar tratamiento con ciprofloxacino y solicitar urocultivos mensuales seriados

Respuesta correcta: c. Iniciar tratamiento y luego profilaxis antibiótica con cefadroxilo y solicitar ecografía abdominal

Explicación: La redacción de las opciones otorga algún grado mayor de dificultad a esta pregunta. El tratamiento de la PNA en pediatría suele ser con cefalosporinas. La nitrofurantoína puede usarse en las ITU baja. Como opción, se puede usar el cotrimoxazol (sulfametoxazol más trimetoprim). Luego, las ITU en pediatría se deben estudiar, en busca de malformaciones y reflujo vesicoureteral. El examen mínimo es la ecografía renal y vesical. En el caso de que esté alterada, o si es una ITU febril en un lactante menor de 1 año, se realiza además la uretrocistografía y la cintigrafía estática DMSA. Sin embargo, estas recomendaciones no son compartidas por todos. De hecho, muchas recomendaciones internacionales solo indican el estudio de ITU febriles y no de las cistitis, usando los siguientes criterios: - Ecografía: solo en ITU febril que 1. primer episodio en menor de dos años, 2. segundo episodio a cualquier edad, 3. que no responde o 4. con clínica de falla renal. - UGC: solo en ITU febril que 1. tiene ecografía alterada, 2. segundo episodio, 3. germen distinto a E. coli o 4. clínica de falla renal. Finalmente, la profilaxis antibiótica suele indicarse solo en pacientes con alteraciones no corregidas que predisponen a ITU (ej. reflujo vesicoureteral), que tienen ITUs recurrentes (discutibles cuántas: desde la tercera es el criterio más aceptado o desde 2 si hay algún factor de riesgo), o mientras se realiza el estudio (como en este caso). No es necesario realizar urocultivos de control ni de seguimiento.

Fuente: Nefrología pediátrica P13

15. Un paciente 4 años, cursando un cuadro disentérico, evoluciona con palidez y oligoanuria. Al examen se aprecia hidratado, con leve edema palpebral. El diagnóstico de sospecha es:

a. Síndrome nefrítico postinfeccioso
b. Síndrome hemolítico urémico
c. Insuficiencia renal aguda prerrenal
d. Sepsis por bacterias Gram negativas
e. Síndrome nefrótico

Respuesta correcta: b. Síndrome hemolítico urémico

Explicación: Es un SHU clásico. Por el edema, no puede ser IRA prerrenal. La palidez orienta a anemia.

Fuente: Nefrología pediátrica P14

16. La primera medida que debe tomarse ante una hiperkalemia grave, que cursa con bradicardia, es:

a. Realizar hemodiálisis de urgencia
b. Administrar insulina y glucosa endovenosa
c. Iniciar beta agonistas por nebulización
d. Administrar gluconato de calcio endovenoso
e. Administrar suero fisiológico por vía periférica

Respuesta correcta: d. Administrar gluconato de calcio endovenoso

Explicación: Al igual que en los adultos, lo primero a hacer en una hiperkalemia grave es estabilizar la membrana miocárdica con calcio (generalmente gluconato de calcio en bolo endovenoso).

Fuente: Nefrología pediátrica P15

17. Un recién nacido de 24 horas de vida, con un peso de 2.500 g. Presenta signos de irritabilidad, apnea, arritmia cardíaca y finalmente convulsiones. El diagnóstico más probable es:

a. Hipercalcemia
b. Hipocalcemia
c. Hiponatremia
d. Hiperkalemia
e. Hipokalemia

Respuesta correcta: b. Hipocalcemia

Explicación: Es una hipocalcemia clásica, típica de recién nacidos prematuros e hijos de madre diabética. La hipoglicemia puede tener una clínica muy similar y es mucho más frecuente en esos grupos, por lo que siempre se debe tomar un hemoglucotest como primera medida. Eso sí, la arritmia cardíaca sugiere más una hipocalcemia que hipoglicemia. Suele alargar el QT y desencadenar torsión de puntas. Se trata con calcio EV.

Fuente: Nefrología pediátrica P17

18. Un niño de 11 años presenta hematuria dismórfica, asociado a artralgias y aparición de lesiones eritematosas, palpables, que no blanquean a la compresión, en ambas extremidades. En una ocasión presenta además hematoquezia. El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura de Schönlein-Henoch
b. Granulomatosis de Wegener
c. Síndrome hemolítico urémico
d. Tumor de Wilms
e. Sepsis diseminada de foco urinario inicial

Respuesta correcta: a. Púrpura de Schönlein-Henoch

Explicación: Es una PSH clásica. Se observa, aunque se trata con corticoides si tiene síntomas severos (ej. falla renal, hematuria, hemorragia digestiva, mucho dolor abdominal o articular.

Fuente: Nefrología pediátrica P18

19. El riñón poliquístico del niño es un trastorno:

a. Autosómico dominante
b. Autosómico recesivo
c. Ligado al cromosoma X
d. De herencia mitocondrial
e. No hereditario

Respuesta correcta: b. Autosómico recesivo

Explicación: El RPQ del adulto suele ser autosómico dominante. El RPQ infantil, en cambio, suele ser recesivo. El diagnóstico, muchas veces, se hace antenatalmente, con la ecografía obstétrica.

Fuente: Nefrología pediátrica P19

20. Un niño de un año de edad, cursando infección respiratoria alta, con buena evolución, presenta presión arterial de 120/80 mmHg en 3 mediciones distintas. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio sin necesidad de nuevos controles de presión arterial
b. Enviar a domicilio y realizar pesquisa de hipertensión arterial cada 6 meses
c. Iniciar dieta hiposódica
d. Iniciar tratamiento antihipertensivo con iECA
e. Iniciar estudio en busca de una causa de hipertensión arterial secundaria

Respuesta correcta: e. Iniciar estudio en busca de una causa de hipertensión arterial secundaria

Explicación: La HTA en niños siempre se debe estudiar, ya que el 90% son secundarias. En los adolescentes ya es más frecuente la HTA primaria o esencial, aunque igualmente deben estudiarse.

Fuente: Nefrología pediátrica P20

21. ¿Cuál de las siguientes glomerulonefritis NO cursan con hipocomplementemia?

a. Glomerulonefritis lúpica
b. Glomerulonefritis postestreptocócica
c. Enfermedad de Berger
d. Glomerulonefritis asociada a endocarditis subaguda
e. Glomerulonefritis mesangiocapilar

Respuesta correcta: c. Enfermedad de Berger

Explicación: Las principal glomerulonefritis hipocomplementémica es la postinfecciosa o postestreptocócica (GNAPE). Las demás, que se pueden confundir con una GNAPE, hay que saberlas y son: lupus, mesangiocapilar o membranoproliferativa, crioglobulinemia, asociada a endocarditis o sepsis. No son hipocomplementémicas la por IgA o Berger, las vasculitis, la por anticuerpos antimembrana basal.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P9

Endocrinología y diabetes (41)

1. Un paciente de 5 años, cursando una meningococcemia presenta hipotensión, que no responde a suero fisiológico y que es difícil de controlar con uso de noradrenalina en bomba de infusión continua. Presenta, además, a hipoglicemia e hiperkalemia. La conducta más adecuada, además del manejo de la sepsis es:

a. Administrar glucosa al 30% por vía endovenosa
b. Administrar glucosa y corticoides endovenosos
c. Administrar levotiroxina
d. Solicitar gases venosos y cuerpos cetónicos
e. Iniciar insulina en esquema intensificado

Respuesta correcta: b. Administrar glucosa y corticoides endovenosos

Explicación: Se sospecha un síndrome de Waterhouse-Friderichsen (insuficiencia suprarrenal aguda, por hemorragia bilateral de las suprarrenales). La hiperkalemia, hipoglicemia y shock refractario son características y obligan a administrar corticoides endovenosos, ante la sola sospecha.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P1

2. Un niño de 10 años, diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensivo, presenta cuadro de sudoración, temblor y actitud agresiva, seguida luego de inconciencia. El diagnóstico más probable es:

a. Accidente vascular encefálico
b. Cetoacidosis diabética
c. Coma hiperglicémico hiperosmolar
d. Hipoglicemia
e. Encefalitis herpética

Respuesta correcta: d. Hipoglicemia

Explicación: Es una hipoglicemia clásica, por insulina. Se debe tratar con glucosa endovenosa, por el compromiso de conciencia.

Tiene una hipoglicemia clásica, con síntomas adrenérgicos, seguidos de síntomas neuroglucopénicos. El AVE tiene signos focales súbitos y es rarísimo en niños. La cetoacidosis puede tener compromiso de conciencia, pero sus síntomas suelen ser malestar general, dolor abdominal, respiraciones profundas, signos de deshidratación. El coma hiperglicémico hiperosmolar es raro en niños y tiene compromiso de conciencia, malestar general y deshidratación. La encefalitis herpética tiene clínica de meningitis (cefalea, fiebre y signos meníngeos), más compromiso de conciencia, convulsiones, lesiones temporales en la TAC y líquido cefalorraquídeo hemorrágico.

Es una hipoglicemia clásica. Se debe diagnosticar con glicemia capilar y se trata con glucosa endovenosa, por estar con compromiso de conciencia.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P2 · Cuestionario 3.1 P12 · Endocrinología pediátrica P7

3. Una niña de 6 años presenta vello púbico y desarrollo mamario. No presenta otros síntomas y su examen físico no entrega mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Tranquilizar a la madre e indicarle que su hija es normal
b. Solicitar cariotipo
c. Solicitar niveles plasmáticos de dihidroepiandrosterona (DHEA)
d. Solicitar edad ósea, ecografía pélvica, niveles plasmáticos de gonadotropinas, hormonas sexuales esteroidales y prueba de estimulación de GnRH
e. Solicitar ecografía transvaginal

Respuesta correcta: d. Solicitar edad ósea, ecografía pélvica, niveles plasmáticos de gonadotropinas, hormonas sexuales esteroidales y prueba de estimulación de GnRH

Explicación: Tiene una pubertad precoz (antes de 9 años en niños y 8 años en niñas), por lo que se debe estudiar ampliamente. El test de estimulación de GnRH puede hacerse de segunda línea.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P3

4. El porcentaje de hemoglobina glicosilada, si se determina correctamente, ofrece una estimación del control diabético, aproximadamente, durante:

a. El mes anterior.
b. Los 3 meses anteriores.
c. Los 6 meses anteriores.
d. Los 9 meses anteriores.
e. Los 12 meses anteriores.

Respuesta correcta: b. Los 3 meses anteriores.

Explicación: A diferencia de la glicemia de ayuna que puede ser alterada por el paciente con su comportamiento reciente, la HbA1c refleja 2 a 3 meses de glicemias.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P5

5. El tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita suele ser

a. Quirúrgico
b. Agonistas GnRH
c. Cortisol
d. Finasteride
e. Flutamida

Respuesta correcta: c. Cortisol

Explicación: Se deber a una causa genética en la que no se produce cortisol. Se corrige dando el cortisol. En las “perdedoras de sal” también falta aldosterona, por lo que, además, requieren análogos de esta hormona (ej. fludrocortisona).

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P6

6. El primer signo de desarrollo puberal en varones es:

a. Vello púbico
b. Crecimiento peneano
c. Crecimiento testicular
d. Cambio de la voz
e. Olor axilar

Respuesta correcta: c. Crecimiento testicular

Explicación: Es el crecimiento testicular y luego peneano.
En niñas, la telarquia (botón mamario o mama Tanner 2) es el primer signos de desarrollo puberal propiamente tal. En niños, suele ser el aumento de volumen testicular. La pubarquia (vello púbico) puede verse tanto en la adrenarquia como en la pubertad.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P7 · Endocrinología pediátrica P4

7. ¿Qué alteración es MENOS probable de encontrar en un paciente con síndrome de Klinefelter?

a. Disminución de los niveles plasmáticos de gonadotropinas
b. Disminución del tamaño testicular
c. Disminución de los niveles plasmáticos de testosterona
d. Talla normal
e. Ginecomastia

Respuesta correcta: a. Disminución de los niveles plasmáticos de gonadotropinas

Explicación: El síndrome de Klinefelter se asocia a hipogonadismo hipergonadotrópico (al igual que el sídrnome de Turner).

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P8

8. Un paciente diabético tipo 1, de 6 años, en tratamiento con insulina en esquema intensificado, inicia un cuadro de astenia y poliuria de 2 días de evolución, seguido de malestar marcado y compromiso de conciencia. Al examen físico está deshidratado, con FC: 105x', PA: 90/60, en sopor superficial, con respiraciones profundas, sin focalidad neurológica ni alteraciones cardiopulmonares. El electrocardiograma muestra FC: 102x', regular, con QRS angosto y alteraciones inespecíficas de la repolarización. El diagnóstico más probable es:

a. Hipoglicemia por insulina
b. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
c. Cetoacidosis diabética
d. Hipokalemia por insulina
e. Hipoglicemia reactiva

Respuesta correcta: c. Cetoacidosis diabética

Explicación: Es una cetoacidosis clásica.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P9

9. Un niño de 5 años, obeso, presenta poliuria y baja de peso. Se solicita glicemia de ayuno que resulta 250 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar dieta y ejercicios y controlar en 3 meses
b. Iniciar dieta, ejercicios, solicitar hemoglobina glicosilada y controlar con resultado
c. Iniciar metformina y controlar en 3 meses
d. Iniciar insulina lenta en 2 dosis, una matinal y otra nocturna
e. Hospitalizar para inicio de insulinoterapia en esquema intensificado

Respuesta correcta: e. Hospitalizar para inicio de insulinoterapia en esquema intensificado

Explicación: Tiene diagnóstico de diabetes: síntomas más glicemia mayor o igual a 200 mg/dl. Toda diabetes infantil se asume tipo 1 y se trata con insulina en bomba o en esquema intensificado (glargina 1 dosis basal más 3 dosis de insulina cristalina).

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P10

10. La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es:

a. Hipopituitarismo
b. Alteraciones de la conversión periférica de T4 en T3
c. Disgenesia tiroidea
d. Déficit de yodo
e. Tiroiditis crónica

Respuesta correcta: c. Disgenesia tiroidea

Explicación: Dos tercios de los hipotiroidismo congénitos se deben a disgenesia tiroidea (agenesia, hipogenesia o ectopia) con o sin alteraciones funcionales asociadas. Otras causas se deben a insensibilidad a la TSH o disfunción en la síntesis de hormonas tiroideas.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P11 · Endocrinología pediátrica P20

11. La principal hormona determinante del crecimiento luego del nacimiento es:

a. Hormona de crecimiento
b. Tiroxina
c. Insulina
d. Cortisol
e. Testosterona / Estrógeno

Respuesta correcta: a. Hormona de crecimiento

Explicación: La insulina es la hormona más importante del crecimiento intrauterino. La GH es la más importante del crecimiento extrauterino. Las hormonas sexuales también influyen acelerando el crecimiento, pero cerrando el cartílago de crecimiento metafisiario.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P12

12. Una lactante de 4 meses, con genitales ambiguos, presenta tendencia a la hipotensión. En sus exámenes presenta glicemia: 70mg/dl, K:5,8 mEq/l, Na: 130 mEql, hematocrito: 40%. El diagnóstico es:

a. Enfermedad de Addison
b. Enfermedad de Cushing
c. Tumor hipofisiario
d. Disgenesia gonadal
e. Hiperplasia suprarrenal congénita

Respuesta correcta: e. Hiperplasia suprarrenal congénita

Explicación: Tiene una insuficiencia suprarrenal, con las alteraciones clásicas. La HSRC es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en lactantes y en niños en general.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P13

13. ¿Cuál es el primer signo de desarrollo puberal en una niña?

a. Menarquia
b. Adrenarquia
c. Pubarquia
d. Telarquia
e. Aumento de la velocidad de crecimiento

Respuesta correcta: d. Telarquia

Explicación: En niñas, la telarquia (botón mamario o mama Tanner 2) es el primer signos de desarrollo puberal propiamente tal. En niños, suele ser el aumento de volumen testicular. La pubarquia (vello púbico) puede verse tanto en la adrenarquia como en la pubertad.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P14

14. Un recién nacido presenta un resultado positivo en la prueba de screening para hipotiroidismo congénito, con sangre de talón. Se solicita confirmación con TSH sérica, la que resulta elevada. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar levotiroxina
b. Solicitar nueva TSH en 1 mes y decidir conducta según resultado
c. Solicitar anticuerpos antitiroídeos y T4 libre y decidir conducta según resultados
d. Solicitar TRH, T4 y T3 y decidir manejo según resultados
e. Iniciar suplemento de yodo, con lugol oral y solicitar nueva TSH y T4 en 15 días

Respuesta correcta: a. Iniciar levotiroxina

Explicación: El screening se realiza entre las 24 y 72 horas de vida y consiste en TSH en sangre capilar, en una muestra tomada en papel. Está positivo si la TSH sérica está sobre 15 UI/mL (o TSH sanguínea sobre 20 UI/ml). En ese caso, se debe solicitar inmediatamente una nueva TSH y, además, T4 libre, pero en sangre venosa. Si están alteradas (TSH alta y T4 libre), se confirma el hipotiroidismo primario y se debe iniciar tratamiento de inmediato, sin retrasar su inicio por buscar la etiología. Si la T4 está normal, tendría un hipotiroidismo subclínico y se repiten los exámenes en 7 días, siendo discutible si tratarlo o no. Si tanto TSH

como T4 libre están normales, pues se trató de un falso positivo del screening. En algunos países se prefiere hacer el screening con T4, en lugar de TSH y es algo aceptable.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P16

15. Un muchacho de 12 años acude al hospital con disminución del apetito, aumento de la sed, micción frecuente y pérdida de peso durante las últimas tres semanas. En las últimas 24 horas aparece letárgico. Los análisis muestran una natremia de 147 mEq/l, una potasemia de 5,6 mEq/l, un cloro de 112 mEq/l, un bicarbonato de 6 mEq/l, una glucosa de 536 mg/dl, una urea de 54 mg/dl, una creatinina de 2 mg/dl y un pH de 7,18. La cetonuria es positiva. ¿Cuál de las siguientes es la medida más adecuada para comenzar el tratamiento de este paciente?:

a. Hidratación con salino hipotónico, 10 U. de insulina subcutánea y bicarbonato.
b. Hidratación con salino isotónico y perfusión i.v. de insulina.
c. Hidratación con salino isotónico, perfusión de insulina i.v., bicarbonato y potasio.
d. Hidratación con salino hipotónico, perfusión de insulina i.v. y bicarbonato.
e. Hidratación con salino hipotónico, con potasio y 10 U. de insulina subcutánea.

Respuesta correcta: b. Hidratación con salino isotónico y perfusión i.v. de insulina.

Explicación: Tiene una cetoacidosis diabética. No requiere bicarbonato porque el pH es mayor a 6,9. No requiere potasio, porque el K+ está mayor a 5 mE/L.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P17

16. Una niña de 7 años consulta por aparición de escaso vello púbico, Tanner 2, asociado a olor axilar adulto. No presenta desarrollo mamario ni menstruación y su crecimiento se ha mantenido normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Pubertad precoz central
b. Pubertad precoz periférica
c. Pubertad normal
d. Adrenarquia precoz
e. Adrenarquia normal

Respuesta correcta: d. Adrenarquia precoz

Explicación: La adrenarquia puede tener varias manifestaciones. La más frecuente es el olor axilar adulto. Además, puede tener pubarquia (vello púbico) y vello axilar. Por el contrario, no debe tener botón mamario en niñas ni aumento del tamaño testicular o peneano en niños, ya que aquello es característico de la pubertad propiamente tal. La importancia en diferenciar una adrenarquia de la pubertad es que la adrenarquia precoz se considera algo benigno, que se puede observar y, a lo más, se estudia con edad ósea, mientras que la pubertad precoz se considera algo patológico, que requiere de múltiples exámenes endocrinos e imagenológicos. Tanto adrenarquia como pubertad se consideran precoces cuando ocurren antes de los 8 años en niñas y de los 9 años en niños.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P18

17. Una niña de 6 años, diagnosticada de coartación de aorta consulta por talla baja. En la exploración física se observa talla en Percentil 3 para su edad y cuello alado. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

a. Déficit de GH
b. Síndrome de Turner
c. Hipocondroplasia
d. Hipotiroidismo
e. Disgenesia gonadal pura

Respuesta correcta: b. Síndrome de Turner

Explicación: Es un síndrome de Turner clásico y se debe estudiar con cariograma.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P19

18. Se considera pubertad precoz el inicio del desarrollo puberal antes de:

a. Los 7 años en los niños y los 8 años en las niñas
b. Los 9 años en los niños y los 8 años en las niñas
c. Los 9 años en los niños y los 10 años en las niñas
d. Los 8 años en los niños y los 7 años en las niñas
e. Los 8 años en los niños y los 9 años en las niñas

Respuesta correcta: b. Los 9 años en los niños y los 8 años en las niñas

Explicación: Tanto adrenarquia como pubertad comienzan normalmente después de los 9 años en niños y después de los 8 años en niñas. El punto de corte para un retraso puberal es 4-5 años más, es decir, 13-14 años para los niños y 12- 13 años para las niñas.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P20

19. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS probable de ser encontrado en un niño con diabetes mellitus 1?

a. Acantosis nigricans
b. Proteinuria
c. Vasos de neoformación retininanos
d. Anticuerpos anti-insulina y anti-islote en plasma
e. Test de tolerancia a la glucosa con glicemia postcarga de 400 mg/dl

Respuesta correcta: a. Acantosis nigricans

Explicación: La acantosis nigricans sugiere resistencia a la insulina, lo que se asocia a la diabetes mellitus tipo 2 (no a la tipo 1).

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P21

20. Un niño de 11 años presenta aumento de volumen y leve dolor en la zona retroareolar izquierda. Al examen físico presenta ginecomastia unilateral izquierda de 1,5 cm de diámetro, sin secreción. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente
b. Solicitar niveles plasmáticos de estrógenos y FSH
c. Administrar testosterona en dosis bajas
d. Solicitar prolactina plasmática
e. Observar evolución

Respuesta correcta: e. Observar evolución

Explicación: Es una ginecomastia puberal benigna clásica.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P22

21. Un paciente diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensificado con dos dosis de insulina NPH y 3 dosis de insulina cristalina, presenta resumen de autocontroles con hemoglucotest, con los siguientes promedios: HGT ayuno: 100 mg/dl; postdesayuno: 120 mg/dl; prealmuerzo:80; postalmuerzo: 130 mg/dl; precena: 90 mg/dl y postcena: 150 mg/dl. No ha presentado síntomas de hipoglicemia y la hemoglobina glicosilada es 7,4%. La conducta más adecuada es:

a. Aumentar la insulina NPH matinal
b. Aumentar la insulina NPH vespertina
c. Aumentar la insulina cristalina precena
d. Aumentar la insulina cristalina prealmuerzo
e. Mantener el esquema sin modificaciones

Respuesta correcta: e. Mantener el esquema sin modificaciones

Explicación: Aunque la glicemia postcena está algo elevada (debe ser menor a 130-180, según la fuente), la HbA1c está menor a 8% (ese es el objetivo en niños), por lo que no se requieren mayores modificaciones.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P23

22. Un niño de 8 años, diabético en tratamiento con insulina desde hace 4 meses, presenta una hipoglicemia leve (HGT: 50), sólo con síntomas neurovegetativos, sin síntomas neuroglucopénicos. La conducta que debe recomendar a los padres, ante situaciones como ésta es:

a. Consultar inmediatamente en el servicio de urgencia más cercano
b. Suspender el uso de insulina lenta y controlar ambulatoriamente con el diabetólogo
c. Suspender el uso de insulina cristalina y controlar ambulatoriamente con el diabetólogo
d. Aprender a poner vía venosa periférica y administrar suero glucosado en la casa
e. Darle a tomar un líquido azucarado y luego indicarle que coma una colación

Respuesta correcta: e. Darle a tomar un líquido azucarado y luego indicarle que coma una colación

Explicación: Si no tiene compromiso neurológico se trata con glucosa oral. Si los tiene, requiere glucosa endovenosa. En ambos casos, requiere ajuste del tratamiento y prevención de hipoglicemias.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P24

23. ¿Con qué examen se evalúa la respuesta al tratamiento en un paciente con hipotiroidismo congénito?

a. Tomas seriadas de frecuencia cardíaca, temperatura y presión arterial
b. TSH
c. T4
d. T3
e. T4 libre

Respuesta correcta: b. TSH

Explicación: La TSH sirve para ajustar el tratamiento, con la única excepción del hipotiroidismo de causa central o hipofisiaria (y otras más raras), en que se requiere controlar con T4. Si la TSH está sobre el rango, se aumenta la dosis de levoT4; si está bajo el rango, se disminuye la dosis; si está dentro del rango, se mantiene la dosis.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P25

24. Un paciente de 10 años presenta astenia y náuseas de 2 meses de evolución. Al examen físico destacan melanoplaquias en la mucosa oral y en sus exámenes generales se aprecia hematocrito: 45% blancos: 10.000 x mm3, con 60% de linfocitos, 25% de neutrófilos, 8% de monocitos y 7% de eosinófilos, plaquetas: 220.000 x mm3, glicemia: 60 mg/dl, Na+: 132 mEq/l, K+: 5,9 mEq/l, creatinina: 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Hiperplasia suprarrenal congénita clásica
b. Enfermedad de Addison
c. Secreción ectópica de ACTH
d. Hiperplasia suprarrenal atípica
e. Diabetes insípida

Respuesta correcta: b. Enfermedad de Addison

Explicación: Es una insuficiencia suprarrenal primaria (por la hiperpigmentación), clásica. Por la edad de presentación, parece una enfermedad de Addison (autoinmune). La HSRC es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en niños, pero suele dar síntomas precozmente, por tanto, habría tenido manifestaciones mucho antes. La HSRC atípica, en cambio, suele compensar el déficit de cortisol, pero a expensas de mantener altos niveles de estrógeno, por lo que se presenta como pubertad precoz o como hirsutismo en mujeres (muy similar al SOP, por lo que se recomienda pedir 17-hidroxiprogesterona en mujeres con SOP). En hombres suele ser asintomática.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P26

25. ¿Qué examen debe solicitarse para confirmar el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita?

a. Tomografía axial computada de abdomen
b. Cortisol libre urinario de 24 horas
c. Cortisol plasmático basal y post ACTH
d. Androstenediona y Dihidroepiandrosterona
e. 17-hidroxiprogesterona

Respuesta correcta: e. 17-hidroxiprogesterona

Explicación: La 17 hidroxiprogesterona es el metabolito que se acumula en la HSRC.
La 17-OH-progesterona es el examen más importante para el diagnóstico de la HSRC, ya que es el metabolito que se acumula. Luego se piden muchos otros exámenes para definir el tipo de HSRC y el tratamiento (se tratan con cortisol, pero las "perdedoras de sal", además, requieren mineralocorticoides, como la fludrocortisona). La más frecuente es la HSRC clásica, por déficit de la enzima 21-hidroxilasa. En algunos países se hace screening neonatal.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P27 · Endocrinología pediátrica P11

26. Un paciente de 6 años, diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensificado, con 1 dosis de insulina glargina (Lantus) y 3 refuerzos preprandiales con insulina cristalina, tiene los siguientes hemoglucotest promedio: Pre Desayuno: 220 Post Desayuno: 232 Pre Almuerzo: 162 Post Almuerzo: 132 Pre Cena: 150 Post Cena: 149 La conducta más adecuada es:

a. Agregar insulina NPH matinal
b. Aumentar la insulina cristalina pre-desayudno
c. Aumentar la insulina glargina
d. Aumentar la insulina cristalina pre-almuerzo
e. Aumentar la insulina cristalina pre-cena

Respuesta correcta: c. Aumentar la insulina glargina

Explicación: La insulina glargina determina las glicemias precomidas, que son las que hay que corregir (idealmente bajo 130- 100). Al corregirlas, se arreglarán también las glicemias postprandiales.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P28

27. La menarquia:

a. Suele iniciar 2 años después del inicio puberal
b. Suele iniciar 2 años después de la adrenarquia
c. En promedio inicia a los 16 años
d. Suele preceder a la aparición de vello púbico
e. Se presenta anticipadamente en las niñas con síndrome de Turner

Respuesta correcta: a. Suele iniciar 2 años después del inicio puberal

Explicación: Aunque es muy variable, la primera menstruación suele ocurrir 2 años después la telarquia.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P29

28. Un niño de 7 años presenta retraso del crecimiento, debilidad, astenia y cefalea. Al examen neurológico destaca defecto del campo visual bitemporal, asimétrico. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Cushing
b. Enfermedad de Addison
c. Craneofaringioma
d. Diabetes insípida
e. Hiperprolactinemia

Respuesta correcta: c. Craneofaringioma

Explicación: Tiene clínica de un tumor hipofisiario. De las opciones, el craneofaringioma es la única aceptable.

Tiene clínica de un tumor hipofisiario, con la afectación del quiasma óptico y los síntomas de hipopituitarismo. De las opciones que aparecen, el craneofaringioma es el único posible, aunque no necesariamente el más probable.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P30 · Endocrinología pediátrica P13

29. Un recién nacido presenta un resultado positivo en la prueba de screening para hipotiroidismo congénito, con sangre de talón. Se solicita confirmación con TSH sérica, la que resulta elevada con T4 libre baja. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar levotiroxina
b. Solicitar nueva TSH en 1 mes y decidir conducta según resultado
c. Solicitar anticuerpos antitiroideos y decidir conducta según resultados
d. Solicitar TRH, tiroglobulina y T3 y decidir manejo según resultados
e. Iniciar suplemento de yodo, con lugol oral y solicitar nueva TSH y T4 en 15 días.

Respuesta correcta: a. Iniciar levotiroxina

Explicación: El screening se realiza entre las 24 y 72 horas de vida y consiste en TSH en sangre capilar, en una muestra tomada en papel. Está positivo si la TSH sérica está sobre 15 UI/mL (o TSH sanguínea sobre 20 UI/ml). En ese caso, se debe solicitar inmediatamente una nueva TSH y, además, T4 libre, pero en sangre venosa. Si están alteradas (TSH alta y T4 libre), se confirma el hipotiroidismo primario y se debe iniciar tratamiento de inmediato, sin retrasar su inicio por buscar la etiología. Si la T4 está normal, tendría un hipotiroidismo subclínico y se repiten los exámenes en 7 días, siendo discutible si tratarlo o no. Si tanto TSH como T4 libre están normales, pues se trató de un falso positivo del screening. En algunos países se prefiere hacer el screening con T4, en lugar de TSH y es algo aceptable.

Fuente: Endocrinología pediátrica P1

30. La adrenarquia se caracteriza por:

a. Botón mamario
b. Aumento de la velocidad de crecimiento
c. Inicio de la fertilidad
d. Olor axilar adulto y/o parición de vello púbico
e. Pigmentación cutánea

Respuesta correcta: d. Olor axilar adulto y/o parición de vello púbico

Explicación: La adrenarquia puede tener varias manifestaciones. La más frecuente es el olor axilar adulto. Además, puede tener pubarquia (vello púbico) y vello axilar. Por el contrario, no debe tener botón mamario en niñas ni aumento del tamaño testicular o peneano en niños, ya que aquello es característico de la pubertad propiamente tal. La importancia en diferenciar una adrenarquia de la pubertad es que la adrenarquia precoz se considera algo benigno, que se puede observar y, a lo más, se estudia con edad ósea, mientras que la pubertad precoz se considera algo patológico, que requiere de múltiples exámenes endocrinos e imagenológicos. Tanto adrenarquia como pubertad se consideran precoces cuando ocurren antes de los 8 años en niñas y de los 9 años en niños.

Fuente: Endocrinología pediátrica P2

31. El primer signo de desarrollo puberal en niñas es:

a. Botón mamario
b. Vello púbico
c. Pigmentación de labios vaginales
d. Pigmentación de areola
e. Olor axilar

Respuesta correcta: a. Botón mamario

Explicación: En niñas, la telarquia (botón mamario o mama Tanner 2) es el primer signos de desarrollo puberal propiamente tal. En niños, suele ser el aumento de volumen testicular. La pubarquia (vello púbico) puede verse tanto en la adrenarquia como en la pubertad.

Fuente: Endocrinología pediátrica P3

32. Se considera pubertad precoz el inicio del desarrollo puberal antes de:

a. Los 6 años en los niños y los 7 años en las niñas
b. Los 9 años en los niños y las niñas
c. Los 9 años en los niños y los 8 años en las niñas
d. Los 8 años en los niños y los 7 años en las niñas
e. Los 8 años en los niños y los 9 años en las niñas

Respuesta correcta: c. Los 9 años en los niños y los 8 años en las niñas

Explicación: Tanto adrenarquia como pubertad comienzan normalmente después de los 9 años en niños y después de los 8 años en niñas. El punto de corte para un retraso puberal es 4-5 años más, es decir, 13-14 años para los niños y 12- 13 años para las niñas.

Fuente: Endocrinología pediátrica P5 · Crecimiento y nutrición pediátricas P29

33. Un joven de 14 años llega a su consultorio con la madre, porque están preocupados por sus mamas. El niño está bien desarrollado y con sobrepeso; tiene vello axilar y pubiano, y el desarrollo peneano y el crecimiento testicular están apropiados para la edad (etapa Tanner III). Sus mamas están aumentadas simétricamente de tamaño; el tejido mamario mide 3 cm. de diámetro a derecha y 4 cm a izquierda, con grosor de 0.5 cm. No hay inflamación ni flujo. El diagnóstico más probable es:

a. Ginecomastia puberal benigna
b. Ginecomastia secundaria a fumar marihuana
c. Síndrome de Klinefelter
d. Tumor adenocortical
e. Hiperplasia suprarrenal congénita

Respuesta correcta: a. Ginecomastia puberal benigna

Explicación: La primera causa de ginecomastia en los niños es la ginecomastia fisiológica, característica del periodo neonatal (en ambos sexos) y durante la adolescencia de los niños, que suele llamarse "ginecomastia puberal benigna", durando unos pocos meses a un año y tendiendo a revertir o estabilizarse al menos. Para que se considere normal, requiere de tamaño máximo 4 cm, Tanner máximo de 3 y ausencia de otras alteraciones. No se debe confundir con la pseudoginecomastia, causada por grasa, en niños obesos. Como tema aparte, en niñas menores de 2 años, también se considera benigna la presencia de botón mamario sin otras alteraciones.

Fuente: Endocrinología pediátrica P6

34. Ante la sospecha clínica de síndrome de Turner se debe tomar la siguiente conducta:

a. Solicitar gonadotrofinas, estrógenos y progesteronas
b. Iniciar anticonceptivos orales
c. Realizar ecografía ginecológica
d. Solicitar cariograma
e. Solicitar prueba de progesterona

Respuesta correcta: d. Solicitar cariograma

Explicación: Basta la mínima sospecha de síndrome de Turner para solicitar un cariograma (talla baja: menor a -2DS; cuello alado, retraso puberal, tórax ancho con pezones separados, retraso puberal).

Fuente: Endocrinología pediátrica P8

35. Una recién nacida de 4 días de vida presenta metrorragia escasa. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución, sin necesidad de mayor estudio
b. Realizar ecografía abdominopélvica
c. Solicitar estradiol y progesterona
d. Solicitar hemograma, con recuento de plaquetas y tiempos de coagulación
e. Solicitar cortisol plasmático basal

Respuesta correcta: a. Observar evolución, sin necesidad de mayor estudio

Explicación: Por los estrógenos maternos, en la recién nacida es normal que haya una escasa metrorragia y también algún grado de ginecomastia.

Fuente: Endocrinología pediátrica P12

36. Un niño de 5 años, cursando una infección diseminada por Neisseria meningitidis, presenta shock refractario al tratamiento antibiótico y a la reposición hídrica con suero fisiológico. Se inician drogas vasoactivas con respuesta parcial. Entre sus exámenes destacan K+: 5,5, Na+: 130, Cl-: 93, HGT: 45. La sospecha diagnóstica debe abarcar:

a. Insuficiencia suprarrenal
b. Hipertiroidismo
c. Diabetes insípida
d. Hipotiroidismo
e. Síndrome de Cushing

Respuesta correcta: a. Insuficiencia suprarrenal

Explicación: Tiene un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una insuficiencia suprarrenal por hemorragia bilateral de las glándulas suprarreales. Como buena insuficiencia suprarrenal aguda, se presenta como shock refractario, con tendencia a la hiperkalemia, hiponatremia e hipoglicemia.

Fuente: Endocrinología pediátrica P14

37. Un niño de 9 años presenta un cuadro de baja de peso, poliuria y astenia de 1 mes de evolución. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita glicemia de ayuno que resulta 260 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
b. Solicitar nueva glicemia de ayuno
c. Indicar dieta y ejercicio y controlar en 1 mes
d. Iniciar medidas generales, asociado a hipoglicemiantes orales
e. Iniciar insulina

Respuesta correcta: e. Iniciar insulina

Explicación: Tiene una diabetes mellitus tipo 1. Cumple con el criterio diagnóstico de síntomas de diabetes más glicemia mayor o igual a 200 mg/dl. Por ser niño, es tipo 1. Se trata con insulina en esquema intensificado (1 dosis diaria de insulina glargina más 3 dosis de insulina cristalina u otra de acción rápida). Actualmente también sirven las bombas de insulina.

Fuente: Endocrinología pediátrica P15

38. La hormona que más incide en el crecimiento fetal intrauterino es:

a. GH
b. Insulina
c. Tiroxina
d. Lactógeno placentario
e. Somatomedina

Respuesta correcta: b. Insulina

Explicación: La insulina es la principal hormona de crecimiento intrauterino, mientras que la GH (hormona de crecimiento) es la más importante en el crecimiento extrauterino, seguida de las hormonas sexuales, que aceleran el crecimiento, pero cierran el cartílago de crecimiento, poniéndole fin.

Fuente: Endocrinología pediátrica P16

39. El síndrome de Klinefelter se presenta como:

a. Hipogonadismo hipogonadotrópico, con testículos pequeños
b. Hipogonadismo hipogonadotrópico, con testículos grandes
c. Hipogonadismo hipergonadotrópico, con testículos pequeños
d. Hipogonadismo hipergonadotrópico, con testículos grandes
e. Hipergonadismo hipogonadotrópico, con testículos grandes

Respuesta correcta: c. Hipogonadismo hipergonadotrópico, con testículos pequeños

Explicación: Es la primea causa de hipogonadismo hipergonadotrópico. Los testículos suelen ser pequeño (menores a 3 cm) y suele asociarse a ginecomastia, talla normal o alta, brazos largos e infertilidad. Sin embargo, en ocasiones tienen síntomas muy sutiles, por lo que únicamente se presenta como infertilidad.

Fuente: Endocrinología pediátrica P17

40. Una adolescente de 17 años consulta porque aún no inicia sus menstruaciones. No tienen antecedentes patológicos ni otros síntomas. Al examen físico se observa desarrollo puberal normal, al igual que el examen ginecológico. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar anticonceptivos orales
b. Solicitar TSH, prolactina, FSH, gonadotropina coriónica y ecografía transvaginal.
c. Solicitar prueba de progesterona
d. Solicitar ecografía transvaginal
e. Solicitar niveles de estradiol y progesterona

Respuesta correcta: b. Solicitar TSH, prolactina, FSH, gonadotropina coriónica y ecografía transvaginal.

Explicación: IMPORTANTE (video desactualizado): Tiene una amenorrea primaria, que se define como la ausencia de menstruación después de los 15 años si es que hay caracteres sexuales secundarios (o desarrollo puberal) y después de los 13 años si es que no los hay. El estudio varía según la fuente que se revise. Algunos recomiendan comenzar con un perfil hormonal básico (TSH, prolactina, FSH y test de embarazo) más una ecografía transvaginal a toda niña con amenorrea primaria; otros, en cambio, diferencian entre las con

desarrollo puberal (en las que se puede asumir que hay estrógenos), las que se estudian con ecografía (para ver si tiene útero); y las que no tienen desarrollo puberal, en las cuales se deben estudiar como un hipogonadismo (con hormonas).

1. Si tiene útero y perfil hormonal normal, se estudia como una amenorrea secundaria, con prueba de progesterona.

2. Si no tiene útero, se debe pedir cariograma: Si es 46XY tiene una disgenesia gonadal o un síndrome de insensibilidad a los andrógenos; si es 46XX, tiene una alteración del desarrollo mulleriano (útero y vagina).

3. Si tiene útero y un hipogonadismo hipergonadotrópico (FSH alta), se pide igualmente cariograma: Si es 45 X0, tiene un síndrome de Turner; si es 46 XX, probablemente tiene una falla ovárica primaria.

4. Si la historia y examen físico orientan a una causa específica, se la estudia dirigidamente (ejemplo: síndrome de Turner clínico se estudia con cariograma. Si tiene algia pélvica cíclica, se sospecha un cuadro de obstrucción del tracto menstrual y se estudia con ecografía pélvica).

Fuente: Endocrinología pediátrica P19

41. Un niño de 9 años, previamente sano y eutrófico, presenta detención del crecimiento y baja de peso, a pesar de mantener un apetito normal. Refiere además que toma mucha agua y va frecuentemente a orinar. En el último tiempo se ha agregado astenia. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable, de entre los siguientes, es:

a. Síndrome de malabsorción intestinal
b. Insuficiencia suprarrenal
c. Leucemia
d. Anorexia nervosa
e. Diabetes mellitus 1

Respuesta correcta: e. Diabetes mellitus 1

Explicación: Es un síndrome diabética clásico. Se debe solicitar una glicemia de ayuno. Si resulta 200 mg/dl o más, confirma el diagnóstico de diabetes mellitus, por la presencia de síntomas. Si resulta 126 a 199, se debe repetir, ya que con una segunda toma en ese rango, se confirma también la diabetes mellitus. En este caso, lo más probable es que estará sobre 200, por la clínica. Finalmente, por ser niño, se trata de una DM tipo 1, que requiere tratamiento con insulina en esquema intensificado (1 dosis de glargina más 3 dosis de insulina cristalina u otra de acción rápida) o bien la instalación de una bomba de insulina.

Fuente: Nutrición pediátrica P18

Crecimiento, talla y desarrollo psicomotor (20)

1. Un niño es capaz de correr sin caerse, forma una torre de 6 cubos, se desviste con habilidad y puede vestirse con ropa sencilla. Dice frases sencillas de 2 a 3 palabras, dice su nombre y es capaz de expresar lo que desea a sus padres y a los adultos que ve con frecuencia. La edad del niño es aproximadamente:

a. 12 meses
b. 18 meses
c. 24 meses
d. 36 meses
e. 48 meses

Respuesta correcta: c. 24 meses

Explicación: Es una pregunta muy discutible, ya que depende mucho del niño, pero pareciera tener 2 años.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P1

2. ¿Qué reflejo arcaico desaparece más tardíamente?

a. Succión
b. Prensión palmar
c. Marcha automática
d. Moro
e. Prensión plantar

Respuesta correcta: e. Prensión plantar

Explicación: La prensión plantar desaparece a los 9-10 meses, cuando empieza a ponerse de pie. El de moro desaparece entre los 3 y 6 meses. Los demás suelen desaparecer a los 3 meses.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P2

3. ¿A qué edad se cierra normalmente la fontanela POSTERIOR?

a. 3 a 6 meses
b. 6 a 9 meses
c. 9 a 18 meses
d. 12 a 24 meses
e. 24 a 36 meses

Respuesta correcta: a. 3 a 6 meses

Explicación: La fontanela anterior o bregma se cierra entre los 9 y 18 meses; la fontanela posterior o lambda entre los 0 y 6 meses.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P3

4. Un niño de 7 años es traído por su padre, ya que es muy bajo. Se revisa la curva de crecimiento y se aprecia que se ha mantenido creciendo en el percentil 5 para su edad, en los últimos años. La edad ósea resulta equivalente a la de un niño de 5 años. El diagnóstico más probable es:

a. Déficit de GH
b. Talla baja familiar
c. Enfermedad celíaca
d. Retraso constitucional del crecimiento
e. Acondroplasia

Respuesta correcta: d. Retraso constitucional del crecimiento

Explicación: En estricto rigor, no tiene talla baja, ya que se define como menor a -2 DS para el índice talla / edad, que equivale al p3. Pero, que la edad ósea sea 2 años menor, sugiere RCC.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P6

5. Un lactante se ríe a carcajadas cuando interactúa con un adulto. Además es capaz de mantener el control de la cabeza sin problemas, mientras se lo mantiene sentado, sin embargo no puede mantenerse sentado por sí mismo. En oportunidades es capaz de tomar objetos con la mano y llevárselos a la boca. ¿Qué edad tiene aproximadamente?

a. 2 meses
b. 4 meses
c. 6 meses
d. 8 meses
e. 10 meses

Respuesta correcta: b. 4 meses

Explicación: Si bien es variable en cada niño, cumple varios hitos clásicos de los 4 meses.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P10

6. En promedio, ¿Cuánto mide un niño de 12 meses de edad?

a. 37 cm
b. 50 cm
c. 62 cm
d. 75 cm
e. 90 cm

Respuesta correcta: d. 75 cm

Explicación: Al nacer: 50 cm. Al año: 75 cm. A los 4 años: 100 cm. Sin embargo, esos son los promedios, siendo muy variable la talla normal.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P13

7. Al nacer los recién nacidos presentan:

a. Tono flexor en extremidades superiores e inferiores
b. Reflejo de paracaídas lateral
c. Reflejo de paracaídas anterior
d. Sonrisa social
e. Tono extensor en extremidades superiores e inferiores

Respuesta correcta: a. Tono flexor en extremidades superiores e inferiores

Explicación: Paracaídas aparecen entre los 6 y 9 meses. Sonrisa social a los 2 meses.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P14

8. Los primeros dientes "de leche" aparecen MÁS frecuentemente:

a. a los 5 años.
b. entre los 12 y los 15 meses de edad.
c. entre los 9 y los 12 meses de edad.
d. entre los 3 y los 5 meses de edad.
e. entre los 5 y los 9 meses de edad.

Respuesta correcta: e. entre los 5 y los 9 meses de edad.

Explicación: Los dientes temporales, llamados “de leche” suelen aparecer entre os 5 y 9 meses de edad, sin embargo, puede demorar bastante, incluso hasta los 15 meses, sin necesidad de estudio (si demora más, sí se piden radiografías). Los dientes permanentes o “definitivos” suelen comenzar a salir desde los 5-6 años.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P15

9. Una niña de 8 años presenta IPT en p50, ITE en p5 e IPE: en p5. La curva de crecimiento muestra una velocidad de crecimiento normal. Se realiza radiografía de carpo que es compatible con una edad ósea de 8 años. El diagnóstico más probable es:

a. Talla baja familiar
b. Retraso puberal
c. Síndrome de Turner
d. Retraso constitucional del crecimiento
e. Talla normal

Respuesta correcta: e. Talla normal

Explicación: Si bien se debería usar el IMC a esta edad, su IPT está normal, por lo que es eutrófica, desde el punto de vista nutricional. La talla es normal (mayor o igual a percentil 3), por lo que el diagnóstico correcto es talla normal.Tiene edad ósea acorde con la cronológica, lo que es compatible con la talla normal y con la talla baja familiar, pero esta última se caracteriza por tener talla bajo el percentil 3.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P17

10. Un lactante es capaz de ponerse de pie, sin lograr caminar por su cuenta, sin embargo gatea de manera activa. Además se ríe a carcajadas cuando interactúa con sus familiares, por ahora sólo dice la palabra "mamá", desconoce a los extraños y no presenta reflejos arcaicos. ¿Qué edad tiene?

a. 4-6 meses
b. 7-8 meses
c. 10-11 meses
d. 14-15 meses
e. 18-20 meses

Respuesta correcta: c. 10-11 meses

Explicación: Podría tener 12 meses también, pero es lo clásico de los 10 meses.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P21

11. Un niño de 15 meses ha dejado de crecer. Se revisa su curva de crecimiento, observándose que ha bajado del percentil 75 al percentil 25 en el IPT, en 3 meses. El diagnóstico más plausible es:

a. Enfermedad celíaca
b. Déficit de GH
c. Retraso constitucional del crecimiento
d. Talla baja familiar
e. Síndrome de Klinefelter

Respuesta correcta: a. Enfermedad celíaca

Explicación: El cambio en el carril de la curva de crecimiento sugiere fuertemente una causa patológica, incluso si es que no alcanza a cumplir criterios de alteraciones nutricionales o de talla.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P22

12. Una madre trae a su hijo de 12 meses de edad, muy preocupada, porque aún no habla. Refiere que entiende su nombre y algunas órdenes, y que se comunica, apuntando cuando quiere algo, pero no dice ninguna palabra. Al examen físico no se encuentran alteraciones y su desarrollo motor es normal. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar impedanciometría
b. Solicitar RMN de cerebro
c. Solicitar potenciales evocados auditivos
d. Derivar a neurología infantil por sospecha de autismo
e. Tranquilizar a la madre y explicarle que su hijo es normal

Respuesta correcta: e. Tranquilizar a la madre y explicarle que su hijo es normal

Explicación: Hasta los 18 meses, puede no hablar ni caminar, mientras el resto de su desarrollo psicomotor no tenga mayores alteraciones.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P28

13. Un niño tiene estatura bajo el percentil 3, velocidad de crecimiento normal y edad cronológica dos años mayor a la edad ósea. El diagnóstico más probable es:

a. Retraso constitucional del crecimiento
b. Talla baja familiar
c. Déficit de GH
d. Acondroplasia
e. Hipopituitarismo secundario

Respuesta correcta: a. Retraso constitucional del crecimiento

Explicación: Tiene talla baja (menor a 2 DS, lo que equivale a menor a p3). Por tener velocidad de crecimiento normal, probablemente tiene una talla baja fisiológica. Como la edad ósea es menor, con una diferencia de 2 años, se confirma el diagnóstico de retraso constitucional del crecimiento. Recordar que la talla baja familiar tiene edad ósea acorde (con una diferencia menor a 2 años que la cronológica). Recordar también que la pubertad precoz tiene edad ósea mayor a la cronológica. El déficit de GH tiene velocidad de crecimiento disminuida y se mantienen las proporciones corporales. La acondroplasia tiene velocidad de crecimiento disminuida, con alteración de las proporciones: cabeza, manos y pies grandes, con extremidades cortas. El hipopituitarismo produciría un déficit de GH, pero además hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, etc.

Es un retraso constitucional del crecimiento clásico. La edad ósea refleja la edad biológica. En la talla baja familiar suele ser acorde a la edad cronológica (la del carnet de identidad); en el retraso constitucional la edad ósea suele ser al menos 2 años menor; en la pubertad precoz, por el contrario, la edad ósea es mayor a la cronológica.

Fuente: Cuestionario 3.1 P2 · Endocrinología pediátrica P10

14. ¿Qué esperaría encontrar en la curva de crecimiento y en la edad ósea de un niño con talla baja debida a un retraso constitucional del crecimiento?

a. Velocidad de crecimiento normal y edad ósea acorde con la edad cronológica
b. Velocidad de crecimiento normal y edad ósea mayor que la edad cronológica
c. Velocidad de crecimiento normal y edad ósea menor que la edad cronológica
d. Velocidad de crecimiento disminuida y edad ósea acorde con la edad cronológica
e. Velocidad de crecimiento disminuida y edad ósea menor que la edad cronológica

Respuesta correcta: c. Velocidad de crecimiento normal y edad ósea menor que la edad cronológica

Explicación: En estricto rigor, tiene distintas fases (al inicio su velocidad de crecimiento es menor a lo normal, luego normal y finalmente mayor), sin embargo, lo habitual es que sea normal. Lo característico es la edad ósea menor (2 años de diferencia con la edad cronológica, aunque un tiempo menor igualmente orienta a que tendrá una talla final mayor).

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P4

15. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con talla baja?

a. Cambio de carril en la curva de crecimiento
b. Ausencia de vello púbico
c. Edad mayor a 10 años
d. Edad menor a 5 años
e. Antecedentes familiares de talla normal

Respuesta correcta: a. Cambio de carril en la curva de crecimiento

Explicación: Lo primero en un niño con posible talla baja, siempre es revisar la curva de crecimiento, ya que diferencia las causa patológicas, que tienen disminución de la velocidad de crecimiento (se cambian de carril en la curva) de las constitucionales, que tienen velocidad de crecimiento normal.

Fuente: Diabetes y endocrinología pediátricas P15

16. Una niña de 7 años es la más baja de su curso. Al revisar su curva de crecimiento se observa que se encuentra el percentil 2 y que se ha mantenido en el mismo carril desde los 2 años de edad. Su madre mide 1,47 metros y su padre, 1,61 metros. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Turner
b. Talla baja familiar
c. Retraso constitucional del crecimiento
d. Pubertad precoz
e. Déficit de GH

Respuesta correcta: b. Talla baja familiar

Explicación: La talla baja se define como talla menor a -2DS para la edad, lo que equivale a menor a p3. Como se ha mantenido en el mismo carril, se concluye que tiene una velocidad de crecimiento normal. Además, sus padres son bajos, por lo que calza perfectamente con el diagnóstico de talla baja familiar o constitucional, que es la primera causa de talla baja. Tiene edad ósea acorde a la edad cronológica. Se diferencia del retraso constitucional del crecimiento en que este último tiene edad ósea discorde (2 años menor a la cronológica) y una expectativa de talla final normal.

Fuente: Endocrinología pediátrica P9

17. La información más útil, al evaluar un niño que consulta por talla baja, la entrega:

a. La edad ósea
b. Los niveles plasmáticos de GH
c. El índice talla/edad
d. Los niveles plasmáticos de testosterona, LH y FSH
e. La curva de crecimiento

Respuesta correcta: e. La curva de crecimiento

Explicación: La curva de crecimiento diferencia las tallas bajas fisiológicas (se mantienen dentro del mismo carril, es decir, tienen velocidad de crecimiento normal), de las patológicas (cambian de carril, cayendo su velocidad de crecimiento). Luego, es útil la edad ósea, que sirve para determinar el pronóstico de talla final y

ayuda a diferenciar algunas causas de talla baja (RCC: edad ósea menor a la cronológica; TBF: edad ósea acorde con la cronológica; pubertad precoz: edad ósea aumentada, en comparación a la cronológica).

Fuente: Endocrinología pediátrica P18

18. Los 3 hitos del desarrollo psicomotor, que el lactante logra normalmente al cumplir el año de edad, son:

a. Gatea, usa las primeras palabras y pasa objetos de una mano a otra
b. Camina sin apoyo, pasa objetos de una mano a otra y dice sus primeras palabras
c. Caminar sin apoyo, uso de la pinza madura entre pulgar e índice, y uso de las primeras palabras
d. Uso de las primeras palabras, continencia urinaria diurna y caminar con apoyo
e. Caminar sin apoyo, formación de las primeras frases y continencia urinaria diurna

Respuesta correcta: c. Caminar sin apoyo, uso de la pinza madura entre pulgar e índice, y uso de las primeras palabras

Explicación: En promedio ocurren a los 12 meses, pero es normal que sea entre los 10 y 18 meses, tanto para las primeras palabras (antes, entiende y dice precursores de palabras) como para los primeros pasos sin apoyo (antes se sienta con apoyo: 4m, luego sin apoyo: 6m, luego gatea: 8m, luego se para: 10m). La pinza madura también suele aparecer simultáneamente (antes, toma cosas con una mano: 4m, luego las pasa a la otra: 6m).

Fuente: Neurología pediátrica P8

19. La fontanela anterior se cierra normalmente entre:

a. Los 3 y 6 meses de edad
b. Los 6 y los 9 meses de edad
c. Los 9 y los 18 meses de edad
d. Los 12 y los 24 meses de edad
e. Los 24 y los 36 meses de edad

Respuesta correcta: c. Los 9 y los 18 meses de edad

Explicación: La fontanela anterior o bregma se cierra entre los 9 y 18 meses; la fontanela posterior o lambda entre los 0 y 6 meses.

Fuente: Neurología pediátrica P9

20. Una madre trae a su hija de 5 años, porque es la más baja de su curso. No presenta otros síntomas y tiene un buen rendimiento escolar. Sus padres son de estatura más bien baja. Al medirla se constata que su talla está en el percentil 2, para su edad. La conducta inicial más adecuada es:

a. Solicitar radiografía de carpo, para determinar la edad ósea
b. Solicitar cariograma
c. Solicitar niveles de 17-hidroxiprogesterona, estradiol, TSH, glicemia y anticuerpos antitransglutaminasa
d. Evaluar la curva de crecimiento, con los registros previos de peso y talla
e. Tranquilizar a la madre y explicarle que la talla de su hija es normal

Respuesta correcta: d. Evaluar la curva de crecimiento, con los registros previos de peso y talla

Explicación: La definición de talla baja es con un índice talla edad menor a -2DS, lo que es equivalente a p3 aproximadamente. Por tanto, sí tiene talla baja. Lo primero será siempre revisar la curva de crecimiento, ya que si tiene una velocidad de crecimiento normal (se mantiene en el mismo carril) y está entre -2 y -3 DS, lo más probable es que sea una causa constitucional (ej. talla baja familiar o retraso constitucional del crecimiento, que se diferencian en la talla de los padres y en la edad ósea). En cambio, si tiene velocidad de crecimiento baja (se cambia de carril) o es severa (menor a -3 DS) probablemente sea una causa patológica. Si tuviese cualquier signo sugerente de síndrome de Turner, se debe pedir el cariograma, sin embargo, lo primero siempre será revisar la curva de crecimiento, que es algo que se realiza en la misma atención.

Fuente: Nutrición pediátrica P5

Nutrición y alimentación (27)

1. Un niño de 10 años presenta un perfil lipídico con TG: 80 mg/dl, Colesterol total: 496 mg/dl, HDL: 60 mg/dl, LDL: 420 mg/dl. Al examen físico está en buenas condiciones, con algunas lesiones solevantadas, amarillentas, alrededor de los párpados. Su padre y varios tíos son hiperlipidémicos. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar dieta baja en ácidos grasos saturados
b. Iniciar dieta baja en colesterol
c. Iniciar dieta e indicar un fibrato
d. Iniciar dieta e indicar una estatina
e. Iniciar dieta e indicar ácido nicotínico

Respuesta correcta: d. Iniciar dieta e indicar una estatina

Explicación: Tiene una hipercolesterolemia familiar clásica, con xantelasmas e hipercolesterolemia severa, en contexto de antecedentes familiares. Se debe tratar agresivamente con estatinas y estudiar al resto de la familia.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P4

2. ¿Qué parámetro es más adecuado para el diagnóstico nutricional en los niños mayores de 6 años?

a. Índice de masa corporal
b. Índice Peso/Talla
c. Índice Peso/Edad
d. Índice Talla/Edad
e. Porcentaje de grasa corporal

Respuesta correcta: a. Índice de masa corporal

Explicación: En Chile se suele usar el índice peso talla (IP/T) hasta los 5 años y, desde esa edad, se usa el índice de masa corporal (IMC), siempre en base a percentiles o desviaciones estándar. El índice peso edad (IP/E) se usa solo en menores de un año para diagnosticar la desnutrición. En algunas guías internacionales se usa el IMC desde los 2 años en adelante. Una vez elegido el parámetro: Desnutrición es -2 DS o menos. Bajo peso o riesgo de desnutrición es -1 a -1,9 DS. Eutrófico es -0,9 a +0,9 DS. Sobrepeso es +1 a +1,9 DS. Obesidad es +2 o más DS. La obesidad se considera severa si es de +3 o más DS. Si se usan los percentiles, sobrepeso es desde p85 y obesidad desde p95 (aunque estos percentiles no calzan perfectamente con las DS).

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P5

3. La fórmula de relleno que se suele dejar en el sistema público suele ser: Leche purita fortificada al 7,5% + azúcar al 3% + aceite al 2%. ¿Cuál es la razón del aporte del aceite?

a. Aporte de vitaminas liposolubles
b. Aporte de ácidos grasos esenciales
c. Aumento de la carga osmolar
d. Disminución de la carga osmolar
e. Aporte de calorías

Respuesta correcta: b. Aporte de ácidos grasos esenciales

Explicación: Lo ideal para todo lactante es tomar leche materna. Si no están disponibles, se pueden usar las fórmulas de inicio, que tienen el problema de ser caras y que cada una se prepara distinto, por lo que se deben seguir sus instrucciones propias. La leche purita fortificada se puede utilizar como un sustituto, pero se debe agregar aceite para aportar ácidos grasos esenciales y azúcar o maltodextrina para agregar calorías, ya que se debe diluir al 7,5%, a fin de evitar una carga osmolar demasiado alta.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P8

4. Un lactante de 4 meses, alimentado con pecho materno exclusivo, presenta las siguientes mediciones antropométricas: índice peso/edad: -2,1 DS; índice talla/edad: -0,4 DS; índice peso/talla: -1,9 DS. El diagnóstico más probable es:

a. Desnutrición severa
b. Sobrepeso
c. Eutrofia
d. Desnutrición moderada
e. Talla baja

Respuesta correcta: d. Desnutrición moderada

Explicación: Por tener menos de 1 año, se usa el IPE para ver si tiene desnutrición (-2,1 es desnutrición moderada). Para la obesidad, se usa el IPT.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P11

5. Un recién nacido pesó 3.500 gramos al nacer. Es pesado a los 7 días de vida, pesando 3.080 gramos. Actualmente se alimenta sólo de leche materna y se ve de buen aspecto, sin presentar ninguna alteración en el examen físico. La conducta más adecuada es:

a. Tranquilizar a la madre, explicando la normalidad de la situación y mantener la lactancia materna exclusiva
b. Mejorar la técnica de lactancia y controlar en 48 horas
c. Suspender la lactancia materna e iniciar un relleno
d. Mantener la lactancia materna y adicionar un relleno
e. Hospitalizar e iniciar nutrición parenteral

Respuesta correcta: b. Mejorar la técnica de lactancia y controlar en 48 horas

Explicación: A los 7 días debió haber recuperado el peso de nacimiento. Como no lo ha hecho, se mejora la técnica de lactancia y se controla. Si no sube 25-30 g/día (lo mínimo esperado), se agrega fórmula a la lactancia materna.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P12

6. ¿Cuál de los siguientes nutrientes NO es suplementado en el lactante sano, según el programa nacional?

a. Vitamina A
b. Vitamina B12
c. Vitamina C
d. Vitamina D
e. Hierro

Respuesta correcta: b. Vitamina B12

Explicación: El hierro se suplementa desde los 4 meses hasta el año de edad, salvo en prematuros que es desde que duplican el peso o cumplen 2 meses, hasta el año de edad corregida. Las vitaminas ACD (solo importa la D, pero se suplementan las tres) se suplementan desde que cumple 1 mes, hasta los 12 meses de edad (edad corregida en prematuros).

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P16

7. Además de alimentación sólida, ¿qué leche indicaría a un lactante de 8 meses, de entre las alternativas enumeradas?

a. Leche purita cereal al 7,5% más azúcar al 5% y cereal al 3%
b. Leche purita cereal al 7,5% más azúcar al 3% y aceite al 2%
c. Leche purita fortificada al 7,5% más azúcar al 3% y cereal al 5%
d. Leche purita fortificada al 7,5% más cereal al 5%
e. Leche purita fortificada al 7,5% más azúcar al 3%

Respuesta correcta: d. Leche purita fortificada al 7,5% más cereal al 5%

Explicación: Ver resumen de alimentación en pediatría.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P19

8. ¿Qué alimento puede comer un niño de 9 meses?

a. Melón
b. Miel
c. Dulces
d. Café
e. Maní

Respuesta correcta: a. Melón

Explicación: Puede comer todas las frutas, sacando antes las semillas con las que se pueda atorar.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P20

9. Un niño de 4 años de edad presenta índice peso/edad: +0,6 DS; índice peso/talla: +1,2 DS e índice talla/edad: -0,8 DS. El diagnóstico nutricional es:

a. Desnutrición
b. Eutrofia
c. Sobrepeso
d. Obesidad
e. Obesidad mórbida

Respuesta correcta: c. Sobrepeso

Explicación: A los 4 años, se usa el IPT, que, al estar en +1, es diagnóstico de sobrepeso.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P23

10. Luego de cumplir un año de edad, un niño debe alimentarse preferentemente con:

a. Dos a tres mamaderas de 250 ml, más dos a tres comidas, según los hábitos familiares
b. Tres mamaderas de 250 ml, más una comida con postre
c. Tres mamaderas de 400 ml, más dos comidas con postre
d. Dos mamaderas de 400 ml, más tres comidas con postre
e. Lactancia materna a libre demanda, más 3 comidas con postre

Respuesta correcta: a. Dos a tres mamaderas de 250 ml, más dos a tres comidas, según los hábitos familiares

Explicación: Al año, idealmente debería ir incorporándose a la rutina alimenticia de la familia. En general toman 2 a 3 leches de 250cc al día, más las 3 comidas diarias y se ajusta luego según el peso (ej. quitar una leche o disminuir la cantidad).

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P25

11. Lactante de 6 meses, que no acude a controles sanos, es traído por su madre por presentar opacidad corneal de 2 semanas de evolución. Al examen destaca úlcera corneal derecha e hiperqueratosis perifolicular, con piel seca y algún grado de alopecia. Lo más probable es que tenga una hipovitaminosis de tipo:

a. A
b. B1
c. C
d. D
e. E

Respuesta correcta: a. A

Explicación: El déficit de vitamina A, además de lo descrito, produce ceguera nocturna.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P27

12. ¿Qué niño NO debe realizarse un perfil lipídico en busca de dislipidemia?

a. Niño obeso
b. Niño diabético tipo 1
c. Niño celíaco, con desnutrición calórica
d. Niño con arco corneal
e. Niño con antecedentes familiares de muertes tempranas por infarto agudo al miocardio

Respuesta correcta: c. Niño celíaco, con desnutrición calórica

Explicación: La enfermedad celíaca produce desnutrición, malabsorción y se asocia a enfermedades autoinmunes (ej. dermatitis herpetiforme), pero no a dislipidemias. Las demás son las indicaciones clásicas de perfil lípídico en pediatría.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P30

13. Un lactante de 10 meses, alimentado con fórmula y sopa puré de carnes con vegetales, es traído por su madre, ya que lo encuentra obeso. Sus mediciones antropométricas son: índice peso/edad: +2,3 DS, índice talla/edad: +1,2 DS, índice peso/talla: +1,8 DS. El diagnóstico nutricional es:

a. Desnutrición
b. Eutrofia
c. Sobrepeso
d. Obesidad
e. Obesidad mórbida

Respuesta correcta: c. Sobrepeso

Explicación: En los menores de un año lo primero a revisar es el índice peso/edad, en busca de desnutrición (desde -2DS) y riesgo de desnutrición (desde -1DS). Si no hay desnutrición, se debe mirar el índice peso/talla o peso/longitud, en busca de obesidad (desde +2 DS) y sobrepeso (desde +1DS). En este caso tiene un IPT de 1,8DS, por lo que tiene sobrepeso.

En menor de 12 meses se ve el IPE para la desnutrición (no tiene) y luego el IPT para el sobrepeso y obesidad (+1,8 es sobrepeso).

Fuente: Cuestionario 3.1 P7 · Nutrición pediátrica P17

14. En el preescolar, el diagnóstico de obesidad se realiza cuando:

a. El peso es al menos 2 desviaciones estándar mayor que el promedio para su edad
b. El peso es al menos 2 desviaciones estándar mayor que el promedio para su talla
c. El peso es al menos 3 desviaciones estándar mayor que el promedio para su edad
d. El peso es al menos 3 desviaciones estándar mayor que el promedio para su talla
e. El peso es al menos el doble que el promedio para su edad

Respuesta correcta: b. El peso es al menos 2 desviaciones estándar mayor que el promedio para su talla

Explicación: En preescolar se usa el índice peso talla (IP/T), también llamado índice peso longitud (IP/L). En Chile se suele usar el IP/T hasta los 5 años y, desde esa edad, se usa el IMC, siempre en base a percentiles o desviaciones estándar. El índice peso edad (IP/E) se usa solo en menores de un año para diagnosticar la desnutrición. En algunas guías internacionales se usa el IMC desde los 2 años en adelante. Una vez elegido el parámetro: Desnutrición es -2 DS o menos. Bajo peso o riesgo de desnutrición es -1 a -1,9 DS. Eutrófico es -0,9 a +0,9 DS. Sobrepeso es +1 a +1,9 DS. Obesidad es +2 o más DS. La obesidad se considera severa si es de +3 o más DS. Si se usan los percentiles, sobrepeso es desde p85 y obesidad desde p95 (aunque estos percentiles no calzan perfectamente con las DS).

Fuente: Nutrición pediátrica P1

15. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una alternativa válida para la alimentación de un recién nacido, que no recibe pecho materno?

a. Leche purita al 7,5%, más azúcar al 3%, más aceite al 2%
b. Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%
c. Leche purita al 7,5%, más azúcar al 3%, más cereal al 5%
d. Leche purita al 10%, más azúcar al 3%, más aceite al 2%
e. Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

Respuesta correcta: a. Leche purita al 7,5%, más azúcar al 3%, más aceite al 2%

Explicación: Lo ideal para todo lactante es tomar leche materna. Si no están disponibles, se pueden usar las fórmulas de inicio, que tienen el problema de ser caras y que cada una se prepara distinto, por lo que se deben seguir sus instrucciones propias. La leche purita fortificada se puede utilizar como un sustituto, pero se debe agregar aceite para aportar ácidos grasos esenciales y azúcar o maltodextrina para agregar calorías, ya que se debe diluir al 7,5%, a fin de evitar una carga osmolar demasiado alta.

Fuente: Nutrición pediátrica P2

16. Un lactante de 4 meses, alimentado exclusivamente con pecho materno presenta un peso 30% mayor del normal para su edad y talla. La conducta más adecuada es:

a. Suspender la lactancia materna, iniciar fórmula en cantidades menores e introducir alimentos sólidos
b. Mantener la lactancia materna, pero disminuir la frecuencia de las mamadas
c. Mantener la lactancia materna, pero disminuir la duración de las mamadas
d. Ordenar la lactancia materna, de modo de ofrecer el pecho 4 veces al día y agregar una comida, tipo sopa puré
e. Tranquilizar a la madre y explicarle que su hijo está obeso, pero que no debe tomar ninguna medida por ahora

Respuesta correcta: e. Tranquilizar a la madre y explicarle que su hijo está obeso, pero que no debe tomar ninguna medida por ahora

Explicación: Hay que distinguir dos cosas (diagnóstico y manejo): 1. El diagnóstico de obesidad es discutible en niños con lactancia materna exclusiva, ya que algunos proponen que son siempre eutróficos, independientemente de su índice peso talla, mientras que otros plantean que sí pueden ser obesos o tener sobrepeso, ya que, a largo plazo, los que cumplen criterios de obesidad tienen mayor riesgo de ser obesos que quienes no los cumplen, aunque sea solo levemente mayor. 2. El manejo, en cambio, consiste en continuar la lactancia materna exclusiva, sin mayores cambios, considerándose innecesario hacer cualquier cambio. Una vez que inician la alimentación sólida, recién se busca tomar medidas que permitan lograr el normopeso.

Fuente: Nutrición pediátrica P3

17. Durante el primer año de vida, habitualmente se suplementa la alimentación con todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Vitamina A
b. Vitamina B1
c. Vitamina C
d. Vitamina D
e. Hierro

Respuesta correcta: b. Vitamina B1

Explicación: El hierro se suplementa desde los 4 meses hasta el año de edad, salvo en prematuros que es desde que duplican el peso o cumplen 2 meses, hasta el año de edad corregida. Las vitaminas ACD (solo importa la D, pero se suplementan las tres) se suplementan desde que cumple 1 mes, hasta los 12 meses de edad (edad corregida en prematuros).

Fuente: Nutrición pediátrica P6

18. El tratamiento de la obesidad en el niño está orientado a:

a. Lograr que coma frutas y verduras, sin ingesta de carbohidratos refinados
b. Lograr que su curva de peso se mantenga en el mismo carril
c. Eliminar las grasas de la dieta
d. Bajar de peso, hasta alcanzar el peso normal
e. Establecer hábitos saludables de alimentación y actividad física

Respuesta correcta: e. Establecer hábitos saludables de alimentación y actividad física

Explicación: En pediatría (y en adultos también), lo más importante en el manejo de la obesidad es lograr un estilo de vida saludable. Los niños requieren grasas, azúcar y calorías en su desarrollo (además de un sinnúmero de otros nutrientes), por lo que no se los debe privar de ninguno de ellos, sino que debe ingerirlos de manera saludable.

Fuente: Nutrición pediátrica P7 · Crecimiento y nutrición pediátricas P9

19. Las medidas más importantes, para prevenir el síndrome de realimentación en un paciente crítico muy desnutrido, son:

a. Reiniciar la alimentación oral progresivamente, con alimentos sin potasio
b. Iniciar la alimentación oral, indicando además un suero glucosado al 5% de mantención, para evitar las hipoglicemias
c. Reiniciar la alimentación por una sonda nasoenteral, usando una bomba de infusión continua
d. Reanudar la alimentación progresivamente, por vía oral, iniciando con cantidades pequeñas y suplementar con vitaminas y minerales
e. Reanudar la alimentación por vía parenteral e iniciar la vía oral una vez que se haya logrado estabilizar al paciente

Respuesta correcta: d. Reanudar la alimentación progresivamente, por vía oral, iniciando con cantidades pequeñas y suplementar con vitaminas y minerales

Explicación: El síndrome de realimentación se produce por la depleción de oligoelementos, que, al reiniciar la ingesta de manera agresiva, caen rápidamente, produciéndose déficits agudos de los mismos, tales como encefalopatía de Wernicke (déficit de B1), arritmias (por hipocalcemia, hipomagnesemia o hipokalemia), así como hipofosfemia, entre otras alteraciones.

Fuente: Nutrición pediátrica P9

20. Se recomienda no darle miel de abeja a los lactantes menores de un año. ¿Cuál es la justificación para esta indicación?

a. Es fuente de alergias en los lactantes menores
b. No se absorben los disacáridos de la miel a esta edad y provoca diarrea osmótica
c. Produce cólicos y malestar abdominal en los lactantes menores
d. Existe riesgo de botulismo en los lactantes menores
e. Provoca enteropatía perdedora de proteínas y de glóbulos rojos, la que puede ser grave

Respuesta correcta: d. Existe riesgo de botulismo en los lactantes menores

Explicación: Aunque el riesgo de bajísimo, existe, razón por lo que la miel de abeja solo se puede dar después del año de edad. Los beneficios de la miel de abeja, en comparación al azúcar común y corriente no cuentan con mayor evidencia, siendo un equivalente.

Fuente: Nutrición pediátrica P10

21. ¿Cuál de las siguientes no constituye una ventaja de la leche materna?

a. Aporta cantidades óptimas de hierro al recién nacido
b. Permite un mejor desarrollo del sistema inmune del recién nacido
c. Disminuye el riesgo de diarreas en el lactante
d. Tiene una osmolaridad óptima para el tubo digestivo del recién nacido
e. Disminuye el riesgo de muerte súbita del lactante

Respuesta correcta: a. Aporta cantidades óptimas de hierro al recién nacido

Explicación: La lactancia materna es lo mejor, pero le falta algo de hierro y vitamina D (se deben suplementar).

Fuente: Nutrición pediátrica P11

22. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una contraindicación para la lactancia materna exclusiva?

a. Galactosemia
b. Infección materna por VIH
c. Consumo materno de cocaína
d. Infección materna por hepatitis B
e. Uso materno de antineoplásicos

Respuesta correcta: d. Infección materna por hepatitis B

Explicación: En la hepatitis B se debe vacunar y dar IgG específica, manteniendo la leche materna (recordar marcar la alternativa correcta y no la B). En la hepatitis C tampoco se contraindica la lactancia materna.

Fuente: Nutrición pediátrica P12 · Crecimiento y nutrición pediátricas P24

23. ¿Cuál de las siguientes vitaminas se absorbe normalmente en un paciente con alteración de la producción de ácidos biliares?

a. A
b. E
c. D
d. C
e. K

Respuesta correcta: d. C

Explicación: Los ácidos biliares son importantes para la emulsión y posterior absorción de grasas, por lo que su déficit se traduce en que no se absorben las vitaminas liposolubles: A, D, E y K (o DEKA si es más fácil memorizarlas así). Recordar poner atención a marcar la opción correcta y no la opción “C”, por ser "vitamina C".

Fuente: Nutrición pediátrica P14

24. Un lactante de 11 meses, sin suplementación vitamínica, es traído por su madre porque presenta epistaxis frecuente y llora con facilidad. Al examen físico se aprecian petequias en manos, muslos y piernas, gingivitis hemorrágica, caderas flectadas y llora al movilizar la cadera izquierda. El cuadro descrito se correlaciona mejor con el déficit de la siguiente vitamina:

a. A
b. B1
c. C
d. B6
e. K

Respuesta correcta: c. C

Explicación: Es un escorbuto infantil, muy raro en la actualidad. Su clínica más frecuente incluye dolores óseos (que puede verse como una pseudoparálisis por dolor), hemorragia gingival, petequias (hasta ahí similar a una leucemia aguda) y la característica aparición de pápulas perifoliculares de aspecto hemorrágico, que se pueden confundir con un púrpura palpable, pero, con la diferencia que se ubican alrededor de los folículos pilosos de la piel.

Fuente: Nutrición pediátrica P15

25. Al cumplir un año de edad un niño debe alimentarse preferentemente con:

a. Dos mamaderas de 250 ml, más tres comidas con postre.
b. Dos mamaderas de 250 ml, más 1 comida, con postre.
c. Tres mamaderas de 400 ml, más dos comidas con postre.
d. Dos mamaderas de 400 ml, más tres comidas con postre.
e. Lactancia materna a libre demanda, más 3 comidas con postre.

Respuesta correcta: a. Dos mamaderas de 250 ml, más tres comidas con postre.

Explicación: Al año, idealmente debería ir incorporándose a la rutina alimenticia de la familia. En general toman 2 a 3 leches de 250cc al día, más las 3 comidas diarias y se ajusta luego según el peso (ej. quitar una leche o disminuir la cantidad).

Fuente: Nutrición pediátrica P16

26. Los exámenes de laboratorio más adecuados para determinar la presencia de una desnutrición proteica y para determinar la cantidad de proteínas que se deben consumir diariamente para su tratamiento, son respectivamente:

a. Albúmina plasmática y proteinuria de 24 horas
b. Albúmina plasmática y calorimetría indirecta
c. Prealbúmina plasmática y calorimetría indirecta
d. Prealbúmina plasmática y nitrógeno urinario total
e. Perfil lipídico y creatinina plasmática

Respuesta correcta: d. Prealbúmina plasmática y nitrógeno urinario total

Explicación: Los exámenes de laboratorio no tienen buen rendimiento en la evaluación nutricional, por lo que de ninguna manera reemplazan al diagnóstico clínico, que es el más importante para el diagnóstico de desnutrición infantil, incluyendo la desnutrición proteica. El hemograma y los niveles de vitaminas pueden ser útiles para identificar algunas deficiencias específicas (ej. hierro, vitamina B12, folatos, vitamina D). Respecto a la desnutrición proteica, la prealbúmina es un buen marcador de la desnutrición proteica aguda, mientras que la albúmina solo cae cuando se hace crónica. Por su parte, aunque con muchos falsos positivos y negativos, el “balance nitrogenado” (entradas de nitrógeno menos salidas de nitrógeno) puede tener alguna utilidad, en especial, para calcular las entradas de nitrógeno que se darán para mantener un balance nitrogenado positivo. El nitrógeno urinario total, a pesar de sus limitaciones, puede dar alguna noción de las pérdidas diarias de nitrógeno.

Fuente: Nutrición pediátrica P19 · Crecimiento y nutrición pediátricas P26

27. ¿Cuál de las siguientes opciones, corresponde a un alimento que NO debe ofrecerse a un niño de 6 meses de edad?

a. Pollo
b. Sandía
c. Vacuno
d. Brócoli
e. Chocolate

Respuesta correcta: e. Chocolate

Explicación: Darle dulces y chocolates a los niños es un pecado pediátrico. De lo demás, puede comer lo que sea, salvo miel (por el botulismo), alimentos con los que se puede ahogar (ej. maní o las semillas de la sandía, que sí se deben retirar) y alimentos que no son adecuados para ningún ser humano (ej. papas crudas).

Fuente: Nutrición pediátrica P20

Hematología y oncología (17)

1. Un niño de 5 años es traído por su madre por cuadro de fiebre y compromiso del estado general de algunas semanas de evolución. El hemograma muestra hematocrito: 27%, hemoglobina: 9,1 mg/dl, plaquetas: 48.000 por mm3, glóbulos blancos: 2.900 por mm3, con 84% de linfocitos, 9% de neutrófilos segmentados, 2% de monocitos, 0% de eosinófilos, 0% de basófilos y 5% de blastos. El diagnóstico más probable es:

a. Linfoma
b. Leucemia linfática aguda
c. Leucemia linfática crónica
d. Púrpura trombocitopénico trombótico
e. Sepsis por bacterias Gram negativas

Respuesta correcta: b. Leucemia linfática aguda

Explicación: Tiene una pancitopenia. La presencia de blastos orienta a leucemia aguda. Además, por la edad y por la clínica, lo más probable es que sea una leucemia linfática aguda. También orienta a este diagnóstico el 84% de linfocitos, aunque sigue siendo necesaria la biopsia de médula ósea, para confirmar. El linfoma tendría hemograma normal, pero adenopatías y síntomas B. La LLC es propia de adultos mayores y no tiene pancitopenia, sino leucocitosis, de tipo linfocitosis, con bicitopenia. El PTT tiene anemia hemolítica, trombopenia y, habitualmente, normalidad de los glóbulos blancos. La sepsis por Gram negativos tienen leucocitosis o leucopenia, con desviación izquierda.

Es una leucemia aguda clásica, en su presentación “aleucémica”, con pancitopenia. Es la causa más frecuente de cáncer en la infancia y actualmente tiene buen pronóstico, con más de 90% de supervivencia si es que se diagnostica y se trata oportunamente, ya que responde a la quimioterapia.

Fuente: Cuestionario 3.1 P3 · Hematología pediátrica P6

2. La primera causa de anemia crónica en los niños menores de 1 año es:

a. Ferropénica
b. Enfermedades crónicas
c. Mutaciones genéticas de la hemoglobina
d. Déficit de folatos y B12
e. Hemólisis extravascular

Respuesta correcta: a. Ferropénica

Explicación: Aunque no es la única causa, la ferropenia es, por lejos, la causa más frecuente de anemia en los niños, en especial en los mayores de 6 meses. Por ello es que en Chile se recomienda dar hierro a todo niño desde que cumple 4 meses hasta que cumple un año. Si es prematuro (<37 semanas), se hace desde que duplica su peso, lo que habitualmente ocurre a los dos meses y se deja hasta que cumplen un año de edad corregida. Esto incluye a quienes toman leche materna. Eso sí, en niños que toman leche Purita Fortificada u otra leche fortificada, es innecesario dar un aporte adicional de hierro, ya que las leches fortificadas lo tienen.

Fuente: Hematología pediátrica P1

3. La ictericia neonatal que aparece en las primeras 24 horas de vida, se debe con mayor frecuencia a:

a. Fenómenos fisiológicos
b. Incompatibilidad de grupo Rh
c. Incompatibilidad de grupo clásico (ABO)
d. Infecciones intrauterinas
e. Hipotiroidismo

Respuesta correcta: c. Incompatibilidad de grupo clásico (ABO)

Explicación: La ictericia fisiológica suele presentarse desde las 48 o 72 horas y siempre después de las primeras 24 horas. La ictericia precoz (<24 horas), sugiere fuertemente un proceso hemolítico o una sepsis. La hemólisis neonatal leve se presenta como ictericia, con riesgo de kernicterus, en cambio, la hemólisis más severa, se presenta, además, con un síndrome anémico y, en los casos más graves, como un hídrops fetal con edema generalizado.

Fuente: Hematología pediátrica P2

4. Un paciente de 5 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de 3 días de evolución de exantema petequial, asociado a sangramiento gingival al cepillarse los dientes. La madre refiere que cursó con una infección respiratoria alta, autolimitada, hace 10 días. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones, afebril, con un exantema petequial generalizado. El examen más importante para confirmar la sospecha diagnóstica es:

a. Hemograma con recuento de plaquetas
b. Hemocultivos
c. Pruebas de agregación plaquetaria
d. Tiempo de sangría
e. Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada

Respuesta correcta: a. Hemograma con recuento de plaquetas

Explicación: La sospecha es una púrpura trombocitopénica inmune, por lo que se debe solicitar el hemograma, que confirmará la plaquetopenia aislada. Otras causas, como la leucemia también se pueden ver en el hemograma. Finalmente, si el hemograma estuviese normal, con plaquetas dentro de rango normal, habría que pensar en las causas no trombopénicas, tales como la disfunción plaquetaria (ej. AINEs) o la púrpura de Schönlein Henoch.

Fuente: Hematología pediátrica P3

5. La primera causa de muerte en niños con leucemia es:

a. Infecciones
b. Hemorragias
c. Arritmias
d. Fenómenos trombóticos
e. Edema pulmonar no cardiogénico

Respuesta correcta: a. Infecciones

Explicación: Los cánceres hematológicos, en general mueren de infecciones, hemorragias y trombosis, en ese orden.

Fuente: Hematología pediátrica P4

6. ¿Cuál de las siguientes opciones NO constituye un factor de riesgo para presentar poliglobulia neonatal?

a. Prematurez
b. Hijo de madre diabética
c. Preclamsia
d. Retraso del crecimiento intrauterino
e. Recién nacido postérmino

Respuesta correcta: a. Prematurez

Explicación: La prematurez suele asociarse a anemia ferropénica y no a poliglobulia, que se asocia más a insuficiencia placentaria y diabetes gestacional. Los prematuros se suplementan con hierro desde que duplican el peso de nacimiento hasta los 12 meses de edad corregida.

Fuente: Hematología pediátrica P5

7. Un lactante de 5 meses diagnosticado de tos convulsiva, presenta leucocitosis importante, hasta 54.000 por mm3, con un 90% de linfocitos. La causa más probable de esta alteración sanguínea es:

a. Infección viral sobreagregada
b. Leucemia linfática aguda concomitante
c. Reacción leucemoide por Bordetella pertusis
d. Infección previa por VIH
e. Agamaglobulinemia congénita

Respuesta correcta: c. Reacción leucemoide por Bordetella pertusis

Explicación: Las reacciones leucemoides se definen como leucocitosis mayor a 50.000 por mm3, debidas a una causa no neoplásica, sino habitualmente infecciosa (ej. sepsis, coqueluche). Su diagnóstico se basa en la existencia de una causa que la explique (ej. infección) y el hecho de que revierten con la desaparición de la causa. En el caso del coqueluche es frecuente y de tipo linfocítica.

Fuente: Hematología pediátrica P8

8. La medida más efectiva para prevenir la hemólisis fetal por incompatibilidad Rh es:

a. Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(+), sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
b. Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(+), no sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
c. Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(-), sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
d. Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(-), no sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto
e. Administrar inmunoglobulina anti-D al recién nacido Rh(-)

Respuesta correcta: d. Administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh(-), no sensibilizadas, a las 28 semanas de gestación y luego del parto

Explicación: Si ya está sensibilizada, no tiene ninguna utilidad, puesto que justamente intenta prevenir la sensibilización. La más importante es la dosis posparto, que reduce en un 90% la sensibilización. La dosis de las 28 semanas la reduce en un 9% adicional. Además, está indicada en cualquier evento que produzca intercambio de sangre fetal y materna: metrorragias, aborto, mola, amniocentesis, biopsia de vellosidad corial, etc. Una vez sensibilizada solo queda seguir el grado de anemia fetal, mediante el Doppler de arteria cerebral media, de modo de decidir el momento de interrupción y la necesidad de transfusiones intrautrerinas.

Fuente: Hematología pediátrica P9

9. Un niño de 3 meses de edad, asintomático, sin antecedentes de importancia, presenta hemoglobina de 10,4 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Anemia ferropénica
b. Anemia de enfermedades crónicas
c. Anemia hemolítica, por incompatibilidad de grupo
d. Anemia hemolítica, de etiología genética
e. Anemia fisiológica

Respuesta correcta: e. Anemia fisiológica

Explicación: Es normal. El diagnóstico de anemia en pediatría se realiza de acuerdo a la hemoglobina, ajustada por edad. El punto de corte es variable, según la fuente, pero actualmente la mayoría se inclina al percentil 3 o 2,5 para la edad (Hb < p3 - p2,5). Así el diagnóstico de anemia se realiza con distintos puntos de corte, según la edad, recordando que suele bajar bastante en los primeros meses. Al nacer: Hb < 15; en el primer mes de vida: Hb < 14; 2 a 4 meses: Hb < 9; mayores de 6 meses: Hb < 11.

Fuente: Hematología pediátrica P10

10. El cáncer es la segunda causa de muerte en los niños mayores de un año, luego de los accidentes. Los dos grupos más importantes de tumores malignos, causantes de mortalidad en la edad pediátrica son:

a. Hematológicos y originados en el sistema nervioso central
b. Hematológicos y originados en el tubo digestivo
c. Hematológicos y originados en el sistema urogenital
d. Hematológicos y los sarcomas de partes blandas
e. Hematológicos y los tumores óseos

Respuesta correcta: a. Hematológicos y originados en el sistema nervioso central

Explicación: Los hematológicos son los más frecuentes, en especial la leucemia linfática aguda en niños y el linfoma de Hodgkin en adolescentes. Luego, los tumores del sistema nervioso central, en especial, los astrocitomas y otros gliomas.

Fuente: Hematología pediátrica P11

11. Un niño de 6 años con diagnóstico de púrpura trombocitopénico idiopático, sin manifestaciones hemorrágicas graves, presenta un recuento de plaquetas de 45.000 por mm3. La conducta más adecuada es:

a. Indicar reposo y observar la evolución, sin necesidad de medicamentos
b. Iniciar corticoides orales
c. Administrar inmunoglobulina endovenosa, en altas dosis
d. Derivar para esplenectomía
e. Indicar transfusión inmediata de plaquetas

Respuesta correcta: a. Indicar reposo y observar la evolución, sin necesidad de medicamentos

Explicación: IMPORTANTE APRENDER: Es importante recordar que el objetivo NO es normalizar las plaquetas, sino solo prevenir hemorragias severas. El PTI de los niños suele ser un cuadro autolimitado, que rara vez se complica. Por ello, el tratamiento general es conservador y basta con observar la evolución, indicando reposo físico, aunque el uso de corticoides es una opción midiendo riesgos y beneficios.

- La observación suele ser el manejo de pacientes con equimosis, petequias.

- Los corticoides orales son una alternativa y están indicados en algunos casos (gingivorragia, epistaxis, otras hemorragias sin urgencia, <20.000 plaquetas o <30.000 más un niño muy inquieto o padres que no tienen mucho acceso al sistema de salud).

- Si hubiese hemorragias graves (ej. hemorragia digestiva u otra hemorragia interna que requiera atención médica de urgencia), se indica IgG EV en alta dosis o Ig anti-D, más corticoides endovenosos.

- En hemorragias muy graves, con riesgo vital (ej. hemorragia cerebral, shock hipovolémico, etc.), se agregan las transfusiones de plaquetas más la IgG y más los corticoides ev.

- El tratamiento de segunda línea solo se usa en PTI crónicos, que no logran un recuento de plaquetas estables >20.000, con el uso de corticoides y, actualmente, se utiliza, la esplenectomía (80-90% éxito, pero quirúrgica y con inmunodepresión secundaria) y el rituximab (50% de éxito, no quirúrgica y también con inmunodepresión secundaria). De los PTI de la infancia solo un 10-20% cronifica y, de esos, cerca de la mitad desaparece en 5 años. En los adultos, en cambio, el 80-90% cronifica. En los adultos, el tratamiento suele ser similar al ya explicado, aunque los corticoides se usan con mayor frecuencia que en los niños. En adultos, con

PTI leves, la decisión de observar vs. usar fármacos se toma caso a caso y lo más importante es siempre la clínica.

Fuente: Hematología pediátrica P13

12. Un paciente de 16 años consulta por fiebre, baja de peso y aumento de volumen cervical progresivo de algunos meses de evolución. En algunas ocasiones presenta dolor, especialmente después de tomar alcohol. En el examen físico destacan poliadenopatías cervicales izquierdas, de consistencia aumentada. Se solicita hemograma que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

a. Linfoma de Hodgkin
b. Enfermedad por arañazo de gato
c. Tuberculosis
d. Leucemia
e. Linfoma no Hodgkin

Respuesta correcta: a. Linfoma de Hodgkin

Explicación: Es la historia clásica del linfoma de Hodgkin. Además, de ser posible, se debe intervenir el consumo de alcohol a esa edad.

Fuente: Hematología pediátrica P14

13. La hemofilia habitualmente corresponde a un trastorno:

a. Autosómico dominante
b. Autosómico recesivo
c. Ligado al cromosoma X
d. Ligado al cromosoma Y
e. De herencia mitocondrial

Respuesta correcta: c. Ligado al cromosoma X

Explicación: Por eso se da en niños y no en niñas, debido a que los niños tienen solo un cromosoma X, mientras que las niñas tienen dos cromosomas X, pudiendo ser portadoras con cierta frecuencia, pero muy rara vez hemofilícas. Tanto el gen del factor VIII (hemofilia A) como del factor IX (hemofilia B) están en el cromosoma X, sin embargo, otras hemofilias más infrecuentes sí pueden presentarse en mujeres.

Fuente: Hematología pediátrica P15

14. Un niño de 7 años consulta por fiebre y compromiso del estado general, de 2 semanas de evolución, asociado a dolores óseos. Al examen destacan petequias en extremidades inferiores y esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia mieloide crónica
b. Leucemia aguda
c. Púrpura trombocitopénico inmune
d. Púrpura trombocitopénico trombótico
e. Anemia de células falciformes

Respuesta correcta: b. Leucemia aguda

Explicación: Es una leucemia aguda clásica, Por la edad, lo más probable es que sea una leucemia linfática aguda, también llamada leucemia linfocítica aguda.

Fuente: Hematología pediátrica P16

15. ¿Cuándo se inicia habitualmente la suplementación con hierro, en el lactante nacido prematuro, alimentado con lactancia materna exclusiva?

a. Al alcanzar los 2 kilogramos de peso
b. Al doblar el peso de nacimiento
c. Al cumplir los 4 meses de edad
d. Al cumplir los 6 meses de edad
e. No requiere suplementación

Respuesta correcta: b. Al doblar el peso de nacimiento

Explicación: En los prematuros el hierro se inicia al doblar el peso o al cumplir 2 meses (lo que ocurra primero) y se deja hasta los 12 meses de edad corregida. Los 2 Kg son el punto de corte para administrar la vacuna BCG.

Fuente: Hematología pediátrica P17

16. La clínica más característica de la hemofilia es:

a. Niños con equimosis, hemartrosis y hematomas profundos ante traumas pequeños
b. Adolescentes con equimosis recurrentes y menstruaciones abundantes
c. Niños con epistaxis, gingivorragia y petequias a repetición
d. Niños con petequias, equimosis y tendencia a formar cicatrices hipertróficas, ante traumas menores
e. Niños con equimosis, hematuria y hemorragias digestivas recurrentes

Respuesta correcta: a. Niños con equimosis, hemartrosis y hematomas profundos ante traumas pequeños

Explicación: Suele manifestarse desde bastante temprano y tener una clínica de alteración de la hemostasia secundaria (coagulación): hematomas, hemartrosis. Las equimosis y la epistaxis son muy frecuentes, pero, también se ven en alteraciones de la hemostasia primaria (plaquetas).

Fuente: Hematología pediátrica P18

17. Un niño de 9 años de edad presenta desde los primeros años de vida, tendencia a la epistaxis y gingivorragia. También presenta petequias y equimosis recurrentes. El examen físico no aporta más información. El examen que con mayor probabilidad se encontrará alterado es:

a. Recuento de plaquetas
b. Tiempo de protrombina
c. Tiempo de tromboplastina parcial activada
d. Tiempo de sangría
e. Fibrinogenemia

Respuesta correcta: d. Tiempo de sangría

Explicación: La clínica es de alteración de la hemostasia primaria (se ve tanto en trombocitopenias, como en disfunciones plaquetarias), que se caracterizan por alargar el tiempo de sangría. Además, por ser algo crónico, probablemente es de origen genético, por lo que se debe sospechar una enfermedad de von Willebrand, que se presenta con disfunción plaquetaria, pero sin trombocitopenia. Si hubiese sido algo más agudo, sí se pensaría en una púrpura trombocitopénica inmune, con la trombocitopenia.

Fuente: Hematología pediátrica P20

Infectología y vacunas (23)

1. Un niño de 6 años, consulta por cuadro de rinorrea, decaimiento y eritema periocular derecho. Al examen físico se constata dicho eritema alrededor del ojo derecho, con oculomotilidad normal, reflejos corneales y fotomotores conservados, agudeza visual 20/20 bilateral, sin proptosis. El diagnóstico más probable es:

a. Etmoiditis
b. Conjuntivitis bacteriana aguda
c. Dacriocistitis aguda
d. Celulitis preseptal
e. Celulitis orbitaria

Respuesta correcta: d. Celulitis preseptal

Explicación: Tienen una celulitis preorbitaria o preseptal clásica, complicación de una sinusitis bacteriana. La postseptal u orbitaria, en cambio, tiene disminución de la agudeza visual, proptosis, alteración de los reflejos o de los movimientos oculares (basta una). La etmoiditis tiene un cuadro séptico (fiebre alta y marcado compromiso general), de foco sinusal, sin eritema de la cara, aunque puede tener edema.

Fuente: Cuestionario 3.1 P14

2. Un paciente de 12 años, consulta por cuadro de fiebre alta, gran compromiso del estado general, odinofagia intensa. Al examen físico destacan faringe eritematosa, con exudado amigdalino blanco adherente, poliadenopatías cervicales y bazo palpable. En sus exámenes se aprecia hemograma con leucocitosis de 16.000 por mm3, con 80% de linfocitos, 15% de ellos atípicos. El diagnóstico más probable es:

a. Linfoma de Hodgkin
b. Linfoma no Hodgkin
c. Leucemia linfática aguda
d. Enfermedad por arañazo de gato (Bartonellosis)
e. Mononucleosis infecciosa

Respuesta correcta: e. Mononucleosis infecciosa

Explicación: Es una mononucleosis clásica. En el hemograma es frecuente que presente linfocitosis, que suele ser morderada (<20.000 por mm3) y puede tener linfocitos atípicos.

Fuente: Hematología pediátrica P12

3. El tratamiento empírico de la meningitis bacteriana aguda en niños, cuando se desconoce el agente causal, es:

a. Ceftriaxona sola
b. Ceftriaxona más vancomicina
c. Penicilina más metronidazol
d. Gentamicina más cefotaximo
e. Azitromicina sola

Respuesta correcta: b. Ceftriaxona más vancomicina

Explicación: Se agrega la vancomicina para cubrir al neumococo resistente. La ceftriaxona cubre bien a todos los demás microorganismos (neumococo, meningococo, Haemophilus, E. coli).

Fuente: Infectología pediátrica P2

4. Una niña de 5 años es traída por su madre, ya que presenta cefalea, fiebre hasta 38,5°C y vómitos. Al examen físico destaca rigidez de nuca esbozada, sin otros hallazgos de importancia. Se solicita punción lumbar que da salida a líquido claro, con 156 células, con 85% mononuclear y 15% polimorfonuclear, la glucosa del LCR es normal y las proteínas están levemente aumentadas. El diagnóstico más probable es:

a. Meningitis tuberculosa
b. Meningitis bacteriana aguda
c. Meningoencefalitis herpética
d. Meningoencefalitis viral por enterovirus
e. Absceso cerebral

Respuesta correcta: d. Meningoencefalitis viral por enterovirus

Explicación: Tienen una meningitis viral clásica, con pleocitosis mononuclear y glosa baja en LCR. No suele ser grave y se trata con analgésicos. Es la causa más frecuente de meningitis y suele ser causada por enterovirus y, en segundo lugar, por virus respiratorios. La meningitis herpética es mucho más grave y se caracteriza por una clínica grave (convulsiones, desorientación), una imagen con lesiones en los lóbulos temporales o un líquido hemorrágico (xantocromía o eritrocitos crenados); la sola sospecha de meningitis herpética obliga a dar aciclovir endovenoso; se diagnostica con PCR para VHS.

Nota del editor: La explicación original dice glucosa baja en LCR, pero el enunciado y la propia respuesta corresponden a meningitis viral, que tiene glucosa normal. Es un error de tipeo del original.

Fuente: Infectología pediátrica P3

5. En los niños, la complicación más frecuente de la varicela es:

a. Cerebelitis postvaricela
b. Neumonía varicelatosa
c. Hepatitis viral
d. Sobreinfección de las lesiones por bacterias Gram positivas
e. Síndrome de Reye

Respuesta correcta: d. Sobreinfección de las lesiones por bacterias Gram positivas

Explicación: En niños, la complicación más frecuente es la infección por S. aureus y S. pyogenes. En cambio, en adultos, son las complicaciones virales más graves, como la neumonía, encefalitis y hepatitis por virus varicela zóster. Son especialmente frecuentes (y graves) en embarazadas y pacientes inmunodeprimidos.

Fuente: Infectología pediátrica P4

6. Un niño de 10 meses presenta fiebre alta hasta 40,3°C, asociado a leve decaimiento durante los episodios febriles. Luego de 2 días presenta aparición de exantema papular, eritematoso, generalizado con lesiones pequeñas y dispersas. Paralelamente a la aparición del exantema, desaparece la fiebre y el lactante se observa en buenas condiciones. El agente causal del cuadro descrito es:

a. Enterovirus
b. Virus Herpes 6
c. Virus Epstein Baar
d. Parvovirus B19
e. Citomegalovirus

Respuesta correcta: b. Virus Herpes 6

Explicación: Tiene un exantema súbito clásico, también llamado roséola o sexta enfermedad (fiebre alta en lactante, que cede y es seguida de un exantema máculo-papular mayor en tronco). Es causado por VH6 y VH7. El diagnóstico es clínico. La fiebre se maneja con paracetamol y cuando ya cede (generalmente junto con la aparición del exantema), simplemente requiere educación.

Tiene un exantema súbito clásico: lactante con fiebre alta, que luego desaparece y da paso a un exantema macular generalizado. Revisar y aprenderse bien las clínicas de los demás exantemas (se preguntan todos y siempre).

Fuente: Infectología pediátrica P5 · Cuestionario 3.1 P4

7. Un niño de 6 meses recibe las vacunas correspondientes a su edad, presentando compromiso del estado general, fiebre alta y convulsiona en una oportunidad. ¿Cuál de las vacunas es la causante de este cuadro, con mayor probabilidad?

a. Difteria
b. Tétanos
c. Pertusis celular
d. Polio
e. Hepatitis B

Respuesta correcta: c. Pertusis celular

Explicación: Es una pregunta antigua, pero que vale la pena recordar. Actualmente en Chile ya no se usa la vacuna pertusis celular, dada la alta tasa de efectos adversos que tiene. La vacuna triple (difteria, pertusis celular y tétanos) fue reemplazada por la vacuna hexavalente (difteria, pertusis acelular, tétanos, VHB y polio parenteral).

Fuente: Infectología pediátrica P6

8. El tratamiento antibiótico de elección para la celulitis orbitaria es:

a. Cefazolina endovenosa
b. Cloxacilina oral
c. Ceftriaxona + vancomicina endovenosa
d. Gentamicina endovenosa
e. Ciprofloxacino oral

Respuesta correcta: c. Ceftriaxona + vancomicina endovenosa

Explicación: En la celulitis preorbitaria o preseptales se usan antibióticos orales, tales como amoxicilina más ácido clavulánico o cefuroximo (aceptable levofloxacino, aunque se evita en niños). En cambio, en las celulitis orbitarias o postseptales se indican antibióticos endovenosos con ceftriaxona (cubren neumococo y Haemophilus) y vancomicina (cubre S. aureus, incluyendo SAMR) y, si hay un absceso o una sinusitis crónica de base, se agrega metronidazol para cubrir anaeribios.

Fuente: Infectología pediátrica P7

9. Una mujer de 34 años, portadora de una infección crónica por el virus de la hepatitis B, da a luz a un recién nacido de término sin patología aparente. La conducta más adecuada, para con este recién nacido, es:

a. Iniciar lamivudina y suspender la lactancia materna
b. Administrar inmunoglobulina hiperinmune anti-VHB e iniciar lamivudina
c. Administrar inmunoglobulina hiperinmune anti-VHB y la primera dosis de la vacuna anti-hepatitis B
d. Administrar la primera dosis de la vacuna anti-hepatitis B y suspender la lactancia materna
e. Vacunar contra la hepatitis B e iniciar lamivudina

Respuesta correcta: c. Administrar inmunoglobulina hiperinmune anti-VHB y la primera dosis de la vacuna anti-hepatitis B

Explicación: Las hepatitis B y C no contraindican la lactancia materna. La hepatitis B materna obliga a 1. Vacunar al recién nacido, 2. Dar inmunoglobulina G hiperinmune contra VHB al recién nacido y 3. Realizar seguimiento al recién nacido para ver si finalmente se contagia o no y, en caso de que se contagie, ver si cronifica o no.

El niño hijo de madre con hepatitis B crónica debe recibir gamaglobulina específica hiperinmune contra VHB, vacunarse anticipadamente y seguirse periódicamente para ver si contrae o no la infección y, en caso de contraerla, determinar si cronifica o no. Puede tomar leche materna.

Fuente: Infectología pediátrica P8 · Digestivo pediátrico P25

10. Respecto a la infección por VIH en el niño es FALSO que:

a. La vía de contagio más frecuente es la vertical
b. El curso de la enfermedad suele ser más lento que en los adultos
c. La manifestación más frecuente es la candidiasis oral
d. El diagnóstico en los recién nacidos debe hacerse con PCR o carga viral y no con ELISA
e. A fin de prevenirlo, debe suspenderse la lactancia materna, si la madre está infectada

Respuesta correcta: b. El curso de la enfermedad suele ser más lento que en los adultos

Explicación: Suele ser más agresiva en los niños. El resto de opciones son verdaderas.

Fuente: Infectología pediátrica P9

11. Una niña de 4 años presenta desde hace 5 días erosiones amarillas, costrosas debajo de las narinas y en las mejillas, el mentón y las extremidades superiores Por lo demás la niña está bien y no tiene alergias conocidas a medicamentos. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento más indicado?

a. Cefadroxilo oral
b. Aciclovir tópico
c. Coprofloxacino oral
d. Mupirocina tópica
e. Ceftriaxona endovenosa

Respuesta correcta: a. Cefadroxilo oral

Explicación: Tiene un impétigo y por estar tan generalizado, se prefiere la vía oral (cefadroxilo, flucloxacilina o amoxicilina más ácido clavulánico sirven, ya que cubren tanto S. aureus como S. pyogenes), por sobre la tópica (mupirocina).

Fuente: Infectología pediátrica P10

12. Un niño de 8 meses presenta fiebre hasta 38,6°C, sin otros síntomas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, sin hallazgos patológicos. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar antipiréticos, solicitar hemograma y sedimento de orina y decidir conducta según resultados
b. Iniciar cefadroxilo oral y antipiréticos, sin necesidad de exámenes
c. Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento, sin necesidad de mayor estudio
d. Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos y solicitar hemograma, VHS, sedimento de orina, urocultivo, radiografía de tórax y punción lumbar, decidiendo manejo según resultados
e. Iniciar antipiréticos y claritromicina, controlando en 48 horas o en caso de empeoramiento

Respuesta correcta: c. Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento, sin necesidad de mayor estudio

Explicación: - En menores de 28 días se maneja como una sepsis (muchos exámenes, incluida punción lumbar, más antibióticos empíricos).

- Con aspecto séptico, a cualquier edad, también se maneja como una sepsis.

- Si está de bien aspecto, entre los 29 días y 3 meses de vida, se piden exámenes generales (orina, hemograma, parámetros inflamatorios: PCR, procalcitonina), en busca de una causa (no se pide punción lumbar ni se dan antibióticos).

- Si tiene más de 3 meses y está de buen aspecto, no se debe pedir ningún examen, a menos que lleve más de 5 días (se busca Kawasaki y PIMPS) o que tenga 39°C o más, en que se piden exámenes de orina.

Fuente: Infectología pediátrica P11

13. Un niño de 13 años consulta por compromiso del estado general y fiebre alta, hasta 40°C, asociado a odinofagia. Al examen destaca faringe eritematosa, con exudado amigdalino blanco adherente. Se palpan varias adenopatías cervicales, axilares e inguinales. Se solicita hemograma que demuestra leucocitosis de 17.000, con 90% de linfocitos, algunos de ellos atípicos. El diagnóstico más probable es:

a. Herpangina
b. Faringoamigdalitis estreptocócica
c. Mononucleosis infecciosa
d. Infección por VIH
e. Linfoma

Respuesta correcta: c. Mononucleosis infecciosa

Explicación: Es una mononucleosis clásica.

Fuente: Infectología pediátrica P12

14. Los agentes etiológicos más frecuentes de la sepsis neonatal son:

a. Streptococcus pyogenes y Staphilococcus aureus
b. Streptococcus agalactiae y Staphilococcus aureus
c. Streptococcus agalactiae y Escherichia coli
d. Streptococcus pneumoniae y Streptococcus agalactiae
e. Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae

Respuesta correcta: c. Streptococcus agalactiae y Escherichia coli

Explicación: Los gérmenes más importantes de las infecciones neonatales son S. agalactiae (o estreptococo betahemolítico grupo B), E. coli y luego Listeria. Después de las primeras 72 horas (sepsis tardía), comienzan a aparecer todo tipo de otras bacterias.

Fuente: Infectología pediátrica P13

15. ¿Cuál de los siguientes pacientes NO requiere de profilaxis antibiótica de endocarditis bacteriana?

a. Válvula aórtica bicúspide con endocarditis previa
b. Comunicación interauricular tipo ostium secundum no corregida
c. Comunicación interventricular no corregida
d. Coartación de la aorta no corregida
e. Tetralogía de Fallot no corregida

Respuesta correcta: b. Comunicación interauricular tipo ostium secundum no corregida

Explicación: En procedimientos dentales invasivos, se recomienda profilaxis con amoxicilina solo en pacientes con condiciones de alto riesgo de endocarditis, que incluyen: 1. Prótesis valvulares, 2. Endocarditis previa, 3. Cardiopatías congénitas no corregidas o con correcciones que incluyan prótesis. La evidencia no demuestra utilidad en otras situaciones, pero, en la práctica, se deja también en las cardiopatías congénitas corregidas. La gran excepción es la CIA tipo ostium secundum que no tiene mayor riesgo.

Fuente: Infectología pediátrica P14

16. ¿Cuál es el agente causal de la mayoría de las neumonías del lactante menor de un año?

a. Neumococo
b. Haemophilus influenza
c. Mycoplasma pneumoniae
d. Adenovirus
e. Virus respiratorio sincicial

Respuesta correcta: e. Virus respiratorio sincicial

Explicación: El VRS es el causante de la mayor parte de las infecciones respiratorias bajas. Por ser viral se le suele llamar “neumonitis” o “neumonía viral”, para diferenciarla de la neumonía bacteriana, que muchas veces se llama simplemente “neumonía”.

Fuente: Infectología pediátrica P15

17. ¿Qué vacunas debe recibir un niño a los 18 meses, según el plan nacional de inmunizaciones?

a. Hexavalente y antineumocócica
b. Sólo Hexavalente
c. Hexavalente, varicela y hepatitis A
d. Hexavalente y trivírica
e. Pentavalente, trivírica y polio oral

Respuesta correcta: c. Hexavalente, varicela y hepatitis A

Explicación: - La BCG se pone al nacer. En prematuros se pone a los 2 kilos de peso (es la única vacuna que se ajusta según edad en prematuros).

- La hexavalente (DPaT, VHB y polio inactivada) se da a los 2, 4, 6 y 18 meses.

- La antineumocócica conjugada, a los 2 y 4 (también 6 meses en los prematuros), más un refuerzo a los 12 meses (después de los 65 años se da la polisacárida cada 5 años).

- La varicela se da a los 18 y 36 meses.

- La hepatitis A, a los 18 meses. La trivírica a los 12 y 36 meses. La pentavalente y polio oral fueron reemplazadas por la hexavalente.

- En el colegio se vacuna con la DPaT en 1° y 8° básico y con la VPH en 4° y 5° básico.

Fuente: Infectología pediátrica P16

18. Niño de 2 años consulta por cuadro de 2 días de evolución de otalgia y otorrea escasa a derecha. A la otoscopía se observa el tímpano derecho eritematoso y abombado, con salida de pus escasa. El tratamiento antibiótico de elección es:

a. Amoxicilina
b. Cefadroxilo
c. Amoxicilina más ácido clavulánico
d. Azitromicina
e. Ciprofloxacino

Respuesta correcta: a. Amoxicilina

Explicación: Tiene una OMA común y corriente, que se trata con amoxicilina.

Fuente: Infectología pediátrica P17

19. Un niño de 7 años presenta un cuadro de rinorrea y tos con escasa expectoración mucosa desde hace 7 días. En las últimas 48 horas aumenta la tos, la que se hace productiva y se agrega fiebre hasta 38,5°C y disnea de grandes esfuerzos. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, sin cianosis ni uso de musculatura accesoria y satura 97% con FiO2 ambiental. Al examen pulmonar se auscultan crepitaciones y sibilancias escasas, mayores en las bases. Se solicita radiografía de tórax que muestra un patrón de relleno alveolo- intersticial, mayor en la base izquierda. El tratamiento antibiótico de elección es:

a. Azitromicina
b. Amoxicilina
c. Ceftriaxona
d. Vancomicina
e. Amoxicilina más ácido clavulánico

Respuesta correcta: a. Azitromicina

Explicación: Tiene una NAC atípica, que se trata con macrólidos.

Fuente: Infectología pediátrica P18

20. El agente etiológico más frecuente de las infecciones congénitas (TORCH) es:

a. Virus de la rubeola
b. Toxoplasma
c. Citomegalovirus
d. Virus herpes simplex
e. Tripanosoma cruzi

Respuesta correcta: c. Citomegalovirus

Explicación: CMV es más frecuente que otras causas, aunque varía según el año.

Fuente: Infectología pediátrica P19

21. Un niño de 8 meses presenta diarrea acuosa, explosiva, asociada a fiebre leve. Al examen físico se observa moderadamente deshidratado. El agente causal más probable es:

a. Rotavirus
b. Escherichia coli
c. Enterovirus
d. Salmonella
e. Shigella

Respuesta correcta: a. Rotavirus

Explicación: Es una diarrea aguda en un lactante, por lo que el rotavirus es lo más probable. Es frecuente que tenga fiebre, ya sea antes o concomitantemente con el inicio de la diarrea. También puede tener vómitos. La disentería, en cambio, obliga a pensar en infecciones bacterianas (Shigella y E. coli enteroinvasora o enterohemorrágica).

Fuente: Infectología pediátrica P20

22. ¿Cuál de las siguientes vacunas puede administrarse a un paciente inmunodeprimido severo?

a. Varicela
b. Polio oral
c. Hepatitis A
d. Trivírica
e. BCG

Respuesta correcta: c. Hepatitis A

Explicación: La hepatitis A es una vacuna generalmente inactivada, por lo que no tiene riesgo en los pacientes inmunodeprimidos. Las demás son a microorganismo vivo, por lo que están contraindicadas en pacientes muy inmunodeprimidos (se debes esperar a que mejore la inmunidad antes de vacunar). Como comentario adicional, también se suele recomendar retrasar en un año la vacunación con virus vivos atenuados en los pacientes que han recibido inmunoglobulinas, ya que destruyen al virus vacuna, antes de que puedan hacer efecto.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P7

23. Usted atiende a un recién nacido de 20 días de vida, nacido por cesárea, que se alimenta con fórmula y que es hijo de madre VIH positivo en terapia antirretroviral, con cargas virales bajas. Se realizó ELISA para VIH que resultó positivo. La conducta más adecuada es

a. Solicitar nuevo ELISA inmediatamente
b. Confirmar la infección con Western Blot
c. Iniciar terapia antirretroviral
d. Indicar vacunación anti-hepatitis B y BCG inmediatamente
e. Tranquilizar a la madre y explicarle que con alta probabilidad corresponde a un falso positivo

Respuesta correcta: e. Tranquilizar a la madre y explicarle que con alta probabilidad corresponde a un falso positivo

Explicación: Si bien no es posible descartar 100% que tenga VIH, sí es posible asegurar que su riesgo es mínimo, al haber nacido por cesárea y, lo más importante, al haber recibido TAR, manteniendo cargas virales bajas. Además, nunca debió haberse pedido un Elisa al recién nacido, ya que sale falsamente positivo, debido a los anticuerpos maternos. Por eso es que en los recién nacidos y lactantes el diagnóstico de VIH se realiza con PCR u otro examen que mida directamente el virus y no los anticuerpos. Por ello no sirve el Elisa ni el Western Blot.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P14

Inmunología y reumatología (16)

1. Una niña de 5 años presenta fiebre intermitente de 3 semanas de evolución, acompañada en algunas oportunidades de un rash eritematoso macular, que compromete el tronco y la zona proximal de las extremidades que desaparece al ceder la fiebre. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata artritis del tobillo derecho y de la tercera y cuarta articulaciones metacarpofalángica izquierdas. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus infantil
b. Púrpura de Schönlein Henoch
c. Enfermedad de Kawasaki
d. Artritis juvenil idiopática
e. Poliangeítis microscópica

Respuesta correcta: d. Artritis juvenil idiopática

Explicación: Tiene una artritis juvenil idiopática o artritis reumatoide juvenil clásica, con la fiebre, el rash evanescente y la artritis de varias articulaciones. El lupus infantil tendría más síntomas de lupus (mariposa lúpica, afectación renal o hematológica, etc.). La púrpura de Schönlein Henoch tiene un rash petequial o purpúrico de extremidades inferiores, sin fiebre habitualmente, con glomerulonefritis, afectación gastrointestinal y articular. La enfermedad de Kawasaki tendría fiebre, más ojo rojo, boca roja, adenopatías, rash y compromiso de manos y pies. La PAM es una vasculitis de vaso pequeño, muy agresiva, que produce falla renal, mononeuritis múltiples y afectación pulmonar y afecta habitualmente a mayores de 55 años.
El rash evanescente (aparece con la fiebre y desaparece al bajar la temperatura) es característco es característico de la artritis juvenil idiopática (en adultos se la suele llamar enfermedad de Still). Su diagnóstico es principalmente clínico, aunque se puede apoyar en el aumento marcado de la ferritina plasmática, a pesar de que es un examen algo inespecífico, ya que puede elevarse en muchas otras patologías inflamatorias, al ser un reactante de fase aguda. Por tanto, el diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico. El tratamiento es con AINEs y, si no responde, se agregan los corticoides y/o terapia biológica.

Fuente: Cuestionario 3.1 P8 · Reumatología e Inmunología pediátrica P1

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es el tipo más frecuente de inmunodeficiencia congénita, en la población pediátrica?

a. Alteraciones de la inmunidad celular
b. Alteraciones de la inmunidad humoral (anticuerpos)
c. Alteraciones de la fagocitosis
d. Déficit de complemento
e. Infección por VIH

Respuesta correcta: b. Alteraciones de la inmunidad humoral (anticuerpos)

Explicación: Las inmunodeficiencias adquiridas son mucho más frecuentes que las primarias (ej. cáncer, desnutrición, VIH, infecciones debilitantes, etc.). Sin embrago, dentro de las primarias, el déficit de IgA es la más frecuente, aunque la mayoría de los pacientes no tienen mayores síntomas o complicaciones, por lo que es un diagnóstico de exclusión, que exige que no haya déficit de IgG o de subclases. Luego vienen los déficit

de IgG, en especial en su presentación de inmunodeficiencia común variable, déficit de subclases de IgG (mayoría también asintomático), hipogamaglobulinemia y agamaglobulinemia. El manejo suele ser con 1. Vacunas conjugadas, 2. Antibióticos durante las infecciones, 3. Antibióticos profilácticos en casos de recurrencias y 4. en los casos muy severos (ej. agamaglobulinemia), se dan inmunoglobulinas endovenosas.

Fuente: Hematología pediátrica P7

3. ¿Qué tipo de inmunodeficiencia debe sospecharse en primer lugar, ante un paciente que presenta infecciones meningocócicas a repetición?

a. Déficit de inmunoglobulina A
b. Déficit de complemento
c. Alteraciones de la fagocitosis
d. Alteración de los linfocitos T
e. Déficit de subclases de IgG

Respuesta correcta: b. Déficit de complemento

Explicación: El déficit de complemento es una inmunodeficiencia rara, pero lo clásico es que se caracteriza específicamente por infecciones meningocócicas a repetición. Eso sí, otras inmunodeficiencias también pueden producirlas, en especial, las deficiencias de anticuerpos IgG (agamaglobulinemia, déficit de subclases de IgG, inmunodeficiencia común variable, etc.), aunque en ellas también son frecuentes las infecciones por otros capsulados, como neumococo y Haemophilus, siendo mucho más frecuentes las infecciones nasosinusales y respiratorias que las meningitis.

Fuente: Hematología pediátrica P19

4. El agente etiológico más frecuente de la artritis séptica en escolares es:

a. Streptococcus pyogenes
b. Streptococcus agalactiae
c. Streptococcus pneumoniae
d. Staphilococcus aureus
e. Staphilococcus epidermidis

Respuesta correcta: d. Staphilococcus aureus

Explicación: Actualmente, en casi todos grupos etarios, el agente causal más frecuente de la artritis séptica es el S. aureus. Los neonatos son la excepción, ya que pueden ser causadas por varias bacterias, incluyendo Streptococcus, Staphylococcus y Neisseria.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P2

5. El mejor examen para evaluar el desarrollo de complicaciones y por tanto, el pronóstico de un paciente con enfermedad de Kawasaki es:

a. Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA)
b. Hemograma-VHS
c. Ecocardiograma
d. Coronariografía
e. Orina completa

Respuesta correcta: c. Ecocardiograma

Explicación: El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki es clínico. Sin embargo, es obligatorio solicitar una ecocardiografía, para determinar la presencia de aneurismas coronarios, que a largo plazo evolucionan a enfermedad coronaria. Los aneurismas coronarios, por tanto, son la complicación más importante. En agudo también pueden complicarse con miocarditis. En los casos con presentación incompleta (ej. 2 o 3 criterios, sin otra causa que los explique), la ecocardiografía puede tener un rol diagnóstico. El tratamiento es con inmunoglobulina en alta dosis (lo más importante) y aspirina.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P3

6. Un lactante de 4 meses, con mal incremento pondoestatural ha presentado varios cuadros de neumonía y diarreas, de difícil tratamiento. Actualmente cursando síndrome diarreico. Al examen físico destaca presencia de algorra y candidiasis anogenital. Un hermano falleció tempranamente por neumonía. El diagnóstico más probable es:

a. Agamaglobulinemia ligada al sexo
b. Déficit de complemento
c. Inmunodeficiencia común variable
d. Inmunodeficiencia combinada severa
e. Síndrome de inmunodeficienca adquirida (SIDA)

Respuesta correcta: d. Inmunodeficiencia combinada severa

Explicación: Es una inmunodeficiencia combinada severa clásica, que se presenta con infecciones oportunistas similares a las del VIH, desde muy temprano. Es rara, pero muy grave y suele tener marcada disminución de los linfocitos T (además pueden estar afectados los linfocitos B y NK). Su tratamiento es el aislamiento estricto, más inmunoglobulina y antibióticos profilácticos. Sin embargo, el tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea, sin lo cual suelen morir. En algunos casos seleccionados, se puede usar terapia génica, con cierto éxito.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P4

7. Un paciente de 14 años de edad tiene una historia desde la infancia de sinusitis de repetición, giardiasis y bronquitis crónica. Debemos sospechar:

a. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
b. Inmunodeficiencia común variable
c. Alteración de los linfocitos T
d. Agammaglobulinemia
e. Agenesia esplénica

Respuesta correcta: b. Inmunodeficiencia común variable

Explicación: Su cuadro es compatible con un déficit de IgA (diagnóstico de descarte, que exige IgA disminuida sin otras alteraciones inmunológicas) y con un déficit de IgG, incluyendo la inmunodeficiencia común variable, que suele presentarse en escolares grandes, adolescentes e incluso adultos jóvenes. En cambio la agamaglobulinemia suele ser más severa y se presenta después de los 6-12 meses de edad. El tratamiento de la inmunodeficiencia común variable suele ser la vacunación contra capsulados (antineumocócica y antimeningocócica), más antibióticos en las infecciones, antibióticos profilácticos en los casos con muchas recurrencias y con IgG endovenosa en los casos refractarios o muy severos.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P5

8. Un niño consulta por fiebre de 7 días de evolución, asociado a un rash papuloeritematoso generalizado. En el examen se observa eritema e inyección conjuntival. Los labios y la lengua están enrojecidos y aumentados de volumen. Se palpan 2 adenopatías cervicales anteriores, la mayor de ellas de 2,5 cm. Además se constata edema, eritema y fina descamación en ambos pies. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia linfoblástica aguda
b. Sarampión
c. Escarlatina
d. Púrpura de Schönlein Henoch
e. Enfermedad de Kawasaki

Respuesta correcta: e. Enfermedad de Kawasaki

Explicación: Tiene una enfermedad de Kawasaki clásica, cumpliendo los criterios diagnósticos, que consisten en fiebre de 5 días más al menos 4 de 5 criterios: 1. Ojo rojo, 2. Boca roja, 3. Adenopatías, 4. Rash maculopapular, 5. Eritema o edama de manos y/o pies.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P8

9. Un adolescente de 14 años presenta artralgias de rodillas y tobillos, asociadas a un rash eritematoso palpable en glúteos y piernas. Presenta además hematuria en 3 oportunidades y hematoquecia en una ocasión. El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura trombocitopénico inmune
b. Púrpura trombocitopénico trombótico
c. Púrpura de Schönlein-Henoch
d. Lupus infantil
e. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

Respuesta correcta: c. Púrpura de Schönlein-Henoch

Explicación: Es una PSH clásica, cuyo diagnóstico es clínico y que suele ser un cuadro autolimitado. Sin embargo, se suele tratar con prednisona oral cuando tiene afectación relevante de los órganos, tales como artritis, compromiso renal o gastrointestinal, como en este caso.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P10

10. ¿Cuál de los siguientes virus suelen producir artritis frecuentemente?

a. Parotiditis y rubeola
b. Enterovirus y virus herpes 6
c. Virus varicela zóster y virus hepatitis A
d. Parvovirus B19 y rubeola
e. Parotiditis y sarampión

Respuesta correcta: d. Parvovirus B19 y rubeola

Explicación: Aunque varía según el año (ej. en la pandemia Covid-19, la causa más frecuente fue precisamente el SARS CoV2), las clásicas etiologías son el parvovirus B19 y el virus rubeola (aunque con la vacunación suele ser el virus rubeola de la vacuna y no el salvaje). Otras causas incluyen enterovirus, citomegalovirus, VHA, VHC, VIH. En otros países, además, se suma el dengue, zika y chikungunya.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P11

11. Un niño de 8 años presenta artralgias y artritis de manos y pies, asociada a compromiso del estado general. El examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes de laboratorio destaca elevación importante de la ferritina plasmática y elevación moderada de la PCR y VHS. El diagnóstico más probable es:

a. Artritis por cristales
b. Hemocromatosis
c. Artritis viral
d. Artritis reactiva
e. Artritis juvenil idiopática

Respuesta correcta: e. Artritis juvenil idiopática

Explicación: La ferritina, aunque inespecífica, es el marcador de la artritis juvenil idiopática, elevándose más que en otras patologías inflamatorias.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P12

12. Un niño de 6 años sufre accidente en bicicleta, golpeándose el abdomen y resultando con rotura del bazo, por lo que es esplenectomizado. ¿Qué conducta adicional debe tomarse?

a. Administrar inmunoglobulina genérica endovenosa cada 3 meses
b. Vacuna antipneumocócica cada 5 años y antigripal anual
c. Profilaxis antibiótica de endocarditis bacteriana durante procedimientos dentales, gastrointestinales y genitourinarios
d. Control anual de PPD y profilaxis con isoniazida según resultados
e. Refuerzo de BCG cada 3 años

Respuesta correcta: b. Vacuna antipneumocócica cada 5 años y antigripal anual

Explicación: La asplenia, ya sea por esplenectomía (ej. por PTI refractario o traumatismo) se presenta similar a una inmunodeficiencia humoral, con infecciones por capsulados, especialmente neumococo. Suele bastar con una adecuada vacunación contra capsulados. Si se presentan infecciones recurrentes, pues se maneja igual que las inmunodeficiencias humorales no severas, con antibióticos y, de última línea, con IgG endovenosa.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P13

13. ¿Cuál de las siguientes patologías es causada por autoinmunidad de tipo 1?

a. Dermatitis herpetiforme
b. Artritis juvenil idiopática
c. Glomerulonefritis postestreptocócica
d. Lupus infantil
e. Rinitis alérgica

Respuesta correcta: e. Rinitis alérgica

Explicación: La autoinmunidad tipo 1 es aquella mediada por IgE (asma, urticaria, rinitis alérgica). La tipo 2 es mediada por anticuerpos IgA o IgG (ej. pénfigo, tiroiditis de Hashimoto, etc.). La tipo 3 es mediada por complejos inmune (ej. Lupus, GNAPE). La tipo 4 es mediada por linfocitos T (ej. psoriasis, dermatitis de contacto alérgica, liquen plano). Algunos incluyen la tipo 5, que también es mediada por linfocitos T, pero con una reacción granulomatosa (ej. enfermedad de Cröhn, sarcoidosis).

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P15

14. La causa más frecuente de artritis en la edad pediátrica es:

a. Bacteriana
b. Traumática
c. Viral
d. Degenerativa
e. Autoinmune

Respuesta correcta: b. Traumática

Explicación: Es traumática.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P16

15. Un niño de 10 años ha presentado 3 meningitis meningocócicas, con buena respuesta al tratamiento antibiótico. ¿Qué examen estará alterado con mayor probabilidad?

a. Inmunoglobulina A
b. Inmunoglobulina G
c. Subclases de inmunoglobulina G
d. Subpoblaciones de linfocitos
e. Complemento

Respuesta correcta: e. Complemento

Explicación: El déficit de complemento se caracteriza por infecciones meningocócicas a repetición.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P18

16. ¿Cuál es la utilidad de las vacunas conjugadas?

a. Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos proteicos en menores de 5 años
b. Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos polisacáridos en mayores de 5 años
c. Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos proteicos en menores de 2 años
d. Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos polisacáridos en menores de 2 años
e. Permiten desarrollar inmunidad en pacientes inmunodeprimidos que tienen contraindicadas las vacunas no conjugadas

Respuesta correcta: d. Permiten desarrollar inmunidad contra antígenos polisacáridos en menores de 2 años

Explicación: Los menores de 2 años no suelen tener una buena respuesta inmune contra los antígenos polisacáridos, por lo que se prefieren las vacunas conjugadas (con toxoide tetánico), dejando las vacunas polisacáridas para mayores de 2 años. Son importante en las bacterias casuladas, tales como neumococo, meningococo y Haemophilus.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P19

Neurología (34)

1. Un niño de 24 meses aún no camina y tiene dificultades para mover las manos, sin embargo habla y no ha perdido los hitos del desarrollo motor que ha ido logrando. Al examen físico tiene hipertonía de las 4 extremidades. El diagnóstico más probable es:

a. Tumor cerebral
b. Poliomielitis por vacuna
c. Parálisis cerebral
d. Distrofia muscular de Duchemne
e. Polineuropatía metabólica

Respuesta correcta: c. Parálisis cerebral

Explicación: Es una parálisis cerebral clásica, que no pierde los hitos ganados. La mayoría tiene solo afectación motora, sin afectación del lenguaje, cognitiva ni sensitiva.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P7

2. Un paciente de 8 años consulta por cuadro de debilidad de las 4 extremidades y dolor en extremidades inferiores Al examen se constata tetraparesia, con abolición de reflejos osteotendíneos y disminución del tono muscular. El diagnóstico más probable es:

a. Mielitis transversa
b. Miastenia gravis
c. Síndrome de Guillan-Barré
d. Déficit de vitamina B12
e. Intoxicación por anticolinérgicos

Respuesta correcta: c. Síndrome de Guillan-Barré

Explicación: Tiene un síndrome de Guillain Barré clásico. Ver resumen de semiología neurológica.

Fuente: Neurología pediátrica P1

3. Cuál de las siguientes opciones corresponde a una asociación INCORRECTA entre un reflejo arcaico y su edad de desaparición?

a. Prensión plantar – 3 meses
b. Prensión palmar – 3 meses
c. Moro – 6 meses
d. Marcha automática – 3 meses
e. Búsqueda – 3 meses

Respuesta correcta: a. Prensión plantar – 3 meses

Explicación: La mayoría de los reflejos arcaicos está presente al nacimiento y desaparecen a los 3 meses.
- El de moro puede durar hasta los 4 a 6 meses.

- El de prensión plantar puede durar hasta los 9 o 10 meses, que es cuando comienza a pararse. Por otro lado, desde los 5-6 meses van apareciendo los reflejos de paracaídas: ponen las manos para apoyarse y evitar la caída.

Fuente: Neurología pediátrica P2

4. Un niño de 3 años presenta cuadro de odinofagia, fiebre alta y tos irritativa escasa. Presenta convulsión tónico clónica en una oportunidad, de 2 minutos de duración. Habría presentado otra convulsión febril hace 1 mes, en relación a fiebre alta. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni signos meníngeos. La faringe se observa eritematosa, sin exudado. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar, iniciar antibióticos y realizar punción lumbar
b. Enviar a domicilio, indicando paracetamol durante los cuadros febriles, sin necesidad de anticonvulsivantes
c. Iniciar ácido valproico y solicitar resonancia magnética nuclear
d. Enviar a domicilio, indicando fenobarbital por un año
e. Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según hallazgos

Respuesta correcta: b. Enviar a domicilio, indicando paracetamol durante los cuadros febriles, sin necesidad de anticonvulsivantes

Explicación: Lo importante es saber que las convulsiones febriles son frecuentes, banales y que lo más importante es simplemente educar. Ocurren entre los 6 meses y los 5 años de edad (fuera de este rango, se tienen que descartar otras patologías, como meningitis o epilepsia).

- Eso sí, si está séptico o tiene signos meníngeos, se estudia con punción lumbar y se dan antibióticos, ya que puede tratarse de una meningitis infecciosa.

- En cambio, si es una convulsión febril simple, solo se educa y se dan antipiréticos durante la fiebre a fin de evitar la probabilidad de que convulsiones.

- Lo anticonvulsivantes (Lorazepam 0,05 a 0,1 mg/Kg ev) solo se usan si está convulsionando al momento de la atención.

- Si es una convulsión febril compleja (dura más de 15 minutos, tiene focalidad o parálisis de Todd, o si tiene dos o más en el mismo día), es conveniente estudiarlo con una imagen y/o un electroencefalograma según la sospecha.

- El manejo de las recurrencias (como en este caso) es controvertido, pero, actualmente, la mayoría de las recomendaciones apuntan a simplemente educar y explicar que es frecuente que recurran (30%) y que, mientras no haya signos de alarma, no es necesario estudiarlos ni dejar anticonvulsivantes, puesto que los riesgo de esos medicamentos superan los beneficios, al tratarse de crisis sin mayor repercusión (alguno sí indican diazepam rectal en la casa si las crisis recurrentes duran mucho: más de 5 minutos).

- En los casos en que ha tenido convulsiones sin fiebre, se trata de una epilepsia. En los casos en que hay antecedentes familiares de epilepsia también es correcto estudiarlo.

Fuente: Neurología pediátrica P3

5. El examen de elección para evaluar a un niño que sufre una convulsión tónico clónica autolimitada y cuyo examen físico y exámenes de laboratorio son normales, es:

a. Electroencefalograma
b. TAC de cerebro sin contraste
c. Resonancia magnética nuclear de cerebro
d. Electromiografía
e. Creatinfosfokinasa plasmática

Respuesta correcta: a. Electroencefalograma

Explicación: En la actualidad, tanto las neuroimágenes como el electroencefalograma se deben solicitar en los niños con una primera convulsión (antes se dejaban las neuroimágenes para las crisis focales y el EEG para las generalizadas, pero hoy se piden ambos). Sin embargo, en primer lugar, siempre, se deben descartar otras causas de convulsiones, como hipoglicemia, alteraciones de la natremia, meningitis, entre otras. Hay casos en que la neuroimagen es el examen más urgente a realizar: convulsiones focales, signos focales y compromiso de conciencia que persiste. En los demás casos, el EEG es el examen más importante y que debe realizarse cuanto antes, ya que su sensibilidad aumenta al estar más cerca de la convulsión (se realiza despierto y durmiendo). Tanto TAC como RMN son muy útiles como neuroimágenes: la TAC suele estar más rápido y la RMN suele ver más detalles, por lo que se prefieren en urgencia y ambulatorio, respectivamente.

Fuente: Neurología pediátrica P4

6. Un niño de 2 años, consulta por cuadro de cefalea y fiebre hasta 38,7°C, asociado a estrabismo divergente. Al examen físico se constata parálisis del tercer nervio craneal derecho y signos meníngeos esbozados, por lo que se decide realizar punción lumbar que demuestra un líquido cefaloraquídeo con proteínas aumentadas, glucosa disminuida y pleocitosis, con 86% de mononucleares. El diagnóstico más probable es:

a. Meningitis viral
b. Meningitis tuberculosa
c. Meningitis bacteriana aguda
d. Encefalitis herpética
e. Absceso cerebral

Respuesta correcta: b. Meningitis tuberculosa

Explicación: Tanto por la parálisis del III nervio craneal como por el líquido con pleocitosis mononuclear e hipoglucorraquia, lo más probable es que sea una meningitis tuberculosa. La bacteriana tiene pleocitosis polimorfonuclear. Las virales tienen glucosa normal y pleocitosis mononuclear (la herpética, además, tiene líquido hemorrágico).

Fuente: Neurología pediátrica P5

7. La triada de cefalea, vómitos y papiledema, es característica de:

a. Hidrocefalia
b. Meningitis viral
c. Glaucoma congénito
d. Hipertensión endocraneana
e. Migraña

Respuesta correcta: d. Hipertensión endocraneana

Explicación: Es una HTEC clásica. Ver semiología neurológica.

Ver semiología neurológica.

Fuente: Neurología pediátrica P6 · Neuropsiquiatría pediátrica P11

8. Un niño de 5 años inicia cefalea progresiva, asociada a caídas frecuentes y luego dificultad para caminar, de 2 semanas de evolución. La cefalea suele ser mayor en las mañanas y ha aumentado considerablemente en los últimos días. Al examen físico se corrobora ataxia de la marcha y dismetría de extremidades, mayor a derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Poliomielitis
b. Tumor del sistema nervioso central
c. Epilepsia focal
d. Accidente vascular cerebral
e. Pseudotumor cerebral

Respuesta correcta: b. Tumor del sistema nervioso central

Explicación: Tiene clínica de un tumor cerebral (ver semiología neurológica). Por el síndrome cerebeloso, lo más probable es que sea un meduloblastoma, que suele ubicarse en el cuarto ventrículo.

Fuente: Neurología pediátrica P7

9. Un niño de 3 años sufre caída a nivel mientras jugaba, golpeándose la cabeza contra un árbol y evolucionando con aparición de aumento de volumen en la zona del golpe. No perdió la conciencia ni presentó vómitos. Al examen se observa en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica. Se observa un hematoma de 3,5 cm en la zona frontal. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio con indicación de reconsultar en caso de aparición de signos de alarma
b. Observar hospitalizado por 24 horas sin necesidad de realizar imágenes
c. Solicitar radiografía de cráneo y decidir manejo según hallazgos
d. Solicitar TAC de cerebro y de cráneo, sin medio de contraste y decidir manejo según resultados
e. Realizar punción del hematoma e iniciar analgesia endovenosa

Respuesta correcta: a. Enviar a domicilio con indicación de reconsultar en caso de aparición de signos de alarma

Explicación: TEC simple en mayor de 2 años, se observa. En menores de 2 años, por regla general, se estudia con una TAC, salvo que sea un niño con un golpe de baja energía, que no tenga ninguna alteración de ningún tipo (ni chichón).

Fuente: Neurología pediátrica P10

10. La causa más frecuente de macrocefalia es:

a. Hidrocefalia
b. Meningitis
c. Infecciones congénitas
d. Constitucional
e. Postraumática

Respuesta correcta: d. Constitucional

Explicación: La macrocefalia constitucional es, por lejos, la causa más frecuente de macrocefalia. De base, suele tener una macroencefalia (cerebro grande). Generalmente es genética, por lo que sus padres también suelen ser macrocefálicos, por tanto, si los padres son macrocefálicos y sanos y el niño es macrocefálico y aparentemente sano, no es necesario realizar ningún examen, sino simplemente educar. Un porcentaje bajo, se asocia a trastornos del espectro autista, pero, no es un dato relevante, ya que el TEA se diagnostica en base a una serie de otros criterios clínicos y no con el perímetro cefálico, por lo que tampoco se debe asustar a los padres con este dato.

La macrocefalia constitucional suele tener antecedentes familiares y ser causada por una macroencefalia. Suelen tener cabeza en percentil alto desde las ecografías antenatales. Se observa y se caracteriza por no tener otras alteraciones.

Fuente: Neurología pediátrica P11 · Neuropsiquiatría pediátrica P12

11. Una niña de 5 años es traída por su madre, ya que presenta cefalea, fiebre hasta 38,5°C y vómitos. Al examen físico destaca rigidez de nuca esbozada, sin otros hallazgos de importancia. Se solicita punción lumbar que da salida a líquido claro, con 100 células, con 85% mononuclear y 15% polimorfonuclear, la glucosa del LCR es normal y las proteínas están levemente aumentadas. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar paracetamol oral
b. Iniciar cefadroxilo oral y analgésicos orales
c. Iniciar ceftriaxona endovenosa, asociada a dexamentasona endovenosa
d. Iniciar vancomicina endovenosa, sin necesidad de corticoides
e. Iniciar corticoides orales

Respuesta correcta: a. Iniciar paracetamol oral

Explicación: Tiene una meningitis viral clásica, con pleocitosis mononuclear y glosa baja en LCR. No suele ser grave y se trata con analgésicos. Es la causa más frecuente de meningitis y suele ser causada por enterovirus y, en segundo lugar, por virus respiratorios. La meningitis herpética es mucho más grave y se caracteriza por una clínica grave (convulsiones, desorientación), una imagen con lesiones en los lóbulos temporales o un líquido hemorrágico (xantocromía o eritrocitos crenados); la sola sospecha de meningitis herpética obliga a dar aciclovir endovenoso; se diagnostica con PCR para VHS.

Nota del editor: La explicación original dice glucosa baja en LCR, pero la meningitis viral tiene glucosa normal (así lo dice también el enunciado). Es un error de tipeo del original.

Fuente: Neurología pediátrica P12

12. Un niño de 8 años, con antecedentes de epilepsia tónicoclónica, en tratamiento con ácido valproico, es traído al servicio de urgencia, donde usted trabaja, ya que se encuentra convulsionando hace 10 minutos. El fármaco de elección para controlar la crisis convulsiva es:

a. Lorazepam intravenoso
b. Fenitoína por sonda nasogástrica
c. Fenobarbital intramuscular
d. Flumazenil intravenoso
e. Diazepam intramuscular

Respuesta correcta: a. Lorazepam intravenoso

Explicación: Las crisis convulsivas en pediatría se tratan con Lorazepam endovenoso (0,05 a 0,1 mg/Kg ev). Si no está disponible, se puede usar diazepam, pero suele tener sedación más prolongada. La excepción son los recién nacidos, ya que las convulsiones neonatales se tratan con barbitúricos (fenobarnital).

Fuente: Neurología pediátrica P13

13. Un niño sufre un accidente en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente en buenas condiciones generales, sin embargo 40 minutos después inicia cefalea importante y luego compromiso de conciencia. Convulsiona en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

a. Concusión
b. Hematoma subdural
c. Hemorragia subaracnoidea
d. Hematoma epidural
e. Fractura de base de cráneo

Respuesta correcta: d. Hematoma epidural

Explicación: La evidencia actual ha demostrado que es imposible diferenciar las distintas complicaciones del TEC severo con la sola clínica, por lo que es fundamental solicitar una TAC sin contraste de urgencia. Sin embargo, clásicamente se enseña que el hematoma extradural o epidural tiene un intervalo lúcido breve y es más frecuente en jóvenes, mientras que el hematoma subdural tiene un intervalo lúcido más largo y es más frecuente en adultos mayores.

Fuente: Neurología pediátrica P14

14. Un niño de 18 meses aún no camina, y presenta también retraso de otras habilidades motoras, sin embargo dice varias palabras y parece comprender lo que su madre le dice. No ha presentado empeoramiento de su condición ni ha perdido los hitos del desarrollo motor que ha ido logrando. Al examen físico destaca espasticidad de ambas extremidades inferiores, mayor a derecha, sin otros hallazgos de importancia. El diagnóstico más probable es:

a. Tumor cerebral
b. Poliomielitis por vacuna
c. Parálisis cerebral
d. Distrofia muscular de Duchenne
e. Polineuropatía metabólica

Respuesta correcta: c. Parálisis cerebral

Explicación: Es una parálisis cerebral clásica, con afectación únicamente motora, en este cado. La mayoría suele tener inteligencia y lenguaje normal (un 20% sí puede tener afectación cognitiva). La espasticidad o hipertonía suele verse en un 70% de los casos. Pero, también hay casos con hipotonía.

Tiene una parálisis cerebral clásica: retraso en el desarrollo psicomotor, con mayor afectación motora y sin pérdida de los hitos ganados. El 80% son de tipo espáticas. El tumor cerebral tendría signos focales progresivos, más hipertensión endocraneana (cefalea matinal, vómitos y edema de papila). La poliomielitis por vacuna es rarísima (e imposible con la nueva vacuna parenteral) y se presenta como un cuadro viral (fiebre, mialgias), con parálisis flácida y dolor cervical o dorsal (mielitis). La distrofia muscular afecta a niños (mujeres pueden ser portadoras, con un cuadro mucho más leve) y tiene debilidad progresiva, de predominio proximal, más signos de hipertrofia muscular. La polineuropatía tiene debilidad de predominio distal, más síntomas sensitivos distales (hipoestesia, disestesias, dolor neuropático).

Fuente: Neurología pediátrica P15 · Cuestionario 3.1 P11

15. ¿Cuál de las siguientes opciones es una indicación para realizar una punción lumbar en un paciente que presentó una convulsión febril?

a. Temperatura mayor a 40°C
b. Causa de la fiebre identificable
c. Crisis convulsiva generalizada
d. Aspecto tóxico
e. La punción lumbar debe realizarse en todo paciente que presenta una convulsión febril

Respuesta correcta: d. Aspecto tóxico

Explicación: El aspecto séptico y los signos meníngeos obligan a sospechar una meningitis bacteriana, en lugar de una simple convulsión febril benigna.

Fuente: Neurología pediátrica P17

16. Un recién nacido de término, de 2 días de vida, con antecedente de sufrimiento fetal agudo durante el parto, presenta una crisis convulsiva. Al examen físico se aprecia levemente hipotónico, sin signos focales, sin otros hallazgos de importancia. El diagnóstico más probable es:

a. Poliglobulia neonatal
b. Encefalopatía hipóxico isquémica
c. Hipoglicemia
d. Hemorragia periventricular
e. TORCH

Respuesta correcta: b. Encefalopatía hipóxico isquémica

Explicación: La encefalopatía hipóxico isquémica es la causa más frecuente de hipotonía neonatal. El sufrimiento fetal la sugiere. El pronóstico dependerá de la evolución clínica que tenga en los próximos meses. La ecografía cerebral y otras neuroimágenes pueden aportar algo de información. Las convulsiones neonatales se tratarán con fenobarbital.

Fuente: Neurología pediátrica P18

17. Un niño de 6 años, con diagnóstico de meningitis bacteriana aguda, presenta una tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo que identifica cocáceas Gram positivos aisladas y en diplos. El agente etiológico más probable es:

a. Neisseria meningitidis
b. Streptococcus pyogenes
c. Haemophilus influenzae
d. Listeria monocytogenes
e. Streptococcus pneumoniae

Respuesta correcta: e. Streptococcus pneumoniae

Explicación: Neisseria meningitidis: diplococo Gram(-); Streptococcus pyogenes: Cocáceas Gram(+) en cadenas largas (raro que produzca MBA); Haemophilus influenzae: Cocobacilo Gram(-); Listeria monocytogenes: Bacilo Gram (+); Streptococcus pneumoniae: Cocáceas Gram(+) en diplos, cadenas cortas o aisladas.

Fuente: Neurología pediátrica P19

18. Un joven de 14 años, previamente sano, presenta en la primera hora de la mañana bruscas sacudidas bilaterales desde hace seis meses, ocasionales, más frecuentes luego de estudiar hasta tarde la noche previa. Su hermano de 12 años también ha tenido saltitos al despertar. Ahora consulta por un episodio único de brusca pérdida del conocimiento, seguida de convulsión tónico clónica recuperada en 15 a 20 minutos. El diagnóstico más probable es:

a. Epilepsia mioclónica
b. Epilepsia parcial motora
c. Crisis convulsiva única
d. Epilepsia parcial benigna
e. Epilepsia focal, secundaria

Respuesta correcta: a. Epilepsia mioclónica

Explicación: Es una epilepsia mioclónica clásica: mioclonías (en particular las del sueño), más crisis tónico-clónicas. Se trata con ácido valproico por sobre otros anticonvulsivantes. No está de más recordar la importancia del a diferenciación entre epilepsias primarias y focales: - Primarias: se estudian con EEG y se tratan solo con algunos anticonvulsivantes, que son de amplio espectro: ej. ácido valproico, topiramato, lamotrigina (la lamotrigina empeora la epilepsia mioclónica).- Secundarias: Se estudian con RMN y se tratan con la mayoría de los anticonvulsivantes, aunque se suelen usar los de espectro acotado, en especial, fenitoína y carbamazepina. Sin embargo, sirven también los demás y la elección final del anticonvulsivante depende de cada paciente.
Tiene una epilepsia mioclónica clásica: mioclonías generalizadas (saltitos), más crisis tónico-clónicas más infrecuentes. Si bien solo ha tenido una crisis convulsiva propiamente tal, las mioclonías hacen que lo más probable es que sea la epilepsia mioclónica. También apuntan a este diagnóstico los antecedentes familiares, ya que las epilepsias primarias tienen un componente genético importante. Se trata con ácido valproico. El EEG puede aportar información valiosa para la confirmación diagnóstica.

Fuente: Neurología pediátrica P20 · Cuestionario 3.1 P6

19. Un niño de 6 años presenta episodio de inicio súbito de compromiso de conciencia, asociado a contracción en flexión de las extremidades superiores y en extensión de las extremidades inferiores, seguido de movimientos repetitivos de todas las extremidades, de cerca de 3 minutos de duración. Al examen físico está en buenas condiciones, sin signos focales y no recuerda lo sucedido. El diagnóstico más probable es:

a. Tumor cerebral
b. Epilepsia primaria
c. Epilepsia focal
d. Esclerosis múltiple
e. Convulsión inocente

Respuesta correcta: b. Epilepsia primaria

Explicación: Por ahora tiene una primoconvulsión o primera convulsión, pero dado que no hay otra causa que lo explique, lo más probable es que sea una epilepsia tónico-clónica. Se debe estudiar con exámenes de sangre y luego con un EEG como primer examen. La RMN también se pedirá, aunque no de urgencia (sí es de urgencia si tiene crisis focales, signos focales o compromiso de conciencia persistente).

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P4

20. En un lactante con un síndrome hipotónico, ¿qué alteración sería MENOS probable de encontrar en una causa de tipo neuromuscular?

a. Facies alargada y labio superior en forma de “V” invertida
b. Debilidad de predominio proximal
c. Alteraciones ortopédicas asociadas (pie bot, artrogriposis, displasia de cadera)
d. Reflejos arcaicos exagerados
e. Retraso en alcanzar los hitos del desarrollo psicomotor

Respuesta correcta: d. Reflejos arcaicos exagerados

Explicación: El síndrome hipotónico de tipo neuromuscular, suelen tener disminución de los reflejos, incluyendo los reflejos arcaicos. Las de origen central, en cambio, pueden tener aumento de ellos.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P5

21. Un lactante de 4 meses consulta por fiebre de 39°C hace 1 día, sin otros síntomas de importancia. Al examen no se encuentran signos de localización. Entre los exámenes que se realizan para aclarar la causa de la fiebre está una PL, cuyo examen citoquímico muestra: Albúmina 0.8 gr/00; Glucosa 30 mg% con Glicemia de 90 mg%; Recuento celular 250 cel/mm3; Recuento diferencial: PMN 70%, MN 30%; Tinción de Gram: sin gérmenes. El diagnóstico MÁS probable es (pregunta MIR):

a. Meningoencefalitis aséptica.
b. Meningitis Bacteriana aguda.
c. LCR de características normales.
d. Meningoencefalitis herpética.
e. Meningoencefalitis por enterovirus.

Respuesta correcta: b. Meningitis Bacteriana aguda.

Explicación: El LCR no es el más clásico de la meningitis bacteriana (porque tiene pocas células y proteínas). Sin embargo, por tener glucosa baja y predominio polimorfonuclear, es probablemente bacteriana.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P6

22. Un niño de 3 años presenta cuadro de odinofagia, fiebre alta y tos irritativa escasa. Presenta convulsión tónico clónica en una oportunidad, de 2 minutos de duración. No ha presentado otras convulsiones. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni signos meníngeos. La faringe se observa eritematosa, sin exudado. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar, iniciar antibióticos y realizar punción lumbar
b. Enviar a domicilio, indicando paracetamol durante los cuadros febriles, sin necesidad de anticonvulsivantes
c. Iniciar ácido valproico y solicitar resonancia magnética nuclear
d. Enviar a domicilio, indicando antipiréticos y diazepam durante las alzas térmicas
e. Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según hallazgos

Respuesta correcta: b. Enviar a domicilio, indicando paracetamol durante los cuadros febriles, sin necesidad de anticonvulsivantes

Explicación: Tiene una convulsión febril benigna (sin signos de alarma). Se trata con paracetamol, en caso de fiebre, más control en caso de aparición de signos de alarma.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P7

23. Un niño de 5 años presenta una convulsión tónico-clónica, en 2 oportunidades distintas, separadas por una semana. Ambas duraron cerca de 5 minutos, cedieron espontáneamente y se relacionaron con haber dormido poco. Su examen físico, así como sus exámenes generales (hemograma, pruebas hepáticas, función renal, perfil bioquímico, PCR) son normales. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

a. TAC de cerebro
b. RMN de cerebro
c. Electroencefalograma
d. Punción lumbar
e. Prueba de respuesta a flumazenil

Respuesta correcta: c. Electroencefalograma

Explicación: Tiene una primoconvulsión: se estudia con EEG tan pronto como sea posible, ya que la sensibilidad es mayor en las primeras horas después de la crisis (recordar que la epilepsia se diagnostica con dos crisis o con una crisis más un EEG alterado. Actualmente también se solicita una neuroimagen pero no urgente. En las crisis focales, en cambio, la neuroimagen es el examen más urgente, aunque actualmente igual se pide el EEG.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P9

24. ¿Cuál es el síntoma que más frecuentemente acompaña a los niños con microcefalia?

a. Retraso mental
b. Convulsiones
c. Hipotonía
d. Craneosinostosis
e. Cefalea

Respuesta correcta: a. Retraso mental

Explicación: Puede tener todas las demás cosas, pero la discapacidad cognitiva es el síntoma más constante. En resumen: las macrocefalias suelen ser constitucionales. En cambio, las microcefalias suelen asociarse a disfunción cognitiva. Eso sí, recordar que se definen como menor a -3DS las microcefalias y mayor a +3DS las macrocefalias.

Nota del editor: El punto de corte habitual de microcefalia es perímetro craneano bajo 2 DS (bajo 3 DS se considera severa). El dato de 3 DS del original es discutible.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P17

25. Respecto a la parálisis cerebral es verdadero que:

a. La mayoría de las veces se debe a causas perinatales
b. La mayoría de las veces se asocia a retraso mental
c. La mayoría de las veces el compromiso es mayormente sensitivo
d. La mayoría de las veces se aprecia hipotonía generalizada
e. La mayoría de las veces es diagnóstico se realiza mediante una ecografía cerebral

Respuesta correcta: a. La mayoría de las veces se debe a causas perinatales

Explicación: El diagnóstico es clínico, suelen deberse a accidentes de placenta y cordón y asfixia perinatal, las alteraciones motoras suelen ser lo más frecuente, la inmensa mayoría tiene inteligencia normal, la mayoría tiene hipertonía.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P18

26. Un lactante de 2 años es traído por su madre por haber presentado hace una hora una convulsión tónico-clónica generalizada de un minuto de duración. Se encuentra febril, hasta 39°C, pálido, somnoliento y poco reactivo. El resto del examen físico es normal. La conducta inmediata debe ser:

a. Indicar antipiréticos
b. Iniciar anticonvulsivantes
c. Descartar meningitis, con una punción lumbar
d. Solicitar exámenes generales y parámetros inflamatorios
e. Solicitar RMN de cerebro

Respuesta correcta: c. Descartar meningitis, con una punción lumbar

Explicación: Por estar séptico, lo primero es descartar meningitis. Si hubiese estado bien, solo se indicarían los antipiréticos.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P21

27. Un niño de 7 años es traído por cefalea y fiebre de 1 día de evolución. Al examen físico destacan rigidez de nuca esbozada, por lo que se decide realizar punción lumbar, que da salida a un líquido claro, con 98 células por mm3, con 90% de mononucleares, proteínas de 60 mg/dl y glucosa normal. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar antibióticos endovenosos
b. Iniciar corticoides endovenosos
c. Iniciar antituberculosos orales
d. Iniciar paracetamol oral
e. Iniciar Aciclovir endovenoso

Respuesta correcta: d. Iniciar paracetamol oral

Explicación: Tiene una meningitis viral, por enterovirus, debido al líquido característicos: pleocitosis mononuclear con glucosa normal.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P22

28. El primer fármaco que debe administrarse a un paciente es estatus epiléptico es:

a. Fenitoína
b. Ácido valproico
c. Lorazepam
d. Fenobarbital
e. Propofol

Respuesta correcta: c. Lorazepam

Explicación: El primer fármacos suele ser el lorazepam (aceptable el midazolam). En paralelo se carga con anticonvulsivantes de larga acción (fenitoína, ácido valproico o levetiracetam). Si no responde, se agregan barbitúricos (pentobarbital o propofol).

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P23

29. Un niño de 6 meses de edad presenta un síndrome hipertónico espástico que afecta las 4 extremidades. Al examen físico se aprecia que no ha alcanzado los hitos del desarrollo motor que debería tener a su edad, sin embargo no ha perdido ninguno de los hitos que sí ha logrado previamente. El diagnóstico más probable es:

a. Tumor cerebral
b. Parálisis cerebral
c. Trastorno del espectro autista
d. Síndrome de West
e. Agenesia cerebelosa

Respuesta correcta: b. Parálisis cerebral

Explicación: Es una parálisis cerebral espástica clásica.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P24

30. Un paciente de 8 años presenta cefalea recurrente fronto-parietal, intensa, que se presenta más frecuentemente en los períodos de sobrecarga escolar y al dormir poco, que se agrava con los sonidos y con la luz y que cede al dormir. El examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

a. Neuralgia del trigémino
b. Cefalea cluster
c. Cefalea tensional
d. Jaqueca
e. Tumor cerebral

Respuesta correcta: d. Jaqueca

Explicación: La jaqueca en niños es infrecuente, pero tiene la misma clínica que en adultos.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P25

31. Un niño sufre una caída de altura, con un golpe en la cabeza. Al examen físico se aprecia salida continua de líquido claro por la fosa nasal derecha. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de cerebro y derivar a otorrinolaringología, por probable fractura facial con compromiso del conducto nasolacrimal
b. Hospitalizar, solicitar TAC de cerebro, administrar antibióticos endovenosos y solicitar evaluación por el neurocirujano
c. Solicitar radiografía de cráneo y mantener en observación por 4 horas
d. Solicitar TAC de cerebro y mantener en observación por 24 horas
e. Enviar a domicilio con reposo relativo, indicando reconsulta en caso de aparición de signos de alarma

Respuesta correcta: b. Hospitalizar, solicitar TAC de cerebro, administrar antibióticos endovenosos y solicitar evaluación por el neurocirujano

Explicación: Tiene un TEC severo, con fractura de la base de cráneo, al nivel del etmoides, con la consecuente fístula de líquido cefalorraquídeo.

Fuente: Traumatología pediátrica P3

32. ¿Qué antecedente representa la MENOR gravedad en contexto de un niño que se golpeó la cabeza contra el suelo?

a. Equimosis retroauricular
b. Equimosis periocular
c. Cefalea intensa y progresiva
d. Compromiso de conciencia durante 30 segundos, inmediatamente después del golpe
e. Vómitos explosivos y frecuentes

Respuesta correcta: d. Compromiso de conciencia durante 30 segundos, inmediatamente después del golpe

Explicación: El TEC simple puede venir con una concusión cerebral, que incluye compromiso de conciencia transitorio (generalmente segundos y nunca más de 15 minutos), amnesia breve, pero que luego no presenta alteraciones. Las demás alteraciones que se describen son propias del TEC severo.

Fuente: Traumatología pediátrica P7

33. Un niño de 7 años se cae en el colegio, golpeándose la cabeza. No recuerda cómo se cayó, pero posteriormente recuerda bien. No perdió la conciencia en ningún momento. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni otros hallazgos patológicos. La conducta más adecuada es:

a. Remitir a su domicilio con observación cuidadosa y con indicación de control en caso de aparición de signos de alarma
b. Solicitar radiografía de cráneo y decidir manejo según hallazgos
c. Solicitar TAC de cerebro sin contraste, inmediatamente y decidir manejo según hallazgos
d. Administrar analgésicos y anticonvulsivantes y solicitar TAC de cerebro con contraste
e. Derivar para manejo ambulatorio por un neurólogo

Respuesta correcta: a. Remitir a su domicilio con observación cuidadosa y con indicación de control en caso de aparición de signos de alarma

Explicación: Tiene un TEC simple, sin signos de alarma.

Fuente: Traumatología pediátrica P20

34. Un niño de 4 años se golpea la cabeza al caer de una bicicleta. Inicialmente está bien, pero a luego de algunos minutos evoluciona con cefalea progresiva e intensa, asociada a vómitos en varias oportunidades. El examen neurológico no muestra signos focales. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio con analgésicos e indicaciones de control en caso de aparición de signos de alarma
b. Administrar antieméticos y AINEs endovenosos y reevaluar en 1 hora
c. Solicitar radiografía de cráneo
d. Solicitar TAC de cerebro y cráneo
e. Realizar punción lumbar

Respuesta correcta: d. Solicitar TAC de cerebro y cráneo

Explicación: Tanto la cefalea progresiva como los vómitos reiterados (>2 veces) son signos de alarma, que obligan a realizar una TAC.

Fuente: Traumatología pediátrica P28

Psiquiatría infantil y maltrato (16)

1. Un niño de 4 años, no habla y presentó retraso en alcanzar los hitos del desarrollo motor. La madre refiere que presenta poco interés en interactuar con ella o con otros niños y que aprendió a caminar a los 20 meses de edad. El diagnóstico más probable es:

a. Depresión infantil
b. Trastorno del espectro autista
c. Trastorno oposicionista desafiante
d. Síndrome de déficit atencional
e. Parálisis cerebral

Respuesta correcta: b. Trastorno del espectro autista

Explicación: El retraso en el lenguaje y la falta de interacción apunta fuertemente al diagnóstico de TEA. Sin embargo, algunos casos más severos también pueden tener afectaciones motoras o del resto del desarrollo, a pesar de que la mayoría no los tiene, sino solo alteraciones en las habilidades sociales, de lenguaje, rigidez cognitiva e intereses restringidos.

Fuente: Crecimiento y nutrición pediátricas P18

2. Un niño de 9 años miente y roba a sus padres con frecuencia, se mete en peleas seguido, es cruel con los animales y presenta una actitud irrespetuosa e indiferente hacia sus padres y profesores. El diagnóstico más probable es:

a. Depresión infantil
b. Trastorno por ansiedad de separación
c. Trastorno de conducta
d. Trastorno oposicionista desafiante
e. Síndrome de Asperger

Respuesta correcta: c. Trastorno de conducta

Explicación: Tiene un trastorno de conducta disocial clásico: niño con comportamiento claramente reñido con las normas y el bien (se está transformando en antisocial). La depresión suele venir con tristeza, pero también puede tener alteraciones conductuales, como irritabilidad, que aparecen en poco tiempo, en un niño que antes era normal y feliz y que está pasando por un problema, en particular disfunción familiar. La ansiedad de separación se caracteriza por llanto y angustia al separarse de los padres (ej. ir al colegio). El trastorno oposicionista desafiante se caracteriza por rabietas, irrespetuosidad y agresividad con la autoridad, pero sigue siendo un buen niño (aunque difícil). El síndrome de Asperger actualmente se llama trastorno del espectro autista, en su variante menos grave, ya que logra lenguaje, pero tiene dificultades en las interacciones sociales, suelen ser muy concretos.

Es un trastorno de conducta clásico.

Fuente: Cuestionario 3.1 P13 · Neuropsiquiatría pediátrica P3

3. Un niño de 6 años es traído por su madre, ya que ha presentado un mal rendimiento escolar. Los profesores dicen que es difícil de manejar, ya que se distrae fácilmente y le cuesta quedarse quieto. Tiene

buena relación con sus compañeros, aunque en algunas ocasiones pelea con ellos. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Autismo
b. Déficit atencional
c. Trastorno oposicionista desafiante
d. Depresión infantil
e. Síndrome de Asperger

Respuesta correcta: b. Déficit atencional

Explicación: Si bien muchas condiciones y trastornos se pueden presentar de esa forma, lo más probable es que sea un TDAH (trastorno de déficit atencional e hiperactividad). Que se lleve bien con sus compañeros hace menos probable un trastorno del espectro autista. Sin embargo, el TDAH sí puede tener problemas con sus pares, al no poder autorregularse.

Fuente: Neurología pediátrica P16

4. ¿Qué fármacos son útiles en el tratamiento del síndrome por déficit atencional del niño?

a. Derivados anfetamínicos
b. Opiáceos
c. Antipsicóticos típicos
d. Antipsicóticos atípicos
e. Antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina

Respuesta correcta: a. Derivados anfetamínicos

Explicación: Se puede usar el metilfenidato y la D-anfetamina, entre otros.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P1

5. Una paciente de 14 años presenta baja de peso, diarrea y amenorrea desde hace algunos meses. Es muy delgada, pesando 40 kilogramos, sin embargo ella se considera obesa y por eso come muy poco y vomita después de ser obligada a comer. La madre la sorprendió usando lactulosa y sibutramina. El diagnóstico más probable es:

a. Anorexia nervosa
b. Enfermedad celíaca
c. Esquizofrenia
d. Trastorno obsesivo compulsivo
e. Bulimia

Respuesta correcta: a. Anorexia nervosa

Explicación: Es una anorexia nervosa clásica, a pesar de la purga. No tiene atracones, que es lo característico de la bulimia (aunque también se puede ver en la anorexia, con la diferencia que esta última tiene muchos menos atracones y tiene desnutricióin).

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P2

6. Un niño de 5 años hace berrinches cada vez que lo llevan al jardín infantil. Una vez que es obligado a ir, llora por largo rato y es difícil de consolar, hasta que finalmente se calma y juega con sus compañeros. La madre refiere que le preocupa que el niño pueda ser víctima de maltrato por parte de sus compañeros o profesores y que esto sea la causa de su comportamiento. Al examen físico no se encuentra ningún tipo de lesión ni otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno por ansiedad de separación
b. Trastorno oposicionista desafiante
c. Trastorno de conducta
d. Trastorno depresivo
e. Trastorno por déficit atencional

Respuesta correcta: a. Trastorno por ansiedad de separación

Explicación: Es un trastorno por ansiedad de separación clásico.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P10

7. ¿A qué edad se detecta con mayor frecuencia el déficit atencional del niño?

a. En el lactante menor
b. En el lactante mayor
c. En el prescolar
d. En el escolar
e. En el adolescente

Respuesta correcta: d. En el escolar

Explicación: Si bien los síntomas están presentes desde antes, el mal rendimiento escolar es lo que lleva al diagnóstico en la mayoría de los casos. Actualmente, algunos colegios y jardines infantiles cuentan con programas de detección más precoz de condiciones neurodiversas, que permiten un mejor manejo del niño.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P13

8. Un niño de 5 años es diagnosticado de trastorno oposicionista desafiante. ¿Qué situación NO le parece acorde con este diagnóstico?

a. Rabietas cuando no se hace lo que quiere
b. Culpa a otros de sus errores y mala conducta
c. Inteligencia normal
d. Desinterés en relacionarse con otros niños
e. Actitud irreverente al recibir una orden

Respuesta correcta: d. Desinterés en relacionarse con otros niños

Explicación: El desinterés es clásico de los TEA (trastornos del espectro autista) y no del TOD.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P14

9. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MÁS FRECUENTE en los pacientes con bulimia y la define?

a. Baja de peso
b. Trastorno de personalidad asociado
c. Atracones
d. Autoinducción del vómito
e. Sobrepeso

Respuesta correcta: c. Atracones

Explicación: Atracones y purga son lo más importante en la bulimia, pero los atracones la definen. Se asocia a TP limítrofe. El tratamiento incluye dieta, psicoterapia y antidepresivos IRS.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P15

10. Usted recibe a un de 3 años por haber caído de la cama, resultando con un golpe en la cabeza y fractura de un dedo. Al examen físico está en buenas condiciones generales, en Glasgow 15 y presenta múltiples hematomas, en distintas etapas de evolución. La conducta más adecuada es:

a. Realizar tratamiento ortopédico de la fractura y enviar a domicilio, indicando control con un neurólogo
b. Realizar tratamiento ortopédico de la fractura y enviar a domicilio, indicando control con un psiquiatra
c. Realizar tratamiento ortopédico de la fractura y solicitar pruebas de coagulación y hemograma
d. Indicar hospitalización y solicitar radiografías de otras partes del cuerpo y fondo de ojo
e. Solicitar TAC de cerebro de urgencia

Respuesta correcta: d. Indicar hospitalización y solicitar radiografías de otras partes del cuerpo y fondo de ojo

Explicación: Se sospecha un maltrato infantil. El fondo de ojo buca hemorragias retinales en el síndrome del niño sacudido.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P16

11. Una madre trae a su hijo de 6 años, porque ha bajado considerablemente su rendimiento escolar y se encuentra irritable y en algunas ocasiones, agresivo. Comparte menos con sus amigos del colegio. Ella refiere tener problemas con su marido y que actualmente están durmiendo en camas separadas. El diagnóstico que debe sospecharse es:

a. Trastorno del desarrollo
b. Trastorno por ansiedad de separación
c. Depresión
d. Maltrato infantil
e. Trastorno de conducta

Respuesta correcta: c. Depresión

Explicación: Es una depresión clásica, causada por disfunción familiar.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P19

12. El tratamiento del trastorno oposicionista desafiante es:

a. Antidepresivos
b. Metilfenidato
c. Benzodiacepinas
d. Psicoterapia al niño
e. Educación a los padres de técnicas de disciplina y respeto mutuo

Respuesta correcta: e. Educación a los padres de técnicas de disciplina y respeto mutuo

Explicación: La psicoterapia familiar es lo más importante. Es especialmente importante trazar límites, pero con infinito amor y paciencia. También se debe trabajar con el niño en desarrollo de diversas habilidades, en su autoestima y en su forma de relacionarse con los demás.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P26

13. Un niño de 5 años presenta ánimo muy bajo, mal rendimiento escolar y problemas de autoestima, que empezaron hace algunos meses, luego de que su padre se fue de la casa. La madre se muestra preocupada y no sabe qué hacer. La conducta más adecuada es:

a. Indicar un antidepresivo ISRS e iniciar psicoterapia cognitivo conductual
b. Indicar un antidepresivo tricíclico e iniciar psicoterapia psicodinámica
c. Indicar un anticonvulsivante e iniciar psicoterapia cognitivo conductual
d. Indicar un antipsicótico e iniciar psicoterapia psicodinámica
e. Indicar psicoterapia con enfoque sistémico, orientada a mejorar la red de apoyo, sin necesidad de fármacos

Respuesta correcta: e. Indicar psicoterapia con enfoque sistémico, orientada a mejorar la red de apoyo, sin necesidad de fármacos

Explicación: Tiene una depresión infantil. Si bien los antidepresivo IRS pueden ayudar, de primera línea se prefiere la psicoterapia con enfoque sistémico o familiar, siendo, por lejos, lo más importante.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P27

14. Usted evalúa a una niña de 15 años, con antecedente de abuso sexual en la infancia, que actualmente cursa con una depresión. ¿Debe preguntársele sobre la ideación suicida?

a. No, en ningún caso, ya preguntarlo aumenta el riesgo de que lo cometa
b. Sólo en los casos que han tenido intentos previos
c. Sólo si la depresión es severa
d. Sólo si la depresión es leve y con bajo riesgo de suicidio
e. Sí, en todos los casos

Respuesta correcta: e. Sí, en todos los casos

Explicación: Siempre se debe evaluar en todo paciente deprimido.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P28

15. Un niño de 6 años no habla y demoró más de lo normal en empezar a caminar. La madre refiere que no contesta al hablarle ni tampoco responde al indicarle cosas. Juega con siempre con el mismo juguete, sin

interactuar con otros niños y tiende a realizar movimientos extraños con las manos varias veces al día. Al examen físico no presenta signos neurológicos focales. El diagnóstico más probable es:

a. Epilepsia
b. Síndrome de Asperger
c. Trastorno del espectro autista
d. Trastorno de conducta
e. Parálisis cerebral

Respuesta correcta: c. Trastorno del espectro autista

Explicación: Los movimientos extraños se llaman manierismos o estereotipias. El síndrome de Asperger es una variante del TEA, pero, se caracteriza por un desarrollo del lenguaje adecuado, aunque, en estricto rigor, no es necesariamente normal, ya que puede ser un lenguaje pedante, algo excéntrico, con escaso lenguaje no verbal o contacto visual, volumen de la voz inadecuado y centrado en intereses restringidos.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P29

16. ¿Cuál de las siguientes lesiones son más características de maltrato infantil?

a. Fractura de antebrazo en tallo verde y fractura subcapital de húmero
b. Hematoma de la zona frontal y fractura nasal
c. Fractura suprancondílea de húmero y de antebrazo
d. Fractura de metatarsiano y calcáneo
e. Fractura de escápula y fracturas costales posteriores

Respuesta correcta: e. Fractura de escápula y fracturas costales posteriores

Explicación: Si bien las fracturas de huesos largos son las más frecuentes, las fracturas de la espalda son muy sugerentes (escápula y zona posterior de costillas).

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P30

Traumatología y ortopedia (28)

1. Un lactante de 13 meses inicia fiebre y decaimiento. La madre refiere que dejó de caminar hace 24 horas. Al examen físico se observa decaído, febril hasta 39,7°C, con presión arterial normal y leve taquicardia. Presenta dolor a la movilización de la cadera izquierda. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio con cefadroxilo oral y antipiréticos
b. Iniciar antipiréticos, solicitar hemograma y radiografías de cadera izquierda y decidir manejo según hallazgos
c. Solicitar hemograma, PCR y hemocultivos y realizar punción articular bajo ecografía
d. Hospitalizar, solicitar hemograma y hemocultivos e iniciar vancomicina endovenosa
e. Solicitar RMN de cadera e iniciar cloxacilina endovenosa

Respuesta correcta: c. Solicitar hemograma, PCR y hemocultivos y realizar punción articular bajo ecografía

Explicación: La sospecha clínica es una artritis séptica. El tratamiento es con drenaje quirúrgico y antibióticos endovenosos. Actualmente se recomienda comenzar con cobertura para SAMR, usando vancomicina, hasta tener los resultados del antibiograma.

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P17

2. Un niño de 3 años presenta cojera de 2 días de evolución. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, afebril, con signos vitales normales. Presenta dolor a la abducción y rotación externa de la cadera derecha, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a. Sinovitis transitoria de la cadera
b. Artritis séptica
c. Displasia de cadera
d. Enfermedad de Osgood.Schlatter
e. Epifisiolisis de la cabeza femoral

Respuesta correcta: a. Sinovitis transitoria de la cadera

Explicación: La sinovitis transitoria es la causa más frecuente de claudicación en la infancia. La edad clásica es en mayores de un año, hasta los 10 años, siendo 2 a 5 años el rango más frecuente. Suele presentarse en relación a traumatismos o algunos días después de infecciones virales. Suele durar unos pocos días, lo que la diferencia de otras causas de cojera. No suele tener fiebre, aunque puede tener fiebre leve (eso sí, la fiebre obliga a descartar artritis séptica).

Fuente: Reumatología e Inmunología pediátrica P20

3. Un niño de 10 años presenta fiebre, malestar general y dolor al pisar, en relación al extremo proximal de la tibia izquierda. Al examen físico sólo se aprecia dolor a la palpación de la metáfisis de la tibia izquierda. ¿Qué examen tiene mejor sensibilidad ante la sospecha diagnóstica?:

a. Radiografía
b. Ecografía
c. TAC
d. RMN
e. Seguimiento clínico

Respuesta correcta: d. RMN

Explicación: La sospecha diagnóstica es una osteomielitis, que se estudia con radiografía como examen inicial, pero, es la RMN el examen con mayor sensibilidad y especificidad.

Fuente: Traumatología pediátrica P1

4. Un paciente de 5 años consulta en el hospital de Futaleufú (zona rural), donde usted es el médico de turno. Sufrió una caída a caballo hace 60 minutos, resultando con una fractura expuesta de la pierna derecha. No presenta sangramiento importante y sus signos vitales son normales. El hospital cuenta con un pabellón básico y la ambulancia demorará 2 hora en llevarlo a un centro de mayor complejidad. ¿Cuál de las siguientes medidas es MENOS adecuada para el manejo de este paciente?

a. Derivación inmediata a un centro de mayor complejidad, en caso de que esté disponible
b. Aseo con abundante suero fisiológico
c. Antibióticos endovenosos de amplio espectro
d. Cobertura de la herida con apósitos estériles e inmovilización transitoria
e. AINES endovenosos

Respuesta correcta: a. Derivación inmediata a un centro de mayor complejidad, en caso de que esté disponible

Explicación: La redacción puede incitar a la confusión, pero, se trata de una fractura expuesta, que es una urgencia no derivable, debiendo hacerse el manejo inicial en el lugar de atención (ABC, aseo con suero fisiológico, analgésicos y antibióticos: cefazolina es el esquema basal, pero se agregan otros medicamentos en las grado III y situaciones epecíficas). Por tanto, no se debe derivar de inmediato, sino después de haber dado el manejo inicial.

Fuente: Traumatología pediátrica P2

5. ¿Qué tratamiento está indicado en un niño que presenta una artritis séptica de la rodilla derecha?

a. Cefazolina intraarticular
b. Aseo articular quirúrgico + cloxacilina e.v.
c. Aseo articular quirúrgico + vancomicina y cefotaximo por vía e.v.
d. Drenaje articular por punción + cefazolina e.v.
e. Drenaje articular por punción + ceftriaxona + vancomicina e.v.

Respuesta correcta: c. Aseo articular quirúrgico + vancomicina y cefotaximo por vía e.v.

Explicación: Actualmente, se recomienda cubrir SAMR en toda patología infecciosa grave y solo bajar a cloxacilina o cefazolina, una vez que se haya completado el estudio de susceptibilidad. Esto aplica a la artritis séptica. Además, se recomienda indicar una cefalosporina de tercera generación, para cubrir otros gérmenes. Es aceptable dejar cloxacilina más cefotaximo, en los casos en que no hay signos de sepsis y, además, no hay factores de riesgo de resistencia.

Fuente: Traumatología pediátrica P4

6. Niña de 3 meses, con antecedentes de madre con displasia de cadera tratada. Al examen físico destaca limitación a la abducción de cadera derecha. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar radiografía de cadera derecha AP y axial
b. Solicitar radiografía de pelvis antero posterior
c. Indicar uso de doble pañal
d. Solicitar ecografía de cadera derecha
e. Observar y controlar en un mes

Respuesta correcta: b. Solicitar radiografía de pelvis antero posterior

Explicación: El mejor examen para diagnosticar la displasia de caderas es la ecografía de caderas, que se puede hacer desde muy temprano. Sin embargo, desde los 3-4 meses, la radiografía AP de pelvis (para comparar ambas caderas) tiene excelente rendimiento y, de hecho, es el examen de screening en Chile y otros países en desarrollo.

El screening de displasia de caderas se hace de dos formas. La óptima es hacerla en el primer de vida, con una ecografía de caderas (antes de que osifique la cabeza femoral): se indica en pacientes con factores de riesgo (como esta) o con examen físico alterado (signos de Ortolani y/o Barlow); también se usa en países con abundantes recursos como screening. Desde los 3 meses de vida, sirve la radiografía AP de pelvis, que es el screening que se hace en Chile, financiado por el Minsal.

Fuente: Traumatología pediátrica P5 · Cuestionario 3.1 P10

7. Las articulaciones más frecuentemente afectadas por la sinovitis transitoria son:

a. Rodillas
b. Caderas
c. Intervertebrales
d. Interfalángicas proximales
e. Metacarpofalángicas

Respuesta correcta: b. Caderas

Explicación: Caderas y luego rodillas son las más afectadas en la sinovitis transitoria.

Fuente: Traumatología pediátrica P6

8. El hueso que se fractura con MAYOR frecuencia en el niño durante el parto es:

a. el radio
b. la tibia
c. el cráneo
d. el fémur
e. la clavícula

Respuesta correcta: e. la clavícula

Explicación: La fractura de clavícula es frecuente en la retención de hombros y en el niño grande para la edad gestacional, en especial si es hijo de madre diabética. Suele tener buen pronóstico y curar sin secuelas, pero siempre se debe evaluar la indemnidad del plexo braquial, ya que se podría lesionar también.

Fuente: Traumatología pediátrica P8

9. El pie bot se caracteriza por:

a. Pie equino, valgo, cavo y abducido
b. Pie talo, varo y plano
c. Pie talo, valgo, plano y abducido
d. Pie equino, varo, cavo y aducto
e. Pie talo, varo, cavo

Respuesta correcta: d. Pie equino, varo, cavo y aducto

Explicación: También se llama pie zambo y se caracteriza por ser equino, varo, cavo y aducto. Se trata ortopédicamente con el método de Ponseti (yesos que se van cambiando y ayudan a “enderezar” el pie en varias semanas).

Fuente: Traumatología pediátrica P9

10. Un niño sufre un accidente de tránsito y es traído por una ambulancia, con collar cervical y tabla espinal. Al examen físico está asustado, adolorido, consciente, respira normalmente, está taquicárdico, con múltiples equimosis y signos de fracturas en la pierna derecha y el brazo izquierdo. La primera medida es:

a. Instalar vía venosa periférica
b. Administrar AINEs intramusculares
c. Solicitar radiografías de las zonas con posibles fracturas
d. Reducir manualmente las fracturas
e. Solicitar TAC de cerebro

Respuesta correcta: a. Instalar vía venosa periférica

Explicación: El ABC es la primera medida en todo paciente con traumatismo. En este caso está bien el A (vía aérea y collar cervical) y B (respiración), por lo que se debe proceder al C (circulación), consistente en parar las hemorragias y reponer fluidos.

Fuente: Traumatología pediátrica P10

11. El tratamiento inicial de la enfermedad de Osgood-Schlatter es:

a. Quirúrgico
b. Yeso pelvipedio
c. Inmovilización con bota larga cerrada
d. Inmovilización con valva de yeso abierta o bota ortopédica removible
e. Reposo relativo y AINEs

Respuesta correcta: e. Reposo relativo y AINEs

Explicación: Suele tener excelente pronóstico y ser transitorio. El reposo deportivo y los AINES son útiles para los síntomas y una recuperación más rápida.

Fuente: Traumatología pediátrica P11

12. Un niño de 3 meses, asintomático, es diagnosticado de displasia de cadera derecha, con subluxación moderada, en el examen de screening habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Observar evolución, con control radiológicos en un mes
b. Resolver quirúrgicamente
c. Indicar uso de doble pañal
d. Indicar uso de correas de Pavlik
e. Indicar yeso pelvipedio

Respuesta correcta: d. Indicar uso de correas de Pavlik

Explicación: Hasta los 10 meses de edad, de elección son las correas de Pavlik. Sobre esa edad, se decide caso a caso, siendo aceptable las correas, el yeso pelvipedio y la reducción quirúrgica abierta.

Fuente: Traumatología pediátrica P12

13. Un recién nacido es diagnosticado de pie bot clínico y radiológico. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar maniobras manuales correctivas, suaves, con yesos de bota larga y controles radiológicos frecuentes
c. Indicar bota de yeso corta
d. Indicar férula removible
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: b. Iniciar maniobras manuales correctivas, suaves, con yesos de bota larga y controles radiológicos frecuentes

Explicación: Se maneja con el método de Ponseti.

Fuente: Traumatología pediátrica P13

14. ¿Qué condición le confiere un peor pronóstico a una fractura expuesta?

a. Herida mayor a 5 cm
b. Presencia de restos vegetales
c. Mala cobertura de partes blandas
d. Conminución del foco de fractura
e. Ocurrencia en sitio agrícola

Respuesta correcta: c. Mala cobertura de partes blandas

Explicación: El peor pronóstico lo da el compromiso neurovascular (Gustilo y Anderson III c), seguido de la mala cobertura de partes blandas (Gustilo y Anderson III b).

Fuente: Traumatología pediátrica P14

15. La complicación más temida de la escoliosis es:

a. Paraplejia
b. Fracturas vertebrales
c. Neuropatía
d. Neumonía
e. Hipoventilación

Respuesta correcta: e. Hipoventilación

Explicación: Puede tener muchas complicaciones (autoestima baja, lumbago crónico, problemas neurológicos), pero la más temida, en los casos graves, es la hipoventilación pulmonar. El tratamiento puede ser 1. Observar (casos leves con desviación < 20°, 2. Corsé: Desviación >20° y 3. Cirugía: evaluarla en desviación sobre 45° - 50°. Influye el grado de desviación y el crecimiento restante (si aún queda por crecer puede progresar más, pero también puede responder mejor al corsé).

Fuente: Traumatología pediátrica P15

16. Un niño de 3 años presenta claudicación de la marcha, asociada a fiebre hasta 39,4°C. Al examen físico se aprecia decaído e irritable, con dolor a la movilización pasiva y ausencia de movilización activa de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

a. Artritis séptica
b. Sinovitis transitoria
c. Enfermedad de Perthes
d. Epifisiolisis de la cabeza femoral
e. Enfermedad de Osgood-Schaltter

Respuesta correcta: a. Artritis séptica

Explicación: La fiebre alta sugiere fuertemente una artritis séptica.

Fuente: Traumatología pediátrica P16

17. Un niño de 4 años, asintomático, es traído por su madre ya que fue diagnosticado de pie plano en su consultorio. Ella decide consultar una segunda opinión, por lo que acude a su consulta particular. Al examen se aprecia ausencia del arco plantar durante el apoyo de ambos pies, pero éste se forma al levantarlos. No se identifican otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Indicar plantillas
b. Solicitar radiografías de pies
c. Derivar a traumatología para resolución quirúrgica
d. Derivar a traumatología para corrección con órtesis
e. Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio

Respuesta correcta: e. Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio

Explicación: Es un pie plano flexible, que solo se trata si es que tiene dolor (con plantillas). En cambio, el pie plano rígido, se debe derivar.

Fuente: Traumatología pediátrica P17

18. El agente causal y la vía de llegada más frecuentes, de las osteomielitis agudas, son respectivamente:

a. Staphilococcus aureus y hematógena
b. Staphilococcus aureus y por contigüidad
c. Staphilococcus aureus e inoculación directa
d. Streptococcus pyogenes y por contigüidad
e. Streptococcus pyogenes y hematógena

Respuesta correcta: a. Staphilococcus aureus y hematógena

Explicación: .

Fuente: Traumatología pediátrica P18

19. Al servicio de urgencias es traído un niño de 4 años por dolor inguinal de 48 horas de evolución. Tres semanas antes ha presentado una infección de vías respiratorias altas tratada con antibióticos. La exploración abdominal es normal y no se palpan hernias. La cadera presenta limitación dolorosa en todos

sus movimientos, y el paciente cojea. La analítica y la radiología son normales y la ecografía indica un pequeño derrame articular de cadera probablemente seroso. El primer diagnóstico de sospecha debe ser:

a. Artritis séptica de cadera
b. Artritis reumatoide juvenil
c. Sinovitis transitoria de cadera
d. Enfermedad de Perthes
e. Osteomielitis hematógena proximal de fémur

Respuesta correcta: c. Sinovitis transitoria de cadera

Explicación: Es una sinovitis transitoria clásica. Se trata con analgésicos. Suele ser autolimitada, desapareciendo a los 7-10 días.

Fuente: Traumatología pediátrica P19

20. Un paciente de 6 años cae del tercer piso de un edificio y es traído al hospital, donde Ud. está de turno. Llega en la parte posterior de una camioneta 15 minutos después del accidente. Viene inconsciente, no responde a estímulos, sólo se palpa pulso carotídeo muy débil, frecuencia respiratoria 35 por minuto, tráquea desviada hacia la derecha. No se ausculta murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, el que se percute timpánico, además se palpan múltiples fracturas costales y enfisema subcutáneo. Está pálido y sudoroso, con abdomen distendido y tenso. Tiene una extensa herida en cráneo que sangra profusamente y una fractura expuesta en antebrazo derecho que también sangra activamente. ¿Cuál sería su primera acción sobre este paciente?

a. Comprimir heridas sangrantes mientras le colocan 2 vías venosas gruesas y le administran suero fisiológico a chorro
b. Puncionar hemitórax izquierdo para descomprimir neumotórax a tensión
c. Proceder con intubación orotraqueal
d. Colocar collar cervical
e. Poner una cánula mayo y ventilar con ambú

Respuesta correcta: b. Puncionar hemitórax izquierdo para descomprimir neumotórax a tensión

Explicación: Hay que dar todo el manejo del politraumatizado, pero, lo primero es descomprimir el neumotórax a tensión y luego seguir con el ABC. Es una pregunta antigua del EUNACOM.

Fuente: Traumatología pediátrica P21

21. Un niño sufre una caída mientras andaba en bicicleta, presentando una fractura de antebrazo en tallo verde, la que es manejada ortopédicamente con un yeso braquiopalmar. Sin embargo 2 horas después evoluciona con aumento del dolor, especialmente a la movilización pasiva de los dedos. El diagnóstico más probable es:

a. Trombosis venosa profunda
b. Necrosis avascular
c. Síndrome de túnel carpiano
d. Rotura de la arteria braquial
e. Síndrome compartimental

Respuesta correcta: e. Síndrome compartimental

Explicación: Es un síndrome compartimental clásico. La primera medida será quitar el yeso, elevar la extremidad e indicar movimientos. Si no responde rápidamente, se debe proceder a la fasciotomía amplia.

Fuente: Traumatología pediátrica P22

22. Escolar de 12 años, deportista, consulta por dolor en ambas rodillas desde hace dos semanas. Hay sensibilidad a la palpación de la tuberosidad anterior en ambas tibias. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Osgood-Schlatter.
b. Dolor de crecimiento.
c. Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes.
d. Artritis reumatoídea juvenil.
e. Artritis reactiva.

Respuesta correcta: a. Enfermedad de Osgood-Schlatter.

Explicación: Es una enfermedas de Osgood Schlatter clásica. El “dolor de crecimiento” sí existe, aunque no necesariamente se debe al crecimiento: se caracteriza por dolores nocturnos en las extremidades inferiores, que desaparecen en el día. Pueden despertar al niño y se manejan con masajes leves en los músculos adoloridos.

Fuente: Traumatología pediátrica P23

23. Una recién nacida de 15 días de vida, con antecedente de parto por cesárea por presentación podálica presenta signo de Ortolani y Barlow positivo en el examen de control. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución y solicitar radiografía de pelvis al cumplir los 3 meses de edad
b. Indicar uso de doble pañal
c. Solicitar radiografía AP de pelvis
d. Solicitar ecografía de caderas
e. Derivar para resolución quirúrgica

Respuesta correcta: d. Solicitar ecografía de caderas

Explicación: Antes de los 3 meses, la radiografía tiene mal rendimiento para la displasia de caderas, por lo que la ecografía es el examen de elección. De hecho, en países en desarrollo suele ser el examen de elección para el screening de todo neonato (en Chile es la radiografía AP de pelvis a los 3 meses).

Fuente: Traumatología pediátrica P24

24. La conducta más adecuada frente a un niño asintomático, con pie plano, cuyo arco plantar aparece al hiperextender el primer ortejo, es:

a. Observar
b. Indicar uso de plantillas
c. Indicar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura plantar
d. Solicitar TAC de pie
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: a. Observar

Explicación: EL pie plano flexible se puede observar y solo se trata con un calzado adecuado o plantillas si es que se asocia a dolor. El pie plano rígido o con otras alteraciones asociadas sí se deriva al especialista.

Fuente: Traumatología pediátrica P25

25. Una niña de 12 años, asintomática, presenta un test de Adams que muestra cierto grado de asimetría en el troco y se visualiza una giba costal leve. Se solicitan radiografías de columna que muestran una escoliosis con desviación de 10%. La conducta más adecuada es:

a. Indicar ejercicios posturales y observar evolución
b. Solicitar TAC de columna
c. Indicar uso de corsé dorsolumbar
d. indicar vendaje en ocho
e. Resolución quirúrgica

Respuesta correcta: a. Indicar ejercicios posturales y observar evolución

Explicación: Hasta 20° se puede observar la escoliosis. Entre 20° y 50° se indica corsé. Sobre 50° se suele operar (desde 45° se evalúa).

Fuente: Traumatología pediátrica P26

26. Un niño de 6 años, con una talla más corta que la que debería corresponder a su edad, aqueja dolores moderados de su cadera derecha y claudicación al correr. A la exploración se aprecia una discreta atrofia del muslo y existe una limitación de los movimientos de rotación interna y abducción. El diagnóstico de sospecha es:

a. Sinovitis transitoria de la cadera
b. Artritis séptica
c. Displasia de cadera
d. Enfermedad de Perthes
e. Epifisiolisis de la cabeza femoral

Respuesta correcta: d. Enfermedad de Perthes

Explicación: Por la edad (5 a 10 años, pero con rango entre los 3 y 12 años) parece una enfermedad de Perthes clásica. El primer examen suele ser la radiografía, aunque la RMN es el con mejor rendimiento (igual que en la necrosis avascular de la cabeza femoral de los adultos). El tratamiento va desde el reposo hasta la cirugía, según el daño y evolución que tenga.

Es una enfermedad de Legg Calvé Perthes clásica, que se caracteriza por la necrosis de la cabeza femoral. Suele presentarse con claudicación y cojera en niños de 5 a 10 años (rango de 3 a 12 años), que persiste en el tiempo y puede agravarse. Se asocia a talla baja. Su estudio comienza con radiografías de caderas o de pelvis, para comparar ambas caderas, aunque en algunos casos se requiere de RMN (especialmente en las etapas iniciales). Su tratamiento es variable, dependiendo de la severidad, yendo desde la observación y reposo, hasta la cirugía con prótesis de cadera, en los casos más severos. La principal diferencia clínica con la sinovitis transitoria es que esta última suele durar una o máximo 2 semanas y luego mejora, además, su radiografía es normal. La epifisiolisis de la cabeza femoral puede presentarse de manera similar, pero suele ocurrir en niños mayores, de 12 a 15 años.

Fuente: Traumatología pediátrica P27 · Reumatología e Inmunología pediátrica P6

27. Un niño de 2 años, que luego de levantarlo bruscamente, traccionando la mano izquierda, presenta inmovilidad de dicha extremidad. Al examen presenta codo derecho extendido en pronación y llora al movilizarlo. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión del nervio mediano
b. Lesión del plexo braquial
c. Fractura de antebrazo
d. Pronación dolorosa
e. Lesión del nervio radial

Respuesta correcta: d. Pronación dolorosa

Explicación: Es una pronación dolorosa clásica, también llamada “codo de niñera”. Su diagnóstico es clínico y el tratamiento consiste en reposicionar la cúpula radial luxada, con maniobras de flexoextensión y pronosupinación del antebrazo.

Fuente: Traumatología pediátrica P29

28. Un adolescente de 13 años, con sobrepeso consulta por dolor inguinal derecho en relación a la marcha, que le hace cojear. Al examen físico el dolor se reproduce con la abducción y rotación de la cadera derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Perthes
b. Sarcoma de Ewing
c. Epifisiolisis de la cabeza femoral
d. Sinovitis transitoria de la cadera
e. Artritis séptica

Respuesta correcta: c. Epifisiolisis de la cabeza femoral

Explicación: Por la edad (13 a 15 años), lo más probable es que se trate de una epifisiolisis de la cabeza femoral. Se diagnostica con radiografía que muestra el signo del “helado caído”. Se trata con cirugía.

Fuente: Traumatología pediátrica P30

Intoxicaciones y misceláneos (5)

1. Un recién nacido de 5 días de vida presenta varias pústulas pequeñas, con base eritematosa en la cara, el tronco y las extremidades. Se aprecia de buen aspecto y el resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar aciclovir
c. Solicitar hemograma, urocultivo, sedimento de orina, radiografía de tórax, hemocultivos, punción lumbar e iniciar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
d. Solicitar VDRL
e. Iniciar paracetamol

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Tiene un eritema tóxico clásico, que es una de las erupciones normales del recién nacido y que no tiene ninguna repercusión y desaparece espontáneamente en unos días. Generalmente tiene pústulas o pápulas sobre una base eritematosa y respeta palmas y plantas. No tiene fiebre.

Fuente: Cuestionario 3.1 P16

2. Un niño ingiere muchas pastillas de paracetamol, por accidente. ¿Qué tratamiento evita el desarrollo de insuficiencia hepática?

a. Carbón activado
b. Corticoides
c. N-acetil cisteína
d. Bicarbonato
e. Suero fisiológico

Respuesta correcta: c. N-acetil cisteína

Explicación: El antídoto de la intoxicación por paracetamol es la N-acetilcisteína, ajustada por niveles plasmáticos de paracetamol.

Fuente: Digestivo pediátrico P6

3. Un paciente 4 años, ingresa en sopor profundo, luego de una intoxicación accidental con altas dosis de aspirina. Se solicitan gases arteriales con el siguiente resultado: pH: 7.28 pO2: 106 mmHg. pCO2: 12 mmHg. HCO3: 14 mEq/l. El diagnóstico ácido base es:

a. Acidosis respiratoria aislada
b. Acidosis metabólica aislada
c. Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica
d. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria
e. Acidosis metabólica y respiratoria

Respuesta correcta: d. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria

Explicación: Revisar resumen ácido base (respiratorio). El CO2 está demasiado bajo para ser un trastorno metabólico puro. Además, la intoxicación con salicilatos suele dar acidosis metabólica con alcalosis respiratoria.

Fuente: Nefrología pediátrica P4

4. Un niño de 3 años consume una sustancia desconocida, evolucionando con sialorrea, vómitos, temblor de extremidades y desorientación. Al examen físico se aprecia aumento de los ruidos hidroaéreos, miosis y temblor de extremidades superiores. ¿Qué sustancia es la responsable?

a. Anticolinérgicos
b. Organofosforados
c. Agonistas adrenérgicos
d. Opiáceos
e. Benzodiacepinas

Respuesta correcta: b. Organofosforados

Explicación: Tiene un síndrome colinérgico (revisar intoxicaciones) y el cuadro clásico de la intoxicación por organofosforados (insecticida). El antídoto de los organofosforados es la atropina.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P8

5. Un niño consume, accidentalmente, una sustancia desconocida, evolucionando con compromiso de consciencia y depresión respiratoria. Al examen físico presenta presión arterial y pulso normales, con frecuencia respiratoria de 6 rpm, sopor profundo y presencia de miosis bilateral y marcada, sin signos focales en el examen neurológico. ¿Qué sustancia fue consumida con mayor probabilidad?

a. Anticolinérgicos
b. Organofosforados
c. Benzodiacepinas
d. Opiáceos
e. Agonistas adrenérgicos

Respuesta correcta: d. Opiáceos

Explicación: Tiene un síndrome opiáceo. La principal diferencia con el síndrome narcótico por benzodiacepinas es que los opiáceos producen miosis puntiforme.

Fuente: Neuropsiquiatría pediátrica P20